

Ergänzende Versicherungsbedingungen für die kurzfristige Krankenversicherung für Aufenthalte in Österreich und im Schengenraum - Tarif 10RB (EB_10RB_17)

Vertragspartner

Diese Vertragsgrundlagen gelten für Verträge mit der Generali Versicherung AG, 1010 Wien, Landskrongasse 1-3.

Aufsichtsbehörde

Finanzmarktaufsicht, 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5



§ 1

Entfall/Abweichung von Bestimmungen der AVBKV(G) 2017

- (1) Folgende Bestimmungen der
- Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeldversicherung (AVBKV 2017) bzw.
 - Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Gruppenkrankenversicherung von Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeldversicherung (AVBKVG 2017)
- gelten als nicht vereinbart:
1. § 4 - Wartezeiten
 2. § 5 - Art und Umfang des Versicherungsschutzes (Abs. 1, Satz 2)
 3. § 6 - Einschränkung des Versicherungsschutzes (Abs. 1, 2 und 3)
Ungeachtet der Leistungspflicht für
 - Heilbehandlungen, die vor Vertragsbeginn begonnen haben (§ 6, Abs. 1) und
 - Krankheiten und Unfallfolgen, die vor Vertragsbeginn entstanden sind, aber erst nach Vertragsbeginn zu einer Heilbehandlung führen (§ 6, Abs. 2),ist der Versicherer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn eine schuldhaft Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht gemäß der §§ 16 ff VersVG vorliegt.
 4. § 17 - Änderung der Prämie und des Versicherungsschutzes
 5. § 18 - Gewinnbeteiligung / Prämienrückvergütung
- (2) Abweichend von § 8 AVBKV(G) 2017 gilt vereinbart:
Ist der Versicherte nach Eintritt eines Versicherungsfalles über das Ende der vereinbarten Vertragsdauer hinaus aus medizinischen Gründen nicht reisefähig, so verlängert sich der Versicherungsschutz bis zur Erlangung der Reisefähigkeit.

Leistungen für ambulante Heilbehandlung

§ 2

Ärztliche Heilbehandlung

- (1) Die Kosten für von Ärzten durchgeführte schulmedizinische Heilbehandlungen sowie Eltern-Kind-Pass-Untersuchungen werden bis zum tariflichen Höchstbetrag erstattet.
- (2) Für ärztlich empfohlene Vorsorgeuntersuchungen (auch Pränataldiagnostik) werden Leistungen bis zum im Tarif angeführten Betrag insoweit erbracht, als sie von einem Arzt durchgeführt werden.

Vorsorgeuntersuchungen sind Untersuchungen zur Früherkennung chronischer Erkrankungen, wie z.B. maligner Prozesse (Krebs), Erkrankungen des Herzens und des Kreislaufes oder des Stoffwechsels, unter Anwendung von nach dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Wissenschaft zweckmäßigen und ausreichenden Maßnahmen. Ebenfalls als Vorsorgeuntersuchung anzusehen ist die einmalige Feststellung der für die erste Hilfe nach akuten Erkrankungen oder Unfällen bzw. zur Schockbekämpfung wesentlichen Daten, wie Blutgruppe, Rhesusfaktor, Allergien usw. Nicht als Vorsorgeuntersuchung gelten Schwangerschaftstests.

§ 3

Ämbulante Operationen

Die Kosten von ambulanten Operationen inkl. Kosten der Anästhesie werden gemäß § 5 A) Abs. 1 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 erstattet, wenn diese Operationen in der Ordination eines Arztes oder in der Ambulanz eines Krankenhauses vorgenommen werden.

Die Kosten refraktiver Augen Chirurgie werden bis zum Höchstbetrag für Heilbehelfe ersetzt (siehe unten § 4).

§ 4

Heilbehelfe

- (1) Leistung für Sehbehelfe:
Im Rahmen des Höchstbetrags für Heilbehelfe hat der Versicherte wahlweise Anspruch auf Kostenersatz für eine Brille, Kontaktlinsen oder refraktive Augen Chirurgie (z.B. Sehstärkenkorrektur mittels Laserbehandlung der Hornhaut oder durch Implantation einer zusätzlichen oder Ersatz der körpereigenen Linse).
- (2) Abweichend von § 5 B) Abs. 9 AVBKV 2017 / AVBKV 2017 erfolgt auch Kostenersatz für ärztlich verordnete Heilbehelfe (Hilfsmittel) zur Versorgung künstlicher Darm- und Blasenaustritte sowie zur Versorgung bei Inkontinenz.

§ 5

Zahnbehandlung, Zahnersatz und Zahnvorsorge

- (1) Leistungen für konservierende Zahnbehandlung werden erbracht für Zahnextraktionen, Herstellung von Plomben (ausgenommen Edelmetall- und Keramikinlays), Wurzelbehandlungen und kieferorthopädische Behandlungen.
- (2) Leistungen für prothetische Zahnbehandlung werden erbracht für Kronen, Stiftzähne, Brücken, Implantate, Prothesen, Edelmetall- und Keramikinlays sowie Zahn- und Kieferregulierungen.
- (3) Vorsorgemaßnahmen zur Zahnerhaltung oder Zahnpflege werden bezahlt für Mundhygiene (Zahntaschenreinigung, Zahnsteinentfernung, Fluoridierung), Fissurenversiegelung und Kontrolluntersuchungen.
- (4) Kostenersatz aus der Tarifleistung "Ärztliche Heilbehandlung" wird erbracht für:
 - In Abs. 1 angeführte Leistungen, sofern eine Fokalfokale Infektion als Ursache einer Erkrankung (z.B. Myokarditis, rheumatische Beschwerden) anzusehen ist
 - Die Behandlung von Mund- und Kieferkrankheiten wie Stomatitis, Gingivitis, Kieferabszessen sowie für die Exstirpation von Zysten, Wurzelspitzenresektionen und Behandlungen von Kieferbrüchen

§ 6

Medizinische Hauskrankenpflege

Unter medizinischer Hauskrankenpflege sind qualifizierte Pflegeleistungen (Injektionen, Sondenernährung, Wundversorgung usw.) zu verstehen, die auf ärztliche Anordnung durch diplomierte KrankenpflegerInnen erbracht werden.

Kein Kostenersatz erfolgt für eine allfällige Grundpflege (z.B. Haut-, Haar- und Zahnpflege) sowie die hauswirtschaftliche Versorgung der versicherten Person.

§ 7

Tele-Medizinische Beratung und Betreuung

Die Kosten medizinischer Beratung und Betreuung im Internet oder per Telefon werden insoweit erstattet, als die Leistung von einem Arzt erbracht wird, nachdem dieser die Behandlung des Versicherten in seiner Ordination oder im Rahmen eines Hausbesuches begonnen hat.

Abweichend von § 5 B) Abs. 5 AVBKV 2017 / AVBKV 2017 leistet der Versicherer in diesem Fall auch Kostenersatz für Leistungen von Ärzten oder Zahnärzten/Dentisten, die nicht unmittelbar am Versicherten erbracht werden.

Dabei gelten insbesondere folgende Leistungen als versichert:

- Mitteilung eines Laborergebnisses, eines histologischen oder radiologischen Befundes
- Beratung des Patienten zur Dosisanpassung eines verordneten Medikaments
- Entscheidung aufgrund vom Patienten geschilderter Symptome, ob ein Termin in der Ordination überhaupt nötig und wie dringlich dieser ist

Kein Versicherungsschutz besteht für Kosten von:

- Mitgliedschaften in Online-Foren, Plattformen von Selbsthilfegruppen oder Informationsportalen zu medizinischen Themen
- Vorsorge- und Laboruntersuchungen, die aufgrund eingesandter Körperproben vorgenommen werden (z.B. Allergietest, DNA Analyse zu Risikofaktoren)

§ 8

Psychotherapeutische Behandlungen

Leistungen für Psychotherapie werden erbracht, sofern die Behandlungen durch in Österreich zugelassene Psychologen

und Psychotherapeuten durchgeführt werden.

§ 9

Transportkosten

- (1) Abweichend von § 5 B) Abs. 7 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 werden die Kosten für notwendige Fahrten der versicherten Person zu einer ärztlichen Behandlung bis zu dem im Leistungstarif vorgesehenen Höchstbetrag je Transport ersetzt. Als notwendige Fahrten gelten die Fahrten mit Krankenwagen, Bahn oder Autotaxi zur Erstversorgung, im Notfall oder nach ärztlicher Verordnung.
- (2) Die Kosten eines medizinisch notwendigen Transports mittels Hubschrauber werden ersetzt, wenn und soweit der Transport mit den in Abs. 1 genannten Transportmitteln aus medizinischen Gründen nicht möglich ist und kein Kostenersatz aus einem Tarif für stationäre Heilbehandlung erfolgt.

Leistungen für stationäre Heilbehandlung

§ 10

Kostenübernahme in Krankenanstalten

(1) Kostenübernahme in Öffentlichen Krankenhäusern in Österreich

Nimmt der Versicherte eine Behandlung in der Allgemeinen Gebührenklasse eines Öffentlichen Krankenhauses in Österreich in Anspruch, so werden die vereinbarten Kosten anstelle der tariflichen Leistungen in voller Höhe übernommen und mit dem Krankenhaus direkt verrechnet.

(2) Kostenübernahme im Schengenraum

Nimmt der Versicherte eine Behandlung in der Allgemeinen Gebührenklasse eines Öffentlichen Krankenhauses im Schengenraum in Anspruch, so werden die Kosten der Pflege und Verpflegung, von Operationen und Behandlung anstelle der tariflichen Leistungen in voller Höhe übernommen.

Der Schengenraum umfasst - neben Österreich - folgende Länder:

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik und Ungarn.

Diese allgemeine Kostendeckungszusage kann im Sinn des § 178c VersVG vom Versicherer in geschriebener Form widerrufen werden. Der Widerruf wird nach Ablauf von drei Wochen wirksam.

§ 11

Direktverrechnung

Sofern eine Vereinbarung mit dem Leistungsträger (Krankenhaus, Arzt) besteht, erfolgt auf Grundlage dieser Vereinbarung die direkte Verrechnung der Kosten und Honorare zwischen dem Versicherer und dem Leistungserbringer.

Weitere Grundlage ist eine vom Versicherten vor Antritt der Heilbehandlung anzufordernde Kostenübernahmeerklärung. Die Art der Erkrankung und die Notwendigkeit der Heilbehandlung sind in dieser Anforderung medizinisch nachzuweisen. Lässt die Dringlichkeit der Heilbehandlung eine vorhergehende Anfrage nicht zu, ist diese spätestens drei Arbeitstage ab Antritt der Heilbehandlung nachzureichen.

Der Versicherte hat der Ermittlung von zum Zwecke der Direktverrechnung erforderlichen Daten zuzustimmen.

Wird die Zustimmungserklärung verweigert, widerrufen oder verspätet erteilt und stellt der Leistungserbringer Kosten und Honorare dem Versicherten in Rechnung, ist der Versicherer diesem gegenüber nur in dem in der Vereinbarung über die Direktverrechnung festgelegten Ausmaß zur Leistung verpflichtet.

§ 12

Tagesklinische Behandlung in Krankenhäusern

Tagesklinische Heilbehandlungen sind Heilbehandlungen in einem Krankenhaus, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Art der Heilbehandlung erfordert üblicherweise einen Aufenthalt von mindestens 24 Stunden,
- der Versicherte wird noch am Tag der Aufnahme aus dem Krankenhaus entlassen, und

- für die Heilbehandlung wird die Infrastruktur einer Abteilung des Krankenhauses in Anspruch genommen (z.B. Aufnahme in der Bettenstation, Benutzung eines Operationssaales).
- Heilbehandlungen und Operationen in der Ambulanz eines Krankenhauses stellen jedenfalls keine tagesklinischen Behandlungen dar.

§ 13

Akut-Geriatrie und Remobilisation

Für medizinisch notwendige stationäre Akut-Geriatrie und Remobilisation im Anschluss an eine stationäre Heilbehandlung wird eine Leistung für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr erbracht.

Erfolgen Akut-Geriatrie bzw. Remobilisation in einem Krankenhaus (Abteilung), mit dem der Versicherer dafür einen Vertrag abgeschlossen hat, werden die vereinbarten Kosten mit dem Vertragskrankenhaus gemäß § 12 direkt verrechnet. In allen übrigen Fällen wird das dafür im Leistungstarif angeführte Ersatztagegeld ausbezahlt.

§ 14

Hospiz, Palliativstation

Für medizinisch notwendige stationäre Aufenthalte in einem Hospiz oder einer Palliativstation eines Krankenhauses wird eine Leistung für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr erbracht.

Erfolgt der Aufenthalt in einer Einrichtung, mit der der Versicherer dafür einen Vertrag abgeschlossen hat, werden die vereinbarten Kosten mit der Vertragseinrichtung gemäß § 12 direkt verrechnet. In allen übrigen Fällen wird das dafür im Leistungstarif angeführte Ersatztagegeld ausbezahlt.

§ 15

Tarifliche Leistungen

(1) Umfang einzelner tariflicher Leistungen

1. Tageskosten

umfassen die zu bezahlenden Kosten für Verpflegs- und Krankenhausgebühren (für die Unterbringung, Pflege und Verpflegung).

2. Behandlungshonorar

umfasst alle ärztlichen Honorare (auch Honorare für Hebammen) ausgenommen die Honorare für technische Untersuchungen wie bildgebende Verfahren, Labor, Nuklearmedizin etc.

Soweit Kosten aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Vereinbarungen mit dem Versicherer betraglich geregelt sind, ist der Versicherer zum Ersatz darüber hinausgehender Kosten (z.B. Sonderhonorare der Vorstände von Universitätskliniken gemäß § 46 KaKuG und ausführende Landesgesetze) nicht verpflichtet.

3. Technische Leistungen

umfassen die Honorare für technische Untersuchungen wie bildgebende Verfahren, Labor, Nuklearmedizin etc. und sämtlichen Sachaufwand einschließlich der Kosten für Benützung des Operationssaales, der Arzneimittel (Heilmittel) und Heilbehelfe.

(2) Stationäre Heilbehandlung in Krankenhäusern

Bei stationärer Heilbehandlung in nicht öffentlichen Krankenhäusern in Österreich oder dem Schengenraum, werden für die Kosten des Aufenthaltes die Leistungen gemäß der für

- Tageskosten,
- Behandlungshonorar,
- Technische Leistungen und
- Summenleistung

festgesetzten Beträgen erbracht.

(3) Tagesklinische Heilbehandlung in Krankenhäusern

Für tagesklinische Heilbehandlungen in Krankenhäusern, mit denen dafür keine vertraglichen Vereinbarungen über die Kostenübernahme bestehen, werden für die Kosten die folgenden tariflichen Leistungen wie für eine eintägige stationäre Heilbehandlung erbracht:

- Tageskosten,
- Behandlungshonorar,
- Technische Leistungen und

- Summenleistung.

Leistungen bei Kur, Rehabilitation und Anschlussheilverfahren

§ 16

Kuraufenthalt, Rehabilitation, Anschlussheilverfahren

- (1) Die Tarifleistungen "Kostenersatz für Kuraufenthalte" (auch in Einrichtungen für Psychosomatik und Zentren für seelische Gesundheit) und "Kostenersatz für Rehabilitation", das sind die Kosten der Unterbringung und Verpflegung und der ärztlich verordneten Behandlungen, werden erbracht, wenn der Aufenthalt vor Antritt durch den Versicherer genehmigt wurde. Grundlage für die Genehmigung ist, dass im Rahmen des Krankheitsgeschehens eine für die medizinisch indizierte Behandlung geeignete Einrichtung aufgesucht wird.
Der Antrag auf Erstattung der Kosten ist entsprechend medizinisch zu begründen. Der Versicherer kann vor Erledigung des Antrages auf seine Kosten die Untersuchung des Antragstellers durch einen von ihm bestimmten Arzt verlangen. Er hat binnen 4 Wochen nach Eingang des Antrages oder des Untersuchungsergebnisses Stellung zu nehmen, ansonsten gilt der Antrag als bewilligt.
Für ambulante Kuren, Rehabilitationen und Anschlussheilverfahren erfolgt keine Bewilligung.
- (2) Kostenersatz für Kuraufenthalte wird für längstens 28 Tage (für Kur- oder Erholungsaufenthalte in einer Einrichtung für Psychosomatik und einem Zentrum für seelische Gesundheit für längstens 42 Tage) bezahlt.
Kostenersatz für Rehabilitation wird für längstens 90 Tage bezahlt.

GesundheitsCoaching

§ 17

GesundheitsCoaching

- (1) **Informationen über medizinische Einrichtungen und Gesundheitsdienste,**
werden bei einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung zu folgenden Themen erteilt:
 - Behandler in Österreich (zur selbständigen Berufsausübung zugelassene Ärzte, Zahnärzte, Ärzte für Ganzheits- und Alternativmedizin, Psychotherapeuten)
 - Medizinische Einrichtungen weltweit
 - Ganzheits- und Alternativmedizin in Österreich
 - Transporteinrichtungen in Österreich
1. Informationen zu medizinischen Einrichtungen außerhalb Österreichs
werden erteilt, wenn für die spezielle medizinische Behandlung kein geeigneter Arzt bzw. keine geeignete medizinische Einrichtung in Österreich vorhanden ist oder ärztliche Hilfe während eines Auslandsaufenthaltes erforderlich ist.
2. Informationen zu Transporteinrichtungen in Österreich
werden erteilt, wenn der Versicherte aufgrund der Art der Erkrankung bzw. durch die Unfallfolgen oder wegen der ärztlich angeordneten Verhaltensmaßregeln außerstande ist, den Arzt oder die medizinische Einrichtung aus eigener Kraft aufzusuchen.
- (2) **Hilfe im Notfall**

Ein medizinischer Notfall liegt vor, wenn der Versicherte von einer unmittelbaren Gefahr (z.B. akute Erkrankung, Unfall, drohende Einwirkung schädigender Stoffe) für Leben, körperliche Unversehrtheit oder Gesundheit bedroht ist.

In allen medizinischen Notfällen ist der Versicherer rund um die Uhr erreichbar und
 - unterstützt durch Herstellung der Verbindung und Organisation des Transports zu allen Notfalleinrichtungen in Österreich:
 - Nacht- und Wochenenddienste durch Ärzte für Allgemeinmedizin und Zahnärzte bzw. Apotheken, nächstgelegenes geeignetes Krankenhaus,
 - sonstige Notdienste (z.B. Rotes Kreuz, Vergiftungszentrale, psychosoziale Dienste)
 - oder
 - veranlasst - abhängig vom Gesundheitszustand des Versicherten - einen zeitnahen Rückruf von einem Arzt zur telefonischen Abklärung und Beratung über weitere Maßnahmen.
- (3) **Herstellung der Verbindung**
erfolgt nur auf Wunsch des Versicherten.

Der Versicherer stellt nur den erstmaligen Kontakt her, in weiterer Folge wendet sich der Versicherte selbst an den Arzt/Therapeuten, die medizinische Einrichtung oder den Gesundheitsdienst.

(4) **Haftungsausschluss**

Durch die Informationsleistung bzw. Herstellung der Verbindung gewährleistet der Versicherer nicht die Verfügbarkeit der Leistungen des betreffenden Arztes/Therapeuten, Gesundheitsdienstes oder der medizinischen Einrichtung in einem bestimmten Umfang oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes.

Ergänzende Versicherungsbedingungen für die kurzfristige Krankenversicherung für Aufenthalte in Österreich und im Schengenraum - Tarif 11RB (EB_11RB_17)

Vertragspartner

Diese Vertragsgrundlagen gelten für Verträge mit der Generali Versicherung AG, 1010 Wien, Landskrongasse 1-3.

Aufsichtsbehörde

Finanzmarktaufsicht, 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5



§ 1

Entfall/Abweichung von Bestimmungen der AVBKV(G) 2017

- (1) Folgende Bestimmungen der
- Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeldversicherung (AVBKV 2017) bzw.
 - Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Gruppenkrankenversicherung von Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeldversicherung (AVBKVG 2017)
- gelten als nicht vereinbart:
1. § 4 - Wartezeiten
 2. § 5 - Art und Umfang des Versicherungsschutzes (Abs. 1, Satz 2)
 3. § 6 - Einschränkung des Versicherungsschutzes (Abs. 1, 2 und 3)
Ungeachtet der Leistungspflicht für
 - Heilbehandlungen, die vor Vertragsbeginn begonnen haben (§ 6, Abs. 1) und
 - Krankheiten und Unfallfolgen, die vor Vertragsbeginn entstanden sind, aber erst nach Vertragsbeginn zu einer Heilbehandlung führen (§ 6, Abs. 2),ist der Versicherer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn eine schuldhafte Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht gemäß der §§ 16 ff VersVG vorliegt.
 4. § 17 - Änderung der Prämie und des Versicherungsschutzes
 5. § 18 - Gewinnbeteiligung / Prämienrückvergütung
- (2) Abweichend von § 8 AVBKV(G) 2017 gilt vereinbart:
Ist der Versicherte nach Eintritt eines Versicherungsfalles über das Ende der vereinbarten Vertragsdauer hinaus aus medizinischen Gründen nicht reisefähig, so verlängert sich der Versicherungsschutz bis zur Erlangung der Reisefähigkeit.

Leistungen für ambulante Heilbehandlung

§ 2

Ärztliche Heilbehandlung

- (1) Die Kosten für von Ärzten durchgeführte schulmedizinische Heilbehandlungen sowie Eltern-Kind-Pass-Untersuchungen werden bis zum tariflichen Höchstbetrag erstattet.
- (2) Für ärztlich empfohlene Vorsorgeuntersuchungen (auch Pränataldiagnostik) werden Leistungen bis zum im Tarif angeführten Betrag insoweit erbracht, als sie von einem Arzt durchgeführt werden.

Vorsorgeuntersuchungen sind Untersuchungen zur Früherkennung chronischer Erkrankungen, wie z.B. maligner Prozesse (Krebs), Erkrankungen des Herzens und des Kreislaufes oder des Stoffwechsels, unter Anwendung von nach dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Wissenschaft zweckmäßigen und ausreichenden Maßnahmen. Ebenfalls als Vorsorgeuntersuchung anzusehen ist die einmalige Feststellung der für die erste Hilfe nach akuten Erkrankungen oder Unfällen bzw. zur Schockbekämpfung wesentlichen Daten, wie Blutgruppe, Rhesusfaktor, Allergien usw. Nicht als Vorsorgeuntersuchung gelten Schwangerschaftstests.

§ 3

Ämbulante Operationen

Die Kosten von ambulanten Operationen inkl. Kosten der Anästhesie werden gemäß § 5 A) Abs. 1 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 erstattet, wenn diese Operationen in der Ordination eines Arztes oder in der Ambulanz eines Krankenhauses vorgenommen werden.

Die Kosten refraktiver Augen Chirurgie werden bis zum Höchstbetrag für Heilbehelfe ersetzt (siehe unten § 4).

§ 4

Heilbehelfe

- (1) Leistung für Sehbehelfe:
Im Rahmen des Höchstbetrags für Heilbehelfe hat der Versicherte wahlweise Anspruch auf Kostenersatz für eine Brille, Kontaktlinsen oder refraktive Augen Chirurgie (z.B. Sehstärkenkorrektur mittels Laserbehandlung der Hornhaut oder durch Implantation einer zusätzlichen oder Ersatz der körpereigenen Linse).
- (2) Abweichend von § 5 B) Abs. 9 AVBKV 2017 / AVBKV 2017 erfolgt auch Kostenersatz für ärztlich verordnete Heilbehelfe (Hilfsmittel) zur Versorgung künstlicher Darm- und Blasenaustritte sowie zur Versorgung bei Inkontinenz.

§ 5

Zahnbehandlung, Zahnersatz und Zahnvorsorge

- (1) Leistungen für konservierende Zahnbehandlung werden erbracht für Zahnextraktionen, Herstellung von Plomben (ausgenommen Edelmetall- und Keramikinlays), Wurzelbehandlungen und kieferorthopädische Behandlungen.
- (2) Leistungen für prothetische Zahnbehandlung werden erbracht für Kronen, Stiftzähne, Brücken, Implantate, Prothesen, Edelmetall- und Keramikinlays sowie Zahn- und Kieferregulierungen.
- (3) Vorsorgemaßnahmen zur Zahnerhaltung oder Zahnpflege werden bezahlt für Mundhygiene (Zahntaschenreinigung, Zahnsteinentfernung, Fluoridierung), Fissurenversiegelung und Kontrolluntersuchungen.
- (4) Kostenersatz aus der Tarifleistung "Ärztliche Heilbehandlung" wird erbracht für:
- In Abs. 1 angeführte Leistungen, sofern eine Fokalinfection als Ursache einer Erkrankung (z.B. Myokarditis, rheumatische Beschwerden) anzusehen ist
 - Die Behandlung von Mund- und Kieferkrankheiten wie Stomatitis, Gingivitis, Kiefereiterungen sowie für die Exstirpation von Zysten, Wurzelspitzenresektionen und Behandlungen von Kieferbrüchen

§ 6

Medizinische Hauskrankenpflege

Unter medizinischer Hauskrankenpflege sind qualifizierte Pflegeleistungen (Injektionen, Sondenernährung, Wundversorgung usw.) zu verstehen, die auf ärztliche Anordnung durch diplomierte KrankenpflegerInnen erbracht werden.

Kein Kostenersatz erfolgt für eine allfällige Grundpflege (z.B. Haut-, Haar- und Zahnpflege) sowie die hauswirtschaftliche Versorgung der versicherten Person.

§ 7

Tele-Medizinische Beratung und Betreuung

Die Kosten medizinischer Beratung und Betreuung im Internet oder per Telefon werden insoweit erstattet, als die Leistung von einem Arzt erbracht wird, nachdem dieser die Behandlung des Versicherten in seiner Ordination oder im Rahmen eines Hausbesuches begonnen hat.

Abweichend von § 5 B) Abs. 5 AVBKV 2017 / AVBKV 2017 leistet der Versicherer in diesem Fall auch Kostenersatz für Leistungen von Ärzten oder Zahnärzten/Dentisten, die nicht unmittelbar am Versicherten erbracht werden.

Dabei gelten insbesondere folgende Leistungen als versichert:

- Mitteilung eines Laborergebnisses, eines histologischen oder radiologischen Befundes
- Beratung des Patienten zur Dosisanpassung eines verordneten Medikaments
- Entscheidung aufgrund vom Patienten geschilderter Symptome, ob ein Termin in der Ordination überhaupt nötig und wie dringlich dieser ist

Kein Versicherungsschutz besteht für Kosten von:

- Mitgliedschaften in Online-Foren, Plattformen von Selbsthilfegruppen oder Informationsportalen zu medizinischen Themen
- Vorsorge- und Laboruntersuchungen, die aufgrund eingesandter Körperproben vorgenommen werden (z.B. Allergietest, DNA Analyse zu Risikofaktoren)

§ 8

Psychotherapeutische Behandlungen

Leistungen für Psychotherapie werden erbracht, sofern die Behandlungen durch in Österreich zugelassene Psychologen

und Psychotherapeuten durchgeführt werden.

§ 9

Transportkosten

- (1) Abweichend von § 5 B) Abs. 7 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 werden die Kosten für notwendige Fahrten der versicherten Person zu einer ärztlichen Behandlung bis zu dem im Leistungstarif vorgesehenen Höchstbetrag je Transport ersetzt. Als notwendige Fahrten gelten die Fahrten mit Krankenwagen, Bahn oder Autotaxi zur Erstversorgung, im Notfall oder nach ärztlicher Verordnung.
- (2) Die Kosten eines medizinisch notwendigen Transports mittels Hubschrauber werden ersetzt, wenn und soweit der Transport mit den in Abs. 1 genannten Transportmitteln aus medizinischen Gründen nicht möglich ist und kein Kostenersatz aus einem Tarif für stationäre Heilbehandlung erfolgt.

Leistungen für stationäre Heilbehandlung

§ 10

Kostenübernahme in Krankenanstalten

(1) Kostenübernahme in Öffentlichen Krankenhäusern in Österreich

Nimmt der Versicherte eine Behandlung in der Allgemeinen Gebührenklasse eines Öffentlichen Krankenhauses in Österreich in Anspruch, so werden die vereinbarten Kosten anstelle der tariflichen Leistungen in voller Höhe übernommen und mit dem Krankenhaus direkt verrechnet.

(2) Kostenübernahme im Schengenraum

Nimmt der Versicherte eine Behandlung in der Allgemeinen Gebührenklasse eines Öffentlichen Krankenhauses im Schengenraum in Anspruch, so werden die Kosten der Pflege und Verpflegung, von Operationen und Behandlung anstelle der tariflichen Leistungen in voller Höhe übernommen.

Der Schengenraum umfasst - neben Österreich - folgende Länder:

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik und Ungarn.

Diese allgemeine Kostendeckungszusage kann im Sinn des § 178c VersVG vom Versicherer in geschriebener Form widerrufen werden. Der Widerruf wird nach Ablauf von drei Wochen wirksam.

§ 11

Direktverrechnung

Sofern eine Vereinbarung mit dem Leistungsträger (Krankenhaus, Arzt) besteht, erfolgt auf Grundlage dieser Vereinbarung die direkte Verrechnung der Kosten und Honorare zwischen dem Versicherer und dem Leistungserbringer.

Weitere Grundlage ist eine vom Versicherten vor Antritt der Heilbehandlung anzufordernde Kostenübernahmeerklärung. Die Art der Erkrankung und die Notwendigkeit der Heilbehandlung sind in dieser Anforderung medizinisch nachzuweisen. Lässt die Dringlichkeit der Heilbehandlung eine vorhergehende Anfrage nicht zu, ist diese spätestens drei Arbeitstage ab Antritt der Heilbehandlung nachzureichen.

Der Versicherte hat der Ermittlung von zum Zwecke der Direktverrechnung erforderlichen Daten zuzustimmen.

Wird die Zustimmungserklärung verweigert, widerrufen oder verspätet erteilt und stellt der Leistungserbringer Kosten und Honorare dem Versicherten in Rechnung, ist der Versicherer diesem gegenüber nur in dem in der Vereinbarung über die Direktverrechnung festgelegten Ausmaß zur Leistung verpflichtet.

§ 12

Tagesklinische Behandlung in Krankenhäusern

Tagesklinische Heilbehandlungen sind Heilbehandlungen in einem Krankenhaus, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Art der Heilbehandlung erfordert üblicherweise einen Aufenthalt von mindestens 24 Stunden,
- der Versicherte wird noch am Tag der Aufnahme aus dem Krankenhaus entlassen, und

- für die Heilbehandlung wird die Infrastruktur einer Abteilung des Krankenhauses in Anspruch genommen (z.B. Aufnahme in der Bettenstation, Benutzung eines Operationssaales).
- Heilbehandlungen und Operationen in der Ambulanz eines Krankenhauses stellen jedenfalls keine tagesklinischen Behandlungen dar.

§ 13

Akut-Geriatrie und Remobilisation

Für medizinisch notwendige stationäre Akut-Geriatrie und Remobilisation im Anschluss an eine stationäre Heilbehandlung wird eine Leistung für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr erbracht.

Erfolgen Akut-Geriatrie bzw. Remobilisation in einem Krankenhaus (Abteilung), mit dem der Versicherer dafür einen Vertrag abgeschlossen hat, werden die vereinbarten Kosten mit dem Vertragskrankenhaus gemäß § 12 direkt verrechnet. In allen übrigen Fällen wird das dafür im Leistungstarif angeführte Ersatztagegeld ausbezahlt.

§ 14

Hospiz, Palliativstation

Für medizinisch notwendige stationäre Aufenthalte in einem Hospiz oder einer Palliativstation eines Krankenhauses wird eine Leistung für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr erbracht.

Erfolgt der Aufenthalt in einer Einrichtung, mit der der Versicherer dafür einen Vertrag abgeschlossen hat, werden die vereinbarten Kosten mit der Vertragseinrichtung gemäß § 12 direkt verrechnet. In allen übrigen Fällen wird das dafür im Leistungstarif angeführte Ersatztagegeld ausbezahlt.

§ 15

Tarifliche Leistungen

(1) Umfang einzelner tariflicher Leistungen

1. Tageskosten

umfassen die zu bezahlenden Kosten für Verpflegs- und Krankenhausgebühren (für die Unterbringung, Pflege und Verpflegung).

2. Behandlungshonorar

umfasst alle ärztlichen Honorare (auch Honorare für Hebammen) ausgenommen die Honorare für technische Untersuchungen wie bildgebende Verfahren, Labor, Nuklearmedizin etc.

Soweit Kosten aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Vereinbarungen mit dem Versicherer betraglich geregelt sind, ist der Versicherer zum Ersatz darüber hinausgehender Kosten (z.B. Sonderhonorare der Vorstände von Universitätskliniken gemäß § 46 KaKuG und ausführende Landesgesetze) nicht verpflichtet.

3. Technische Leistungen

umfassen die Honorare für technische Untersuchungen wie bildgebende Verfahren, Labor, Nuklearmedizin etc. und sämtlichen Sachaufwand einschließlich der Kosten für Benützung des Operationssaales, der Arzneimittel (Heilmittel) und Heilbehelfe.

(2) Stationäre Heilbehandlung in Krankenhäusern

Bei stationärer Heilbehandlung in nicht öffentlichen Krankenhäusern in Österreich oder dem Schengenraum, werden für die Kosten des Aufenthaltes die Leistungen gemäß der für

- Tageskosten,
- Behandlungshonorar,
- Technische Leistungen und
- Summenleistung

festgesetzten Beträgen erbracht.

(3) Tagesklinische Heilbehandlung in Krankenhäusern

Für tagesklinische Heilbehandlungen in Krankenhäusern, mit denen dafür keine vertraglichen Vereinbarungen über die Kostenübernahme bestehen, werden für die Kosten die folgenden tariflichen Leistungen wie für eine eintägige stationäre Heilbehandlung erbracht:

- Tageskosten,
- Behandlungshonorar,
- Technische Leistungen und

- Summenleistung.

Leistungen bei Kur, Rehabilitation und Anschlussheilverfahren

§ 16

Kuraufenthalt, Rehabilitation, Anschlussheilverfahren

- (1) Die Tarifleistungen "Kostenersatz für Kuraufenthalte" (auch in Einrichtungen für Psychosomatik und Zentren für seelische Gesundheit) und "Kostenersatz für Rehabilitation", das sind die Kosten der Unterbringung und Verpflegung und der ärztlich verordneten Behandlungen, werden erbracht, wenn der Aufenthalt vor Antritt durch den Versicherer genehmigt wurde. Grundlage für die Genehmigung ist, dass im Rahmen des Krankheitsgeschehens eine für die medizinisch indizierte Behandlung geeignete Einrichtung aufgesucht wird.
Der Antrag auf Erstattung der Kosten ist entsprechend medizinisch zu begründen. Der Versicherer kann vor Erledigung des Antrages auf seine Kosten die Untersuchung des Antragstellers durch einen von ihm bestimmten Arzt verlangen. Er hat binnen 4 Wochen nach Eingang des Antrages oder des Untersuchungsergebnisses Stellung zu nehmen, ansonsten gilt der Antrag als bewilligt.
Für ambulante Kuren, Rehabilitationen und Anschlussheilverfahren erfolgt keine Bewilligung.
- (2) Kostenersatz für Kuraufenthalte wird für längstens 28 Tage (für Kur- oder Erholungsaufenthalte in einer Einrichtung für Psychosomatik und einem Zentrum für seelische Gesundheit für längstens 42 Tage) bezahlt.
Kostenersatz für Rehabilitation wird für längstens 90 Tage bezahlt.

GesundheitsCoaching

§ 17

GesundheitsCoaching

- (1) **Informationen über medizinische Einrichtungen und Gesundheitsdienste,**
werden bei einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung zu folgenden Themen erteilt:
 - Behandler in Österreich (zur selbständigen Berufsausübung zugelassene Ärzte, Zahnärzte, Ärzte für Ganzheits- und Alternativmedizin, Psychotherapeuten)
 - Medizinische Einrichtungen weltweit
 - Ganzheits- und Alternativmedizin in Österreich
 - Transporteinrichtungen in Österreich
 1. Informationen zu medizinischen Einrichtungen außerhalb Österreichs
werden erteilt, wenn für die spezielle medizinische Behandlung kein geeigneter Arzt bzw. keine geeignete medizinische Einrichtung in Österreich vorhanden ist oder ärztliche Hilfe während eines Auslandsaufenthaltes erforderlich ist.
 2. Informationen zu Transporteinrichtungen in Österreich
werden erteilt, wenn der Versicherte aufgrund der Art der Erkrankung bzw. durch die Unfallfolgen oder wegen der ärztlich angeordneten Verhaltensmaßregeln außerstande ist, den Arzt oder die medizinische Einrichtung aus eigener Kraft aufzusuchen.
- (2) **Hilfe im Notfall**
- Ein medizinischer Notfall liegt vor, wenn der Versicherte von einer unmittelbaren Gefahr (z.B. akute Erkrankung, Unfall, drohende Einwirkung schädigender Stoffe) für Leben, körperliche Unversehrtheit oder Gesundheit bedroht ist.
- In allen medizinischen Notfällen ist der Versicherer rund um die Uhr erreichbar und
- unterstützt durch Herstellung der Verbindung und Organisation des Transports zu allen Notfalleinrichtungen in Österreich:
 - Nacht- und Wochenenddienste durch Ärzte für Allgemeinmedizin und Zahnärzte bzw. Apotheken, nächstgelegenes geeignetes Krankenhaus,
 - sonstige Notdienste (z.B. Rotes Kreuz, Vergiftungszentrale, psychosoziale Dienste)
 - oder
 - veranlasst - abhängig vom Gesundheitszustand des Versicherten - einen zeitnahen Rückruf von einem Arzt zur telefonischen Abklärung und Beratung über weitere Maßnahmen.
- (3) **Herstellung der Verbindung**
erfolgt nur auf Wunsch des Versicherten.

Der Versicherer stellt nur den erstmaligen Kontakt her, in weiterer Folge wendet sich der Versicherte selbst an den Arzt/Therapeuten, die medizinische Einrichtung oder den Gesundheitsdienst.

(4) **Haftungsausschluss**

Durch die Informationsleistung bzw. Herstellung der Verbindung gewährleistet der Versicherer nicht die Verfügbarkeit der Leistungen des betreffenden Arztes/Therapeuten, Gesundheitsdienstes oder der medizinischen Einrichtung in einem bestimmten Umfang oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes.

Ergänzende Versicherungsbedingungen für MedCare: Privatarzt - Tarife 1AHB, 2AHB und 3AHB (EB_AHB_17)

Vertragspartner

Diese Vertragsgrundlagen gelten für Verträge mit der Generali Versicherung AG, 1010 Wien, Landskronergasse 1-3.

Aufsichtsbehörde

Finanzmarktaufsicht, 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5



§ 1

Tarifkombination, gesetzliche Krankenversicherung

(1) Tarifkombination

Der Tarif AHB kann nur in Verbindung mit einer beim Versicherer für denselben Versicherten abgeschlossenen Krankenhauskosten- oder Krankenhaustagegeldversicherung (Haupttarif) versichert werden.
Wird der Haupttarif beendet, endet der Tarif AHB in demselben Zeitpunkt.

(2) Ausscheiden aus der gesetzlichen Krankenversicherung

Der Tarif AHB setzt voraus, dass der Versicherte gegenüber einem Träger der gesetzlichen Krankenversicherung in Österreich anspruchsberechtigt ist.
Damit bei einem Ausscheiden des Versicherten aus der gesetzlichen Krankenversicherung in Österreich weiterhin ein geeigneter Versicherungsschutz besteht, ist es erforderlich, dass der Versicherungsnehmer den Versicherer umgehend verständigt.

§ 2

Kostenersatz

Für "Ärztliche Heilbehandlung" und "Tele-Medizinische Beratung und Betreuung" gilt als maßgeblicher Zeitraum ein Kalenderjahr.

Fällt der Versicherungsbeginn für den Tarif AHB nicht mit dem Beginn eines Kalenderjahres zusammen, werden Leistungen für den Zeitraum zwischen Versicherungsbeginn des Tarifes AHB und 31. Dezember des betreffenden Jahres bis zu dem diesem Zeitraum entsprechenden anteiligen Höchstbetrag erbracht (der vor Versicherungsbeginn liegende Teil eines Kalendermonats wird für die Ermittlung des anteiligen Höchstbetrags mit einbezogen).

Dies gilt sinngemäß, wenn der Vertrag während des Kalenderjahres endet.

§ 3

Zahnbehandlungen und zahnärztliche Leistungen

(1) Leistungen werden erbracht für:

- Entfernung von Zähnen, Wurzeln und vorgelagerten Zähnen, wenn diese als Entzündungsherde die Erkrankung eines anderen Organs verursachen (z.B. Myokarditis, rheumatische Beschwerden)
- Behandlung von Mund- und Kieferkrankheiten (z.B. Stomatitis, Gingivitis, Kiefereiterungen)
- Entfernung von Zysten
- Wurzelspitzenresektionen
- Behandlung von Kieferbrüchen

(2) Keine Leistungen werden erbracht für:

- Konservierende Zahnbehandlungen (z.B. Füllungen)
- Prothetische Zahnbehandlungen (z.B. Implantate, Zahnbrücken)
- Kieferorthopädische Behandlungen (z.B. Zahnspange)
- Behandlungen von Parodontose

§ 4

Ärztliche Heilbehandlung

(1) Die Kosten für von Ärzten durchgeführte schulmedizinische Heilbehandlungen und im Tarif angeführte Heilbehandlungen der Ganzheits- und Alternativmedizin sowie Eltern-Kind-Pass-Untersuchungen werden bis zum tariflichen Höchstbetrag erstattet.

(2) Für im Tarif nicht genannte Heilbehandlungen nach sonstigen alternativmedizinischen Methoden werden Leistungen bis zum im Tarif angeführten Betrag insoweit erbracht, als sie von einem Arzt durchgeführt werden.

§ 5

Ambulante Operation

Die Kosten von ambulanten Operationen inkl. Kosten der Anästhesie werden gemäß § 5 A) Abs. 1 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 erstattet, wenn diese Operationen in der Ordination eines Arztes oder in der Ambulanz eines Krankenhauses vorgenommen werden

§ 6

Tele-Medizinische Beratung und Betreuung

Die Kosten medizinischer Beratung und Betreuung im Internet oder per Telefon werden insoweit erstattet, als die Leistung von einem Arzt erbracht wird, nachdem dieser die Behandlung des Versicherten in seiner Ordination oder im Rahmen eines Hausbesuches begonnen hat.

Abweichend von § 5 B) Abs. 5 AVBKV 2017 /AVBKVG 2017 leistet der Versicherer in diesem Fall auch Kostenersatz für Leistungen von Ärzten oder Zahnärzten/Dentisten, die nicht unmittelbar am Versicherten erbracht werden.

Dabei gelten insbesondere folgende Leistungen als versichert:

- Mitteilung eines Laborergebnisses, eines histologischen oder radiologischen Befundes
- Beratung des Patienten zur Dosisanpassung eines verordneten Medikaments
- Entscheidung aufgrund vom Patienten geschilderter Symptome, ob ein Termin in der Ordination überhaupt nötig und wie dringlich dieser ist

Kein Versicherungsschutz besteht für Kosten von:

- Mitgliedschaften in Online-Foren, Plattformen von Selbsthilfegruppen oder Informationsportalen zu medizinischen Themen
- Vorsorge- und Laboruntersuchungen, die aufgrund eingesandter Körperproben vorgenommen werden (z.B. Allergietest, DNA Analyse zu Risikofaktoren)

§ 7

GesundheitsCoaching

(1) Informationen über medizinische Einrichtungen und Gesundheitsdienste

werden bei einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung zu folgenden Themen erteilt:

- Behandler in Österreich (zur selbständigen Berufsausübung zugelassene Ärzte, Zahnärzte, Ärzte für Ganzheits- und Alternativmedizin, Psychotherapeuten)
- Medizinische Einrichtungen weltweit
- Ganzheits- und Alternativmedizin in Österreich
- Transporteinrichtungen in Österreich

1. Informationen zu medizinischen Einrichtungen außerhalb Österreich

werden erteilt, wenn für die spezielle medizinische Behandlung kein geeigneter Arzt bzw. keine geeignete medizinische Einrichtung in Österreich vorhanden ist oder ärztliche Hilfe während eines Auslandsaufenthaltes erforderlich ist.

2. Informationen zu Transporteinrichtungen in Österreich

werden erteilt, wenn der Versicherte aufgrund der Art der Erkrankung bzw. durch die Unfallfolgen oder wegen der ärztlich angeordneten Verhaltensmaßnahmen außerstande ist, den Arzt oder die medizinische Einrichtung aus eigener Kraft aufzusuchen.

(2) Hilfe im Notfall

Ein medizinischer Notfall liegt vor, wenn der Versicherte von einer unmittelbaren Gefahr (z.B. akute Erkrankung, Unfall, drohende Einwirkung schädigender Stoffe) für Leben, körperliche Unversehrtheit oder Gesundheit bedroht ist.

In allen medizinischen Notfällen ist der Versicherer rund um die Uhr erreichbar und

- unterstützt durch Herstellung der Verbindung und Organisation des Transports zu allen Notfalleinrichtungen in Österreich:

- Nacht- und Wochenenddienste durch Ärzte für Allgemeinmedizin und Zahnärzte bzw. Apotheken, nächstgelegenes geeignetes Krankenhaus
- sonstige Notdienste (z.B. Rotes Kreuz, Vergiftungszentrale, psychosoziale Dienste)

oder

- veranlasst - abhängig vom Gesundheitszustand des Versicherten - einen zeitnahen Rückruf von einem Arzt zur telefonischen Abklärung und Beratung über weitere Maßnahmen.

(3) **Bester Arzt, bester Therapeut**

Bei einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung unterstützt der Versicherer den Versicherten bei der Suche nach dem hinsichtlich

- des konkreten Beschwerdebildes am besten geeigneten Arzt, bzw.
- der ärztlich empfohlenen Maßnahmen am besten geeigneten Therapeuten.

Bei einer notwendigen medizinischen Heilbehandlung nennt der Versicherer auf Wunsch des Versicherten einen Spezialisten, wenn eine Therapie bzw. ein Eingriff von einem Arzt bereits geplant ist (Ärztliche Zweitmeinung (Second Opinion)).

(4) **Herstellung der Verbindung**

erfolgt nur auf Wunsch des Versicherten.

Der Versicherer stellt nur den erstmaligen Kontakt her, in weiterer Folge wendet sich der Versicherte selbst an den Arzt/Therapeuten, die medizinische Einrichtung oder den Gesundheitsdienst.

(5) **Haftungsausschluss**

Durch die Informationsleistung bzw. Herstellung der Verbindung gewährleistet der Versicherer nicht die Verfügbarkeit der Leistungen des betreffenden Arztes/Therapeuten, Gesundheitsdienstes oder der medizinischen Einrichtung in einem bestimmten Umfang oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes.

(6) **Leistungen des persönlichen GesundheitsCoaches**

werden für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten durch dafür qualifizierte Mitarbeiter eines Vertragspartners des Versicherers erbracht.

Dieser Zeitraum beginnt:

- Bei der Begleitung während der Genesung und Unterstützung bei der besseren Bewältigung der durch den Versicherungsfall bedingten Lebenssituation mit der medizinisch notwendigen ambulanten Heilbehandlung
- Bei der Erarbeitung einer Strategie zur Reduktion von Risikofaktoren und Unterstützung bei Maßnahmen zur Umstellung hin zu einem gesünderen Lebensstil mit der erstmaligen Kontaktaufnahme mit dem GesundheitsCoach

Der Versicherer trägt die Kosten der Begleitung und Unterstützung durch den persönlichen GesundheitsCoach, leistet jedoch keinen Kostenersatz für von diesem erarbeitete oder vorgeschlagene Maßnahmen (z.B. Kosten gesünderer Lebensmittel oder eines Fitnesstrainings).

(7) **Medizinische Online Sprechstunde**

durch Experten eines Vertragspartners des Versicherers:

1. Beratung durch einen Arzt (bestimmte Fachgebiete) bei Beschwerden, Krankheit oder nach Unfall
2. Erklärung eines medizinischen Befundes durch einen Arzt (bestimmte Fachgebiete)
3. Information über Wirkung und Wechselwirkung verordneter Medikamente durch einen Pharmazeuten

Der Versicherte kann die Leistungen gemäß Pkt. 1 - 3 jeweils fünfmal pro Kalenderjahr in Anspruch nehmen. Der Versicherer verrechnet die Kosten direkt mit dem Vertragspartner.

Die Zusage für die Inanspruchnahme der Medizinischen Online Sprechstunde gilt, solange eine Vereinbarung mit einem Vertragspartner besteht.

(8) **Nachweis der Anspruchsvoraussetzungen**

Außer bei "Hilfe im Notfall" kann der Versicherer verlangen, dass der Versicherte die Anspruchsvoraussetzungen der oben angeführten Leistungen durch entsprechende medizinische Unterlagen (ärztliche Befunde, Rezepte für Arzneien, etc.) nachweist.

§ 8

Änderung der Prämie und des Versicherungsschutzes

Der Tarif AHB unterliegt der Anpassung gemäß § 17 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017.

§ 9

Tarifabrechnungsverband

Die Versicherungen nach Tarif AHB gehören zum Tarifabrechnungsverband H (siehe § 18 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017) und berechtigen bei Leistungsfreiheit zu einer Prämienrückvergütung in Höhe von 15% der für das Kalenderjahr vorgeschriebenen, abgegrenzten Jahresprämie.

Im Falle einer Gruppenkrankenversicherung kann für die Prämienrückvergütung aus dem Tarif AHB im Gruppenvertrag eine abweichende Vereinbarung getroffen werden.

Ergänzende Versicherungsbedingungen für MedCare: Privatarzt & Alternative Vorsorge für Nichtsozialversicherte - Tarif AJN (EB_AJN_17)

Vertragspartner

Diese Vertragsgrundlagen gelten für Verträge mit der Generali Versicherung AG, 1010 Wien, Landskrongasse 1-3.

Aufsichtsbehörde

Finanzmarktaufsicht, 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5



§ 1

Tarifikombination

Der Tarif AJN kann nur in Verbindung mit einer beim Versicherer für denselben Versicherten abgeschlossenen Krankenhauskostenversicherung (Haupttarif) versichert werden.
Wird der Haupttarif beendet, endet der Tarif AJN in demselben Zeitpunkt.

§ 2

Eintritt in die gesetzliche Krankenversicherung

Der Tarif AJN setzt voraus, dass der Versicherte in Österreich keiner gesetzlichen Krankenversicherung unterliegt. Damit bei einem Eintritt des Versicherten in eine gesetzliche Krankenversicherung in Österreich (Pflichtversicherung oder freiwillige Versicherung) weiterhin ein geeigneter Versicherungsschutz besteht, ist es erforderlich, dass der Versicherungsnehmer den Versicherer umgehend verständigt.

§ 3

Kostenersatz

Für die in den Absätzen 1 und 2 angeführten Tarifleistungen gilt als maßgeblicher Zeitraum ein Kalenderjahr.

Leistung für Sehbehelfe:

Im Rahmen des Höchstbetrags für Heilbehelfe hat der Versicherte wahlweise Anspruch auf Kostenersatz für eine Brille, Kontaktlinsen oder refraktive Augenchirurgie (z.B. Sehstärkenkorrektur mittels Laserbehandlung der Hornhaut oder durch Implantation einer zusätzlichen oder Ersatz der körpereigenen Linse).

(1) Tarif 1AJN:

- Ärztliche Heilbehandlung
- Tele-Medizinische Beratung und Betreuung
- Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
- Ärztlich verordnete Arzneimittel
- Ärztlich verordnete Behandlung durch Psychologen und Psychotherapeuten
- Ärztlich verordnete Besondere Heilbehandlungen
- Ärztlich verordnete Heilbehelfe

(2) Tarif 2AJN und 3AJN:

- Ärztliche Heilbehandlung (Tarif 2AJN)
- Tele-Medizinische Beratung und Betreuung
- Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
- Ärztlich verordnete Behandlung durch Psychologen und Psychotherapeuten
- Ärztlich verordnete Besondere Heilbehandlungen
- Ärztlich verordnete Heilbehelfe
- Kosten für Zahnbehandlung

- (3)** Fällt der Versicherungsbeginn für den Tarif AJN nicht mit dem Beginn eines Kalenderjahres zusammen, werden Leistungen für den Zeitraum zwischen Versicherungsbeginn des Tarifes AJN und 31. Dezember des betreffenden Jahres bis zu dem diesem Zeitraum entsprechenden anteiligen Höchstbetrag erbracht (der vor Versicherungsbeginn liegende Teil eines Kalendermonats wird für die Ermittlung des anteiligen Höchstbetrags mit einbezogen). Dies gilt sinngemäß, wenn der Vertrag während des Kalenderjahres endet.

§ 4

Wartezeit

Für Leistungen für prothetische Zahnbehandlung beträgt die allgemeine Wartezeit 6 Monate. Im Falle akut notwendiger Zahnbehandlung gilt keine Wartezeit vereinbart.

In Ergänzung zu § 4 Abs. 2 AVBKV 2017 / AVBKG 2017 besteht für Früh- oder Fehlgeburten Versicherungsschutz, wenn der normale Verlauf der Schwangerschaft zu einer Entbindung nach 9 Monaten geführt hätte.

§ 5

Einschränkung des Versicherungsschutzes

Für die Tarife 2AJN und 3AJN gilt vereinbart:

Abweichend von § 5 A) Abs. 9 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 erfolgt auch Kostenersatz für ärztliche verordnete Heilbehelfe (Hilfsmittel) zur Versorgung künstlicher Darm- und Blasenausgänge sowie zur Versorgung bei Inkontinenz.

§ 6

Ärztliche Heilbehandlung

- (1) Die Kosten für von Ärzten durchgeführte schulmedizinische Heilbehandlungen und im Tarif angeführte Heilbehandlungen der Ganzheits- und Alternativmedizin sowie Eltern-Kind-Pass-Untersuchungen werden bis zum tariflichen Höchstbetrag erstattet.
- (2) Für im Tarif nicht genannte Heilbehandlungen nach sonstigen alternativmedizinischen Methoden und für medizinisch empfohlene Vorsorgeuntersuchungen (auch Pränataldiagnostik) werden Leistungen bis zum im Tarif angeführten Betrag insoweit erbracht, als sie von einem Arzt durchgeführt werden.

Vorsorgeuntersuchungen sind Untersuchungen zur Früherkennung chronischer Erkrankungen, wie z.B. maligner Prozesse (Krebs), Erkrankungen des Herzens und des Kreislaufes oder des Stoffwechsels, unter Anwendung von nach dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Wissenschaft zweckmäßigen und ausreichenden Maßnahmen. Ebenfalls als Vorsorgeuntersuchung anzusehen ist die einmalige Feststellung der für die erste Hilfe nach akuten Erkrankungen oder Unfällen bzw. zur Schockbekämpfung wesentlichen Daten, wie Blutgruppe, Rhesusfaktor, Allergien usw. Nicht als Vorsorgeuntersuchung gelten Schwangerschaftstests.

§ 7

Ambulante Operation

Die Kosten von ambulanten Operationen inkl. Kosten der Anästhesie werden gemäß § 5 A) Abs. 1 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 erstattet, wenn diese Operationen in der Ordination eines Arztes oder in der Ambulanz eines Krankenhauses vorgenommen werden.

Die Kosten refraktiver Augenchirurgie werden bis zum Höchstbetrag für Heilbehelfe ersetzt (siehe oben, § 2).

§ 8

Medizinische Hauskrankenpflege

Unter medizinischer Hauskrankenpflege sind qualifizierte Pflegeleistungen (Injektionen, Sondenernährung, Wundversorgung usw.) zu verstehen, die

- nach einer stationären Heilbehandlung,
 - auf ärztliche Anordnung,
 - durch diplomierte KrankenpflegerInnen
- erbracht werden.

Kein Kostenersatz erfolgt für eine allfällige Grundpflege (z.B. Haut-, Haar- und Zahnpflege) sowie die hauswirtschaftliche Versorgung des Versicherten.

§ 9

Maßnahmen der Gesundheitsförderung

- (1) Kosten werden ersetzt für:
 - **Vorbeugende alternativmedizinische Maßnahmen**, sofern sie von Ärzten oder in Österreich zur Heilbehandlung am Kranken Berechtigten durchgeführt werden
 - **Anleitung zu gesundem Lebensstil**, wenn die Maßnahmen anerkannterweise geeignet sind, zu einer Änderung des Lebensstils beizutragen und von dafür qualifizierten und berechtigten Personen durchgeführt werden
 - Maßnahmen der **Gesundheitsförderung und Prophylaxe**, z.B. Massagen, Schutzimpfungen (auch Reiseimpfungen)
 - Ärztlich verordnete **Nahrungsergänzungsmittel**
 - **Sportmedizinische Tests** von dafür qualifizierten Personen (z.B. Sportmediziner, Fitnesstrainer)
 - **Erste-Hilfe-Kurse** im Rahmen der privaten Aus- und Weiterbildung (z.B. Führerscheinkurs, Kindernotfallkurs) durch qualifizierte Angehörige von dazu in Österreich berechtigten Organisationen (z.B. Rotes Kreuz, Arbeitersamariterbund).

Der Versicherer ersetzt keine Kosten, die im Rahmen der Ausbildung als Mitglied einer Rettungsorganisation oder beruflicher Aus- und Weiterbildung entstehen.

Der Versicherer ersetzt die nachgewiesenen Kosten nach Vorlage einer von der den Kurs durchführenden Organisation ausgestellten Teilnahmebestätigung.

(2) Nicht bezahlt werden:

- Nahrungsmittel (z.B. Diätahrung oder Nahrungsmittel aus biologischer Landwirtschaft)
- Mitgliedschaften in Online-Foren, Plattformen von Selbsthilfegruppen oder Informationsportalen zu medizinischen Themen
- Vorsorge- und Laboruntersuchungen, die aufgrund eingesandter Körperproben vorgenommen werden (z.B. Allergietest, DNA Analyse zu Risikofaktoren)
- Geräte zur Förderung der körperlichen Beweglichkeit und Fitness

§ 10

Tele-Medizinische Beratung und Betreuung

Die Kosten medizinischer Beratung und Betreuung im Internet oder per Telefon werden insoweit erstattet, als die Leistung von einem Arzt erbracht wird, nachdem dieser die Behandlung des Versicherten in seiner Ordination oder im Rahmen eines Hausbesuches begonnen hat.

Abweichend von § 5 B) Abs. 5 AVBKV 2017 /AVBKVG 2017 leistet der Versicherer in diesem Fall auch Kostenersatz für Leistungen von Ärzten oder Zahnärzten/Dentisten, die nicht unmittelbar am Versicherten erbracht werden.

Dabei gelten insbesondere folgende Leistungen als versichert:

- Mitteilung eines Laborergebnisses, eines histologischen oder radiologischen Befundes
- Beratung des Patienten zur Dosisanpassung eines verordneten Medikaments
- Entscheidung aufgrund vom Patienten geschilderter Symptome, ob ein Termin in der Ordination überhaupt nötig und wie dringlich dieser ist

Kein Versicherungsschutz besteht für Kosten von:

- Mitgliedschaften in Online-Foren, Plattformen von Selbsthilfegruppen oder Informationsportalen zu medizinischen Themen
- Vorsorge- und Laboruntersuchungen, die aufgrund eingesandter Körperproben vorgenommen werden (z.B. Allergietest, DNA Analyse zu Risikofaktoren)

§ 11

Psychotherapeutische Behandlungen

Leistungen für Psychotherapie werden erbracht, sofern die Behandlungen durch in Österreich zugelassene Psychologen und Psychotherapeuten durchgeführt werden.

§ 12

Transportkosten

- (1) Abweichend von § 5 B) Abs. 7 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 werden die Kosten für notwendige Fahrten des Versicherten zu einer ärztlichen Behandlung bis zu dem im Leistungstarif vorgesehenen Höchstbetrag je Transport ersetzt. Als notwendige Fahrten gelten die Fahrten mit Krankenwagen, Bahn oder Autotaxi zur Erstversorgung, im Notfall oder nach ärztlicher Verordnung.
- (2) Die Kosten eines medizinisch notwendigen Transports mittels Hubschrauber werden ersetzt, wenn und soweit der Transport mit den in Abs. 1 genannten Transportmitteln aus medizinischen Gründen nicht möglich ist und kein Kostenersatz aus einem Tarif für stationäre Heilbehandlung erfolgt.

§ 13

GesundheitsCoaching

(1) **Informationen über medizinische Einrichtungen und Gesundheitsdienste**

werden bei einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung zu folgenden Themen erteilt:

- Behandler in Österreich (zur selbständigen Berufsausübung zugelassene Ärzte, Zahnärzte, Ärzte für Ganzheits- und Alternativmedizin, Psychotherapeuten)
- Medizinische Einrichtungen weltweit
- Ganzheits- und Alternativmedizin in Österreich

- Transporteinrichtungen in Österreich

1. Informationen zu medizinischen Einrichtungen außerhalb Österreich

werden erteilt, wenn für die spezielle medizinische Behandlung kein geeigneter Arzt bzw. keine geeignete medizinische Einrichtung in Österreich vorhanden ist oder ärztliche Hilfe während eines Auslandsaufenthaltes erforderlich ist.

2. Informationen zu Transporteinrichtungen in Österreich

werden erteilt, wenn der Versicherte aufgrund der Art der Erkrankung bzw. durch die Unfallfolgen oder wegen der ärztlich angeordneten Verhaltensmaßregeln außerstande ist, den Arzt oder die medizinische Einrichtung aus eigener Kraft aufzusuchen.

(2) Hilfe im Notfall

Ein medizinischer Notfall liegt vor, wenn der Versicherte von einer unmittelbaren Gefahr (z.B. akute Erkrankung, Unfall, drohende Einwirkung schädigender Stoffe) für Leben, körperliche Unversehrtheit oder Gesundheit bedroht ist.

In allen medizinischen Notfällen ist der Versicherer rund um die Uhr erreichbar und

- unterstützt durch Herstellung der Verbindung und Organisation des Transports zu allen Notfalleinrichtungen in Österreich:

- Nacht- und Wochenenddienste durch Ärzte für Allgemeinmedizin und Zahnärzte bzw. Apotheken, nächstgelegenes geeignetes Krankenhaus
- sonstige Notdienste (z.B. Rotes Kreuz, Vergiftungszentrale, psychosoziale Dienste)

oder

- veranlasst - abhängig vom Gesundheitszustand des Versicherten - einen zeitnahen Rückruf von einem Arzt zur telefonischen Abklärung und Beratung über weitere Maßnahmen.

(3) Bester Arzt, bester Therapeut

Bei einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung unterstützt der Versicherer den Versicherten bei der Suche nach dem hinsichtlich

- des konkreten Beschwerdebildes am besten geeigneten Arzt, bzw.
- der ärztlich empfohlenen Maßnahmen am besten geeigneten Therapeuten.

Bei einer notwendigen medizinischen Heilbehandlung nennt der Versicherer auf Wunsch des Versicherten einen Spezialisten, wenn eine Therapie bzw. ein Eingriff von einem Arzt bereits geplant ist (Ärztliche Zweitmeinung (Second Opinion)).

(4) Herstellung der Verbindung

erfolgt nur auf Wunsch des Versicherten.

Der Versicherer stellt nur den erstmaligen Kontakt her, in weiterer Folge wendet sich der Versicherte selbst an den Arzt/Therapeuten, die medizinische Einrichtung oder den Gesundheitsdienst.

(5) Haftungsausschluss

Durch die Informationsleistung bzw. Herstellung der Verbindung gewährleistet der Versicherer nicht die Verfügbarkeit der Leistungen des betreffenden Arztes/Therapeuten, Gesundheitsdienstes oder der medizinischen Einrichtung in einem bestimmten Umfang oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes.

(6) Leistungen des persönlichen GesundheitsCoaches

werden für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten durch dafür qualifizierte Mitarbeiter eines Vertragspartners des Versicherers erbracht.

Dieser Zeitraum beginnt:

- Bei der Begleitung während der Genesung und Unterstützung bei der besseren Bewältigung der durch den Versicherungsfall bedingten Lebenssituation mit der medizinisch notwendigen ambulanten Heilbehandlung
- Bei der Erarbeitung einer Strategie zur Reduktion von Risikofaktoren und Unterstützung bei Maßnahmen zur Umstellung hin zu einem gesünderen Lebensstil mit der erstmaligen Kontaktaufnahme mit dem GesundheitsCoach

Der Versicherer trägt die Kosten der Begleitung und Unterstützung durch den persönlichen GesundheitsCoach, leistet jedoch keinen Kostenersatz für von diesem erarbeitete oder vorgeschlagene Maßnahmen (z.B. Kosten gesünderer Lebensmittel oder eines Fitnesstrainings).

(7) Medizinische Online Sprechstunde

durch Experten eines Vertragspartners des Versicherers:

1. Beratung durch einen Arzt (bestimmte Fachgebiete) bei Beschwerden, Krankheit oder nach Unfall

2. Erklärung eines medizinischen Befundes durch einen Arzt (bestimmte Fachgebiete)
3. Information über Wirkung und Wechselwirkung verordneter Medikamente durch einen Pharmazeuten

Der Versicherte kann die Leistungen gemäß Pkt. 1 - 3 jeweils fünfmal pro Kalenderjahr in Anspruch nehmen. Der Versicherer verrechnet die Kosten direkt mit dem Vertragspartner.

Die Zusage für die Inanspruchnahme der Medizinischen Online Sprechstunde gilt, solange eine Vereinbarung mit einem Vertragspartner besteht.

(8) Nachweis der Anspruchsvoraussetzungen

Außer bei "Hilfe im Notfall" kann der Versicherer verlangen, dass der Versicherte die Anspruchsvoraussetzungen der oben angeführten Leistungen durch entsprechende medizinische Unterlagen (ärztliche Befunde, Rezepte für Arzneien, etc.) nachweist.

§ 14

Änderung der Prämie und des Versicherungsschutzes

Der Tarif AJN unterliegt der Anpassung gemäß § 17 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017.

§ 15

Tarifabrechnungsverband

Die Versicherungen nach Tarif AJN gehören zum Tarifabrechnungsverband H (siehe § 18 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017) und berechtigen bei Leistungsfreiheit zu einer Prämienrückvergütung in Höhe von 15% der für das Kalenderjahr vorgeschriebenen, abgegrenzten Jahresprämie.

Im Falle einer Gruppenkrankenversicherung kann für die Prämienrückvergütung aus dem Tarif AJN im Gruppenvertrag eine abweichende Vereinbarung getroffen werden.

Die nachfolgenden Bestimmungen der §§ 16 und 17 gelten nur bei Tarifen 2AJN und 3AJN:

§ 16

Kuraufenthalt, Rehabilitation, Anschlussheilverfahren

- (1) Die Tarifleistungen "Kostenersatz für Kuraufenthalte" (auch in Einrichtungen für Psychosomatik und Zentren für seelische Gesundheit) und "Kostenersatz für Rehabilitation", das sind die Kosten der Unterbringung und Verpflegung und der ärztlich verordneten Behandlungen, werden erbracht, wenn der Aufenthalt vor Antritt durch den Versicherer genehmigt wurde. Grundlage für die Genehmigung ist, dass im Rahmen des Krankheitsgeschehens eine für die medizinisch indizierte Behandlung geeignete Einrichtung aufgesucht wird.
Der Antrag auf Erstattung der Kosten ist entsprechend medizinisch zu begründen. Der Versicherer kann vor Erledigung des Antrages auf seine Kosten die Untersuchung des Antragstellers durch einen von ihm bestimmten Arzt verlangen. Er hat binnen 4 Wochen nach Eingang des Antrages oder des Untersuchungsergebnisses Stellung zu nehmen, ansonsten gilt der Antrag als bewilligt.
Für ambulante Kuren, Rehabilitationen und Anschlussheilverfahren erfolgt keine Bewilligung.
- (2) Kostenersatz für Kuraufenthalte wird für längstens 28 Tage (für Kur- oder Erholungsaufenthalte in einer Einrichtung für Psychosomatik und einem Zentrum für seelische Gesundheit für längstens 42 Tage) und maximal 2 Aufenthalte innerhalb von 6 Kalenderjahren bezahlt.
Kostenersatz für Rehabilitation wird für längstens 90 Tage bezahlt.

§ 17

Zahnbehandlung, Zahnersatz und Zahnvorsorge

- (1) Leistungen für konservierende Zahnbehandlung werden erbracht für Zahnextraktionen, Herstellung von Plomben (ausgenommen Edelmetall- und Keramikinlays), Wurzelbehandlungen und kieferorthopädische Behandlungen.
- (2) Leistungen für prothetische Zahnbehandlung werden erbracht für Kronen, Stiftzähne, Brücken, Implantate, Prothesen, Edelmetall- und Keramikinlays sowie Zahn- und Kieferregulierungen.
- (3) Vorsorgemaßnahmen zur Zahnerhaltung oder Zahnpflege werden bezahlt für Mundhygiene (Zahntaschenreinigung, Zahnsteinentfernung, Fluoridierung), Fissurenversiegelung und Kontrolluntersuchungen.

- (4) Kostenersatz aus der Tarifleistung "Ärztliche Heilbehandlung" wird erbracht für:
- In Abs. 1 angeführte Leistungen, wenn Zähne oder Wurzeln als Entzündungsherde die Erkrankung eines anderen Organs verursachen (z.B. Myokarditis, rheumatische Beschwerden)
 - Behandlung von Mund- und Kieferkrankheiten (z.B. Stomatitis, Gingivitis, Kiefereiterungen)
 - Entfernung von Zysten
 - Wurzelspitzenresektionen
 - Behandlung von Kieferbrüchen

Ergänzende Versicherungsbedingungen für MedCare: Privatarzt & Alternative Vorsorge - Tarif AJS (EB_AJS_17)

Vertragspartner

Diese Vertragsgrundlagen gelten für Verträge mit der Generali Versicherung AG, 1010 Wien, Landskrongasse 1-3.

Aufsichtsbehörde

Finanzmarktaufsicht, 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5



§ 1

Gesetzliche Krankenversicherung

Der Tarif AJS setzt voraus, dass der Versicherte gegenüber einem Träger der gesetzlichen Krankenversicherung in Österreich anspruchsberechtigt ist.

Damit bei einem Ausscheiden des Versicherten aus der gesetzlichen Krankenversicherung in Österreich weiterhin ein geeigneter Versicherungsschutz besteht, ist es erforderlich, dass der Versicherungsnehmer den Versicherer umgehend verständigt.

§ 2

Kostenersatz

Für die folgenden Leistungen des Tarifes AJS gilt als maßgeblicher Zeitraum ein Kalenderjahr:

- Ärztliche Heilbehandlung
- Tele-Medizinische Beratung und Betreuung
- Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
- Ärztlich verordnete Behandlung durch Psychologen, Psychotherapeuten
- Ärztlich verordnete besondere Heilbehandlungen
- Ärztlich verordnete Arzneimittel
- Ärztlich verordnete Heilbehelfe
- Transportkosten

Leistung für Sehbehelfe:

Im Rahmen des Höchstbetrags für Heilbehelfe hat der Versicherte wahlweise Anspruch auf Kostenersatz für eine Brille, Kontaktlinsen oder refraktive Augen Chirurgie (z.B. Sehstärkenkorrektur mittels Laserbehandlung der Hornhaut oder durch Implantation einer zusätzlichen oder Ersatz der körpereigenen Linse).

Fällt der Versicherungsbeginn für den Tarif AJS nicht mit dem Beginn eines Kalenderjahres zusammen, werden Leistungen für den Zeitraum zwischen Versicherungsbeginn des Tarifes AJS und 31. Dezember des betreffenden Jahres bis zu dem diesem Zeitraum entsprechenden anteiligen Höchstbetrag erbracht (der vor Versicherungsbeginn liegende Teil eines Kalendermonats wird für die Ermittlung des anteiligen Höchstbetrags mit einbezogen).

Dies gilt sinngemäß, wenn der Vertrag während des Kalenderjahres endet.

§ 3

Zahnbehandlungen und zahnärztliche Leistungen

(1) Leistungen werden erbracht für:

- Entfernung von Zähnen, Wurzeln und vorgelagerten Zähnen, wenn diese als Entzündungsherde die Erkrankung eines anderen Organs verursachen (z.B. Myokarditis, rheumatische Beschwerden)
- Behandlung von Mund- und Kieferkrankheiten (z.B. Stomatitis, Gingivitis, Kiefereiterungen)
- Entfernung von Zysten
- Wurzelspitzenresektionen
- Behandlung von Kieferbrüchen

(2) Keine Leistungen werden erbracht für:

- Konservierende Zahnbehandlungen (z.B. Füllungen)
- Prothetische Zahnbehandlungen (z.B. Implantate, Zahnbrücken)
- Kieferorthopädische Behandlungen (z.B. Zahnspange)
- Behandlungen von Parodontose

§ 4

Ärztliche Heilbehandlung

(1) Die Kosten für von Ärzten durchgeführte schulmedizinische Heilbehandlungen und im Tarif angeführte Heilbehandlungen der Ganzheits- und Alternativmedizin sowie Eltern-Kind-Pass-Untersuchungen werden bis zum tariflichen Höchstbetrag erstattet.

- (2) Für im Tarif nicht genannte Heilbehandlungen nach sonstigen alternativmedizinischen Methoden werden Leistungen bis zum im Tarif angeführten Betrag insoweit erbracht, als sie von einem Arzt durchgeführt werden.

§ 5

Ambulante Operation

Die Kosten von ambulanten Operationen inkl. Kosten der Anästhesie werden gemäß § 5 A) Abs. 1 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 erstattet, wenn diese Operationen in der Ordination eines Arztes oder in der Ambulanz eines Krankenhauses vorgenommen werden.

Die Kosten refraktiver Augenchirurgie werden bis zum Höchstbetrag für Heilbehelfe ersetzt (siehe oben, § 2).

§ 6

Maßnahmen der Gesundheitsförderung

- (1) Kosten werden ersetzt für:

- **Vorbeugende alternativmedizinische Maßnahmen**, sofern sie von Ärzten oder in Österreich zur Heilbehandlung am Kranken Berechtigten durchgeführt werden
- **Anleitung zu gesundem Lebensstil**, wenn die Maßnahmen anerkannterweise geeignet sind, zu einer Änderung des Lebensstils beizutragen und von dafür qualifizierten und berechtigten Personen durchgeführt werden
- Maßnahmen der **Gesundheitsförderung und Prophylaxe**, z.B. Massagen, Schutzimpfungen (auch Reiseimpfungen)
- Ärztlich verordnete **Nahrungsergänzungsmittel**
- **Sportmedizinische Tests** von dafür qualifizierten Personen (z.B. Sportmediziner, Fitnesstrainer)
- Von einem praktischen Arzt oder Facharzt durchgeführte **Vorsorgeuntersuchungen** (auch Pränataldiagnostik) einschließlich der Kosten von Röntgen- und Laboruntersuchungen. Vorsorgeuntersuchungen sind Untersuchungen zur Früherkennung chronischer Erkrankungen, wie z.B. maligner Prozesse (Krebs), Erkrankungen des Herzens und des Kreislaufes oder des Stoffwechsels, unter Anwendung von nach dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Wissenschaft zweckmäßigen und ausreichenden Maßnahmen. Ebenfalls als Vorsorgeuntersuchung anzusehen ist die einmalige Feststellung der für die erste Hilfe nach akuten Erkrankungen oder Unfällen bzw. zur Schockbekämpfung wesentlichen Daten, wie Blutgruppe, Rhesusfaktor, Allergien usw. Nicht als Vorsorgeuntersuchung gelten Schwangerschaftstests.
- **Erste-Hilfe-Kurse** im Rahmen der privaten Aus- und Weiterbildung (z.B. Führerscheinkurs, Kindernotfallkurs) durch qualifizierte Angehörige von dazu in Österreich berechtigten Organisationen (z.B. Rotes Kreuz, Arbeitersamariterbund). Der Versicherer ersetzt keine Kosten, die im Rahmen der Ausbildung als Mitglied einer Rettungsorganisation oder beruflicher Aus- und Weiterbildung entstehen. Der Versicherer ersetzt die nachgewiesenen Kosten nach Vorlage einer von der den Kurs durchführenden Organisation ausgestellten Teilnahmebestätigung.

- (2) Nicht bezahlt werden:

- Nahrungsmittel (z.B. Diätahrung oder Nahrungsmittel aus biologischer Landwirtschaft)
- Mitgliedschaften in Online-Foren, Plattformen von Selbsthilfegruppen oder Informationsportalen zu medizinischen Themen
- Vorsorge- und Laboruntersuchungen, die aufgrund eingesandter Körperproben vorgenommen werden (z.B. Allergietest, DNA Analyse zu Risikofaktoren)
- Geräte zur Förderung der körperlichen Beweglichkeit und Fitness

§ 7

Tele-Medizinische Beratung und Betreuung

Die Kosten medizinischer Beratung und Betreuung im Internet oder per Telefon werden insoweit erstattet, als die Leistung von einem behandelnden Arzt des Versicherten erbracht wird.

Abweichend von § 5 B) Abs. 5 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 leistet der Versicherer in diesem Fall auch Kostenersatz für Leistungen von Ärzten oder Zahnärzten/Dentisten, die nicht unmittelbar am Versicherten erbracht werden.

Dabei gelten insbesondere folgende Leistungen als versichert:

- Mitteilung eines Laborergebnisses, eines histologischen oder radiologischen Befundes
- Beratung des Patienten zur Dosisanpassung eines verordneten Medikaments
- Entscheidung aufgrund vom Patienten geschilderter Symptome, ob ein Termin in der Ordination überhaupt nötig und wie dringlich dieser ist

Kein Versicherungsschutz besteht für Kosten von:

- Mitgliedschaften in Online-Foren, Plattformen von Selbsthilfegruppen oder Informationsportalen zu medizinischen Themen
- Vorsorge- und Laboruntersuchungen, die aufgrund eingesandter Körperproben vorgenommen werden (z.B. Allergietest, DNA Analyse zu Risikofaktoren)

§ 8

Psychotherapeutische Behandlungen

Leistungen für Psychotherapie werden erbracht, sofern die Behandlungen durch in Österreich zugelassene Psychologen und Psychotherapeuten durchgeführt werden.

§ 9

Transportkosten

Abweichend von § 5 B) Abs. 7 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 werden die Kosten für notwendige Fahrten des Versicherten zu einer ärztlichen Behandlung bis zu dem im Leistungstarif vorgesehenen Höchstbetrag ersetzt. Als notwendige Fahrten gelten die Fahrten mit Krankenwagen, Bahn oder Autotaxi zur Erstversorgung oder im Notfall.

§ 10

GesundheitsCoaching

(1) Informationen über medizinische Einrichtungen und Gesundheitsdienste

werden bei einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung zu folgenden Themen erteilt:

- Behandler in Österreich (zur selbständigen Berufsausübung zugelassene Ärzte, Zahnärzte, Ärzte für Ganzheits- und Alternativmedizin, Psychotherapeuten)
- Medizinische Einrichtungen weltweit
- Ganzheits- und Alternativmedizin in Österreich
- Transporteinrichtungen in Österreich

1. Informationen zu medizinischen Einrichtungen außerhalb Österreich

werden erteilt, wenn für die spezielle medizinische Behandlung kein geeigneter Arzt bzw. keine geeignete medizinische Einrichtung in Österreich vorhanden ist oder ärztliche Hilfe während eines Auslandsaufenthaltes erforderlich ist.

2. Informationen zu Transporteinrichtungen in Österreich

werden erteilt, wenn der Versicherte aufgrund der Art der Erkrankung bzw. durch die Unfallfolgen oder wegen der ärztlich angeordneten Verhaltensmaßnahmen außerstande ist, den Arzt oder die medizinische Einrichtung aus eigener Kraft aufzusuchen.

(2) Hilfe im Notfall

Ein medizinischer Notfall liegt vor, wenn der Versicherte von einer unmittelbaren Gefahr (z.B. akute Erkrankung, Unfall, drohende Einwirkung schädigender Stoffe) für Leben, körperliche Unversehrtheit oder Gesundheit bedroht ist.

In allen medizinischen Notfällen ist der Versicherer rund um die Uhr erreichbar und

- unterstützt durch Herstellung der Verbindung und Organisation des Transports zu allen Notfalleinrichtungen in Österreich:

- Nacht- und Wochenenddienste durch Ärzte für Allgemeinmedizin und Zahnärzte bzw. Apotheken, nächstgelegenes geeignetes Krankenhaus
- sonstige Notdienste (z.B. Rotes Kreuz, Vergiftungszentrale, psychosoziale Dienste)

oder

- veranlasst - abhängig vom Gesundheitszustand des Versicherten - einen zeitnahen Rückruf von einem Arzt zur telefonischen Abklärung und Beratung über weitere Maßnahmen.

(3) **Bester Arzt, bester Therapeut**

Bei einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung unterstützt der Versicherer den Versicherten bei der Suche nach dem hinsichtlich

- des konkreten Beschwerdebildes am besten geeigneten Arzt, bzw.
- der ärztlich empfohlenen Maßnahmen am besten geeigneten Therapeuten.

Bei einer notwendigen medizinischen Heilbehandlung nennt der Versicherer auf Wunsch des Versicherten einen Spezialisten, wenn eine Therapie bzw. ein Eingriff von einem Arzt bereits geplant ist (Ärztliche Zweitmeinung (Second Opinion)).

(4) **Herstellung der Verbindung**

erfolgt nur auf Wunsch des Versicherten.

Der Versicherer stellt nur den erstmaligen Kontakt her, in weiterer Folge wendet sich der Versicherte selbst an den Arzt/Therapeuten, die medizinische Einrichtung oder den Gesundheitsdienst.

(5) **Haftungsausschluss**

Durch die Informationsleistung bzw. Herstellung der Verbindung gewährleistet der Versicherer nicht die Verfügbarkeit der Leistungen des betreffenden Arztes/Therapeuten, Gesundheitsdienstes oder der medizinischen Einrichtung in einem bestimmten Umfang oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes.

(6) **Leistungen des persönlichen GesundheitsCoaches**

werden für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten durch dafür qualifizierte Mitarbeiter eines Vertragspartners des Versicherers erbracht.

Dieser Zeitraum beginnt:

- Bei der Begleitung während der Genesung und Unterstützung bei der besseren Bewältigung der durch den Versicherungsfall bedingten Lebenssituation mit der medizinisch notwendigen ambulanten Heilbehandlung
- Bei der Erarbeitung einer Strategie zur Reduktion von Risikofaktoren und Unterstützung bei Maßnahmen zur Umstellung hin zu einem gesünderen Lebensstil mit der erstmaligen Kontaktaufnahme mit dem GesundheitsCoach

Der Versicherer trägt die Kosten der Begleitung und Unterstützung durch den persönlichen GesundheitsCoach, leistet jedoch keinen Kostenersatz für von diesem erarbeitete oder vorgeschlagene Maßnahmen (z.B. Kosten gesünderer Lebensmittel oder eines Fitnesstrainings).

(7) **Medizinische Online Sprechstunde**

durch Experten eines Vertragspartners des Versicherers:

1. Beratung durch einen Arzt (bestimmte Fachgebiete) bei Beschwerden, Krankheit oder nach Unfall
2. Erklärung eines medizinischen Befundes durch einen Arzt (bestimmte Fachgebiete)
3. Information über Wirkung und Wechselwirkung verordneter Medikamente durch einen Pharmazeuten

Der Versicherte kann die Leistungen gemäß Pkt. 1 - 3 jeweils fünfmal pro Kalenderjahr in Anspruch nehmen. Der Versicherer verrechnet die Kosten direkt mit dem Vertragspartner.

Die Zusage für die Inanspruchnahme der Medizinischen Online Sprechstunde gilt, solange eine Vereinbarung mit einem Vertragspartner besteht.

(8) **Nachweis der Anspruchsvoraussetzungen**

Außer bei "Hilfe im Notfall" kann der Versicherer verlangen, dass der Versicherte die Anspruchsvoraussetzungen der oben angeführten Leistungen durch entsprechende medizinische Unterlagen (ärztliche Befunde, Rezepte für Arzneien, etc.) nachweist.

§ 11

Änderung der Prämie und des Versicherungsschutzes

Der Tarif AJS unterliegt der Anpassung gemäß § 17 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017.

§ 12

Tarifabrechnungsverband

Die Versicherungen nach Tarif AJS gehören zum Tarifabrechnungsverband H (siehe § 18 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017) und berechtigen bei Leistungsfreiheit zu einer Prämienrückvergütung in Höhe von 15% der für das Kalenderjahr vorgeschriebenen, abgegrenzten Jahresprämie.

Im Falle einer Gruppenkrankenversicherung kann für die Prämienrückvergütung aus dem Tarif AJS im Gruppenvertrag eine abweichende Vereinbarung getroffen werden.

Ergänzende Versicherungsbedingungen für MedCare: Baby-Option - Tarif BHO (EB_BHO)

Vertragspartner

Diese Vertragsgrundlagen gelten für Verträge mit der Generali Versicherung AG, 1010 Wien, Landskrongasse 1-3.

Aufsichtsbehörde

Finanzmarktaufsicht, 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5



§ 1

Inhalt der MedCare: Baby-Option

- (1) Die MedCare: Baby-Option gilt für leibliche Kinder eines Versicherten, die nach dem in der Polizze angeschriebenen Datum geboren werden.
- (2) Die MedCare: Baby-Option berechtigt den Versicherungsnehmer, innerhalb des ersten Lebensjahres des neugeborenen Kindes für dieses eine Krankenversicherung gemäß Abs. 3 abzuschließen.
Mit Vollendung des ersten Lebensjahres ist die MedCare: Baby-Option für das betreffende neugeborene Kind erloschen.
- (3) Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, für das neugeborene Kind eine Krankenversicherung innerhalb von zwei Monaten ab dem Tag der Geburt mit Wirkung ab dem Tag der Geburt, danach ab dem Tag der Antragstellung abzuschließen.

Der Versicherungsnehmer kann dabei aus den Tarifen des Versicherten wählen, die

- zum Zeitpunkt der Geburt versichert sind und
- nach den Annahmerichtlinien des Versicherers für Kinder abgeschlossen werden können.

Wird ein versicherter Tarif im Neuverkauf nicht mehr angeboten, ist der Versicherungsnehmer berechtigt, für das neugeborene Kind den entsprechenden Nachfolgetarif abzuschließen.

Der Abschluss der Krankenversicherung für das neugeborene Kind erfolgt bis zur Höhe des Versicherungsschutzes des Versicherten ohne Risikoprüfung und ohne Wartezeiten.

Der Abschluss eines darüber hinausgehenden Versicherungsschutzes ist vom Ergebnis einer Risikoprüfung abhängig.

- (4) Aus der Krankenversicherung des neugeborenen Kindes wird für den Krankenhausaufenthalt aufgrund der erfolgten Entbindung und den darüber hinausgehenden Aufenthalt des Kindes mit konservativer Behandlung (z.B. Inkubator) keine Leistung erbracht.
Aufenthalte für Operationen des neugeborenen Kindes werden als Versicherungsfall anerkannt.

Wenn für das neugeborene Kind kein Sozialversicherungsschutz begründet werden kann, besteht im Rahmen der versicherten Tarife Versicherungsschutz auch für den Aufenthalt des Kindes mit konservativer Behandlung.

- (5) Der für das neugeborene Kind vereinbarte Versicherungsschutz wird ab dem Tag der Geburt für ein halbes Jahr prämienfrei geboten, sofern er mindestens für drei Jahre bestehen bleibt.

§ 2

Dauer und Beendigung der MedCare: Baby-Option

- (1) Der Versicherungsnehmer kann die MedCare: Baby-Option
 - zu jedem Monatsersten mit einer Frist von drei Monaten,
 - bei Ausübung der MedCare: Baby-Option zum selben Zeitpunkt,kündigen.
- (2) Wird im Vertrag keine besondere Vereinbarung getroffen, endet die MedCare: Baby-Option mit dem Monatsersten, der auf die Vollendung des 50. Lebensjahres des Versicherten folgt.

Der Versicherer erstellt in diesem Fall eine neue Polizze ohne den Tarif BHO.

Der Versicherungsnehmer hat innerhalb von 4 Wochen ab Erhalt der Polizze Anspruch auf den neuerlichen Abschluss der MedCare: Baby-Option.

§ 3

Änderung der Prämie und des Versicherungsschutzes

Der Tarif BHO unterliegt der Anpassung gemäß

- § 18 AVBKV 2012 / AVBKVG 2012 bzw.
- § 17 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017.

Ergänzende Versicherungsbedingungen für Krankengeld nach Spitalsaufenthalt - Tarif KSH (EB_KSH)

Vertragspartner

Diese Vertragsgrundlagen gelten für Verträge mit der Generali Versicherung AG, 1010 Wien, Landskronergasse 1-3.

Aufsichtsbehörde

Finanzmarktaufsicht, 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5



§ 1

Tarifkombination

Der Tarif KSH kann nur in Verbindung mit einer auf denselben Versicherten abgeschlossenen Krankenhauskosten- oder Krankentagegeldversicherung (Haupttarif) versichert werden.

Wird der Haupttarif beendet, endet der Tarif KSH in demselben Zeitpunkt.

§ 2

Krankengeld nach stationärer Heilbehandlung

- (1) Das Krankengeld wird bezahlt, wenn der Versicherte unmittelbar nach einer stationären Heilbehandlung wegen
- Krankheit
 - Schwangerschaft, Entbindung oder Fehlgeburt
 - Unfallfolgen
- völlig (100%) arbeitsunfähig ist.

Soweit nachstehend auf „Arbeitsunfähigkeit“ Bezug genommen wird, ist darunter ausschließlich die völlige (100%)ige Arbeitsunfähigkeit (siehe unten Abs. 2 Pkt. 1) zu verstehen.

Voraussetzung für die Leistung des Krankengeldes ist eine stationäre Heilbehandlung im Sinne des

- § 5 B) Abs. 8 AVBKV 2012 / AVBKVG 2012, bzw.
- § 5 C) Abs. 10 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017.

Für Arbeitsunfähigkeit infolge tagesklinischer Heilbehandlung und infolge stationärer Heilbehandlung in Anstalten gemäß

- § 5 B) Abs. 9 AVBKV 2012 / AVBKVG 2012, bzw.
- § 5 C) Abs. 11 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017

erfolgt jedenfalls keine Leistung.

Eine tagesklinische Heilbehandlung in einem Krankenhaus liegt vor, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Art der Heilbehandlung erfordert üblicherweise einen Aufenthalt von mindestens 24 Stunden,
- der Versicherte wird noch am Tag der Aufnahme aus dem Krankenhaus entlassen und
- für die Heilbehandlung wird die Infrastruktur einer Abteilung des Krankenhauses in Anspruch genommen (z.B. Aufnahme in die Bettenstation, Benutzung eines Operationssaales).

Im Falle einer Entbindung wird bei Vorliegen der nachstehend beschriebenen Anspruchsvoraussetzungen das Krankengeld auch bei Arbeitsunfähigkeit infolge einer Hausgeburt bezahlt.

(2) Vollständige Arbeitsunfähigkeit

1. Der Versicherungsfall beginnt, wenn der Versicherte seine berufliche Tätigkeit (selbstständige Erwerbstätigkeit, ständiges Dienst- oder Arbeitsverhältnis gegen Entgelt) nach objektivem ärztlichen Urteil in keiner Weise ausüben kann, sie auch nicht ausübt und keiner anderen Erwerbstätigkeit nachgeht, also weder mitarbeitend noch aufsichtsführend oder leitend in seinem Beruf tätig sein kann.
Der Versicherungsfall endet, wenn der Versicherte nach medizinischem Befund wieder teilweise oder völlig arbeitsfähig wird oder eine berufliche Tätigkeit ausübt.

Übt der Versicherte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles seine berufliche Tätigkeit vorübergehend nicht aus (z.B. Bezug von Arbeitslosengeld, Bildungskarenz, Bezug von Kinderbetreuungsgeld), wird die Dauer der Arbeitsunfähigkeit nach allgemeiner medizinischer Erfahrung bzw. nach Maßgabe der Beeinträchtigung körperlicher oder geistiger Funktionen ermittelt.

2. Die Arbeitsunfähigkeit muss in einem ursächlichen Zusammenhang mit der Krankheit, Schwangerschaft/Entbindung/Fehlgeburt oder den Unfallfolgen stehen, aufgrund derer die stationäre Heilbehandlung medizinisch erforderlich war.
Die Arbeitsunfähigkeit muss darüber hinaus unmittelbar nach Ende des stationären Aufenthalts vorhanden sein. Die Unmittelbarkeit ist gegeben, wenn die Arbeitsunfähigkeit von einem Arzt spätestens am nächsten, auf die Entlassung aus dem Krankenhaus folgenden Werktag bestätigt wird.

§ 3

Art und Umfang des Versicherungsschutzes

- (1) Das Krankengeld wird innerhalb der maximalen Leistungszeiträume (Abs. 2) bei Aufenthalt in Österreich unter Einschluss der Sonn- und Feiertage bezahlt.
Der Anspruch auf Krankengeld endet mit dem nachgewiesenen letzten Tag der Arbeitsunfähigkeit, jedenfalls jedoch mit Erreichen der maximalen tariflichen Leistungsdauer gemäß Abs. 2.
- (2) Das Krankengeld wird für höchstens folgende Zeiträume bezahlt:

Bei Arbeitsunfähigkeit gemäß § 2 infolge von
 1. Krankheit oder Unfallfolgen
 - je Krankenhausaufenthalt innerhalb und bis zu 28 Tage ab Entlassung aus stationärer Heilbehandlung,
 - bei mehreren Krankenhausaufenthalten bis zu 42 Tage im Kalenderjahr.
Die Zuordnung eines Krankenhausaufenthalts zu einem Kalenderjahr erfolgt nach dem Aufnahmetag.
2. Schwangerschaft, Entbindung oder Fehlgeburt nach einem oder mehreren Krankenhausaufenthalten bis zu 14 Tage pro Schwangerschaft.
- (3) Das versicherte Krankengeld darf nicht mehr als das auf den Tag umgerechnete durchschnittliche Nettoeinkommen der letzten 12 Monate vor jeweils eingetretener Arbeitsunfähigkeit betragen. Bei Minderung des monatlichen Nettoeinkommens sind das versicherte Krankengeld und die Prämie entsprechend der Minderung mit Wirkung vom Beginn des zweiten Monats nach Kenntnis herabzusetzen.
- (4) Der Versicherer ist berechtigt, jederzeit vom Versicherungsnehmer den Nachweis zu verlangen, dass das versicherte Krankengeld das auf den Tag umgerechnete Nettoeinkommen des Versicherten in den letzten 12 Monaten vor jeweils eingetretener Arbeitsunfähigkeit nicht übersteigt.

§ 4

Obliegenheiten

In Ergänzung zu

- § 11 AVBKV 2012 / AVBKVG 2012 bzw.
 - § 10 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017
- gelten folgende Obliegenheiten als vereinbart:

Obliegenheit vor Eintritt des Versicherungsfalles

- (1) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüglich den Zeitpunkt mitzuteilen, zu welchem die Voraussetzungen zur Aufrechterhaltung des Versicherungsvertrages gemäß § 6 Abs. 1 entfallen oder eine Minderung des monatlichen Nettoeinkommens aus selbständiger oder unselbständiger Tätigkeit (§ 3 Abs. 3) eingetreten ist.

Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

- (2) Nach Eintritt des Versicherungsfalles sind folgende Obliegenheiten einzuhalten:
 - a) Die Arbeitsunfähigkeit ist spätestens innerhalb 1 Woche nach deren Eintritt in geschriebener Form unter Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses mit Angabe der Diagnose zu melden. Zeugnisse und Bescheinigungen von Ärzten, die mit dem Versicherten in auf- oder absteigender Linie verwandt oder mit ihm verheiratet sind, sowie von nicht in Österreich niedergelassenen Ärzten werden nicht anerkannt.
Bei Anmeldung eines Leistungsanspruchs aufgrund Arbeitsunfähigkeit infolge einer Entbindung ist die Vorlage der Geburtsurkunde des neugeborenen Kindes ausreichend.
 - b) Die Arbeitsunfähigkeit ist auf Verlangen des Versicherers durch dessen Vertrauensärzte feststellen zu lassen.
 - c) Die Wiedererlangung der teilweisen Arbeitsfähigkeit ist ebenfalls mittels ärztlicher Bestätigung im Sinne von Pkt. a) unverzüglich bekannt zu geben.
 - d) Den zumutbaren Anforderungen des Arztes ist Folge zu leisten und alles zu vermeiden, was der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit hinderlich sein könnte.

§ 5

Kündigung durch den Versicherer

In Abweichung von

- § 14 Abs. 1 AVBKV 2012 / AVBKVG 2012 bzw.
- § 13 Abs. 1 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017

hat der Versicherer auch das Recht, das Versicherungsverhältnis zum Ende eines jeden Versicherungsjahres mit einer Frist von drei Monaten zu kündigen.

§ 6

Sonstige Beendigungsgründe

(1) Der Versicherungsvertrag endet in den folgenden Fällen:

- a) Bei nicht nur vorübergehendem Fortfall jeglichen Erwerbseinkommens aus selbstständiger oder unselbstständiger Tätigkeit.
- b) Bei Eintritt der dauernden Berufsunfähigkeit des Versicherten. Eine solche liegt vor, wenn der Versicherte im bisher ausgeübten Beruf auf nicht absehbare Zeit mehr als 50% erwerbsunfähig ist.
- c) Bei Pensionsantritt des Versicherten.
- d) Spätestens jedenfalls bei Vollendung des 65. Lebensjahres.

(2) In den Fällen des Abs. 1 Pkt. a.) – d.) endet der Versicherungsvertrag mit dem auf den jeweiligen Umstand folgenden Monatsersten.

Eine Leistung für zum Zeitpunkt des Vertragsendes laufende Versicherungsfälle wird innerhalb der maximalen Leistungszeiträume (§ 3 Abs. 2) bezahlt.

§ 7

Änderungen der Prämie und des Versicherungsschutzes

(1) Der Tarif KSH unterliegt der Anpassung gemäß

- § 18 AVBKV 2012 / AVBKVG 2012, bzw.
- § 17 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017.

Indexvereinbarung

(2) Der für Änderungen der Prämie oder des Versicherungsschutzes gemäß § 178f Abs 2 Z 1 VersVG maßgebliche Index ist der von der Bundesanstalt "Statistik Österreich" (FN 191155k) veröffentlichte Verbraucherpreisindex VPI 2010 oder, wenn dieser Index nicht mehr veröffentlicht wird, der an dessen Stelle tretende Index ("VPI").

(3) Der Versicherer ist berechtigt, die Leistungen gemäß dem VPI (siehe oben Abs. 2) und, aus Anlass einer Leistungsänderung auch die Prämie, wie folgt zu ändern:

1. Der Tarif KSH ist ein sogenannter Stufentarif mit Grundtarifstufe 1.
Die Leistungen der Grundtarifstufe sind unabhängig vom Lebensalter des Versicherten gleich hoch. Die Höhe der Prämie für die Grundtarifstufe ist je nach Alter des Versicherten zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses unterschiedlich.
Die Höhe der in der Polizza konkret vereinbarten Tarifleistungen wird durch die Anzahl der versicherten Grundtarifstufen bestimmt.
2. Ausgangsbasis ist die Indexzahl für Juli des Kalenderjahres, das dem Vertragsabschluss oder der letzten Vertragsänderung (worunter Indexanpassungen und andere Änderungen der Leistung zu verstehen sind) vorangegangen ist.
3. Der Versicherer ermittelt Indexänderungen vor Ablauf eines jeden Kalenderjahres für das nächste Kalenderjahr. Vergleichswert ist die für Juli des aktuellen Kalenderjahres veröffentlichte Indexzahl.
Eine Anpassung aufgrund einer Indexveränderung erfolgt frühestens nach Ablauf eines Jahres nach Vertragsabschluss oder der letzten Vertragsänderung.
4. Der Faktor, um den der Vergleichswert höher oder niedriger als die Ausgangsbasis ist, wird mit der Anzahl der Grundtarifstufen, die jeweils aktuell versichert sind, multipliziert.

5. Ist das Ergebnis um eine oder mehr Grundtarifstufen höher oder niedriger als die aktuelle Anzahl der Grundtarifstufen, dann wird die Anzahl der Grundtarifstufen um diese Differenz - kaufmännisch gerundet auf die nächste ganze Zahl an Grundtarifstufen - erhöht oder vermindert.
Ergibt die Indexveränderung eine Differenz von weniger als einer Grundtarifstufe, so wird sie auf den nächsten Vergleichszeitraum vorgetragen und bei einer späteren Indexanpassung berücksichtigt.
6. Die Prämie für die zusätzlichen oder in Abzug zu bringenden Grundtarifstufen wird mit dem aktuellen Alter des Versicherten zum Zeitpunkt der Anpassung berechnet.
- (4) Daraus resultierende Änderungen der Prämie und des Versicherungsschutzes wird der Versicherer dem Versicherungsnehmer vor Ablauf des Kalenderjahres zusenden. Sie wirken gemäß § 178f Abs 4 VersVG ab dem dieser Absendung folgenden Monatsersten, dh ab dem 1. Jänner des Folgejahres.
- (5) Wenn der Versicherungsnehmer mit der zugesandten Änderung nicht einverstanden ist, kann er das dem Versicherer bis 31. Jänner des Folgejahres mitteilen. Dann findet die Änderung für den Vertrag nicht statt. Auf dieses Recht wird der Versicherer den Versicherungsnehmer in der Verständigung von der Änderung der Prämie und des Versicherungsschutzes gesondert hinweisen.
- (6) Beispiele zur oben beschriebenen Indexanpassung sind auf der Homepage www.generali.at veröffentlicht.

Ergänzende Versicherungsbedingungen für MedCare: Sonderklasse - Tarife SJ und SJR (EB_SJ_SJR_17)

Vertragspartner

Diese Vertragsgrundlagen gelten für Verträge mit der Generali Versicherung AG, 1010 Wien, Landskronergasse 1-3.

Aufsichtsbehörde

Finanzmarktaufsicht, 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5



§ 1

Kostenübernahme in Krankenanstalten

(1) Kostenübernahme in den Vertragskrankenhäusern in Österreich laut Krankenhausverzeichnis

Nimmt der Versicherte eine Behandlung in einem Vertragskrankenhaus in Österreich in Anspruch, so werden die vereinbarten Kosten einschließlich der ärztlichen Honorare anstelle der tariflichen Leistungen in voller Höhe übernommen und mit dem Krankenhaus direkt verrechnet.

(2) Kostenübernahme in Europa (Europaliste)

Nimmt der Versicherte eine Behandlung in einem allgemeinen öffentlichen Krankenhaus im europäischen Ausland (siehe Krankenhausverzeichnis/Europaliste) in Anspruch, so werden die Kosten der Pflege und Verpflegung, von Operationen und Behandlung einschließlich der ärztlichen Honorare anstelle der tariflichen Leistungen in voller Höhe übernommen.

(3) Weltweite Kostenübernahme

Nimmt der Versicherte eine Behandlung in einem allgemeinen öffentlichen Krankenhaus außerhalb Österreichs und Europas (siehe Europaliste) in Anspruch, so werden die Kosten der Pflege und Verpflegung, von Operationen und Behandlung einschließlich der ärztlichen Honorare anstelle der tariflichen Leistungen in voller Höhe übernommen, wenn

- a) die Behandlung in Österreich gleichwertig nicht durchgeführt werden kann, diese ärztlich empfohlen wurde und der Versicherer vorher eine Kostenübernahmeerklärung abgegeben hat. Der Versicherer gibt eine Kostenübernahmeerklärung ab, wenn er über die geplante Behandlung informiert wurde und dadurch Gelegenheit hatte, vor Beginn der Behandlung mit dem betreffenden Krankenhaus über die Höhe der Kosten Einvernehmen herzustellen.
- b) wegen eines Unfalles oder einer akut auftretenden Erkrankung während eines Aufenthaltes mit einer geplanten Dauer von bis zu 6 Wochen in diesen Ländern eine Heilbehandlung medizinisch notwendig und eine Rückkehr nach Österreich aus medizinischen Gründen nicht möglich ist.

Bei Kostenübernahme gemäß Pkt. a) wird der für "Kosten des Krankenhaus- und Heimtransportes" festgesetzte Betrag verzehnfacht.

(4) Krankenhausverzeichnis - Garantietarife - Europaliste

Die Vertragskrankenhäuser in Österreich und die Länder der Europaliste sind im Krankenhausverzeichnis angeführt. Für alle Vertragskrankenhäuser sind für die volle Kostenübernahme zumindest erforderliche Tarifstufen definiert (Garantietarife).

Die Kostenübernahme aufgrund des versicherten Tarifs ist in der Polizze beschrieben.

Diese allgemeine Kostendeckungszusage kann im Sinn des § 178c VersVG vom Versicherer in geschriebener Form widerrufen werden. Der Widerruf wird nach Ablauf von drei Wochen wirksam.

(5) Selbstbehalt

1. Selbstbehalt bei Krankheit

Ist der versicherte Tarif niedriger als der für das betreffende Krankenhaus bzw. die betreffende Zimmerkategorie gültige Garantietarif, so gilt die Kostenübernahme (Abs. 1 bis 3) mit dem auf der Polizze angeschriebenen Selbstbehalt pro Aufenthaltstag vereinbart.

Dieser Selbstbehalt ist je Kalenderjahr für höchstens 5 Tage zu bezahlen.

Erstreckt sich ein Krankenhausaufenthalt über den Jahreswechsel hinaus, ist auch für diesen Aufenthalt der Selbstbehalt mit höchstens 5 Tagen begrenzt.

Bei mehreren Krankenhausaufenthalten in unterschiedlichen Krankenhäusern oder Zimmerkategorien innerhalb eines Kalenderjahres sind ab dem 6. Aufenthaltstag die jeweils 5 höchsten Selbstbehalte maßgeblich.

Ist für das betreffende Krankenhaus bzw. die betreffende Zimmerkategorie ein Selbstbehalt vereinbart, der höher ist als die bisher verrechneten Selbstbehalte, so ist dieser höhere Selbstbehalt zu bezahlen. Von diesem wird der jeweils

niedrigste bereits bezahlte Selbstbehalt abgezogen und nur die Differenz vorgeschrieben.

2. Selbstbehalt bei Unfall

Innerhalb von 2 Jahren ab dem Unfalltag gilt die Kostenübernahme (Abs. 1 - 3) ohne die Selbstbehalte, die in der Polizze für die vereinbarte Zimmerkategorie angeführt sind.

Lautet die vereinbarte Zimmerkategorie auf "Zweibettzimmer", wird der Differenzbetrag auf den anzuwendenden höheren Selbstbehalt für "Einbettzimmer" verrechnet.

Neue oder erhöhte Selbstbehalte gemäß Abs. 8 werden jedoch auch nach Unfall bei Kostenübernahme in der vereinbarten Zimmerkategorie verrechnet.

2.1 Ein Unfall liegt vor, wenn der Versicherte durch ein plötzlich von außen auf seinen Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.

2.2 Als Unfall gelten auch:

- a) Zerreißen von an Gliedmaßen und an der Wirbelsäule befindlichen Muskeln, Sehnen, Bändern und Kapseln sowie Meniskusverletzungen infolge plötzlicher Abweichung vom geplanten Bewegungsablauf, wenn sie innerhalb von 7 Tagen ab dem Ereignistag medizinisch dokumentiert und ärztlich behandelt wurden.
- b) Bandscheibenhernien, wenn sie durch eine plötzliche, erhebliche direkte Gewalteinwirkung auf das jeweilige Segment der Wirbelsäule verursacht werden, und
 - diese durch Kraft und Richtung in der Lage war, eine gesunde Bandscheibe zu zerreißen, die bildgebende Untersuchung nach dem Unfall (wie MRT, Röntgen) keine degenerativen Veränderungen zeigt und vor dem Unfall keine Wirbelsäulenbeschwerden bestanden; oder
 - Frakturen ober- oder unterhalb der geschädigten Bandscheibe vorliegen; oder
 - es zu Bänderrissen im Bereich der Wirbelsäule mit Wirbelverrenkungen gekommen ist.
- c) Bauch- und Unterleibsbrüche, wenn sie durch eine plötzlich von außen kommende mechanische Einwirkung direkt herbeigeführt worden sind und nicht anlagenbedingt waren.

2.3 Als Unfälle gelten nicht:

- a) Fehl- und Frühgeburten, die durch einen Unfall herbeigeführt worden sind;
- b) Unfälle als Folgen einer Krankheit.

(6) Differenztagegeld in Vertragskrankenhäusern in Österreich

Besteht Versicherungsschutz nach einem Tarif, der höher ist als für die volle Kostenübernahme lt. gültigem Garantietarif erforderlich, wird für jeden Tag des Aufenthaltes ein Differenztagegeld geleistet.

Die Höhe des Differenztagegeldes ergibt sich aus der Differenz zwischen der Anzahl der Tarifstufen des versicherten Tarifes und des für die volle Kostenübernahme erforderlichen Garantietarifes, multipliziert mit dem für die Grundtarifstufe SJ1/SJR1 vorgesehenen Betrag von EUR 0,15.

(7) Gesetzliche Krankenversicherung

Abhängig von der gesetzlichen Krankenversicherung des Versicherten erfolgt die Kostenübernahme unter der Voraussetzung der Erbringung der nachstehenden Leistungen durch Krankenversicherungsträger.

Ohne Leistung eines Krankenversicherungsträgers erfolgt keine Kostenübernahme (Abs. 1 - 3) und die Kosten der stationären Heilbehandlung werden bis zu den in der Polizze angeführten tariflichen Höchstbeträgen ersetzt:

- 1. Für gesetzlich Krankenversicherte nach ASVG (ÖGK usw.), BSVG (SVS - Bauern) und GSVG-Sachleistungsgruppe (SVS - Selbständige):
Der Krankenversicherungsträger erbringt eine Leistung für die Kosten der allgemeinen Gebührenklasse.
- 2. Für gesetzlich Krankenversicherte nach B-KUVG (BVAEB - Beamte):
Der Krankenversicherungsträger erbringt eine Leistung für die Kosten der allgemeinen Gebührenklasse und für einen Teil der Pflege- und/oder Sondergebühren einschließlich der Arzthonorare der Sonderklasse.

3. Für gesetzlich Krankenversicherte nach GSVG-Geldleistungsgruppe (SVS - Selbständige):
Der Krankenversicherungsträger erbringt eine Leistung für die Kosten der allgemeinen Gebührenklasse und für einen Teil der Pflege- und/oder Sondergebühren einschließlich der Arzthonorare der Sonderklasse.
4. Für Anspruchsberechtigte nach den Gemeinschaftsbestimmungen über die Soziale Sicherheit in der Europäischen Union (EU):
Der Versicherte ist aufgrund der Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und Nr. 988/2009 im Krankheitsfall in Österreich sachleistungsberechtigt und der Krankenversicherungsträger erbringt für den konkreten Krankenhausaufenthalt eine Leistung für die Kosten der allgemeinen Gebührenklasse.

(8) Änderung/Ende der gesetzlichen Krankenversicherung

Die Tarife SJ und SJR setzen voraus, dass der Versicherte gegenüber einem Träger der gesetzlichen Krankenversicherung anspruchsberechtigt ist.

Eine Änderung der gesetzlichen Krankenversicherung wirkt sich daher auf den Versicherungsschutz aus - insbesondere kann ein Selbstbehalt anfallen oder ein bestehender Selbstbehalt steigen. Wenn die gesetzliche Krankenversicherung endet, erfolgt keine Kostenübernahme (siehe oben Abs. 7) und die Kosten der stationären Heilbehandlung werden bis zu den in der Polize angeführten tariflichen Höchstbeträgen ersetzt.

Damit in diesen Fällen weiterhin ein geeigneter Versicherungsschutz besteht, ist es erforderlich, dass der Versicherungsnehmer den Versicherer umgehend verständigt.

§ 2

Direktverrechnung

Sofern eine Vereinbarung mit dem Leistungsträger (Krankenhaus, Arzt) besteht, erfolgt auf Grundlage dieser Vereinbarung die direkte Verrechnung der Kosten und Honorare zwischen dem Versicherer und dem Leistungserbringer.

Weitere Grundlage ist eine vom Versicherten vor Antritt der Heilbehandlung anzufordernde Kostenübernahmeerklärung. Die Art der Erkrankung und die Notwendigkeit der Heilbehandlung sind in dieser Anforderung medizinisch nachzuweisen. Lässt die Dringlichkeit der Heilbehandlung eine vorhergehende Anfrage nicht zu, ist diese spätestens drei Arbeitstage ab Antritt der Heilbehandlung nachzureichen.

Der Versicherte hat der Ermittlung von zum Zwecke der Direktverrechnung erforderlichen Daten zuzustimmen. Wird die Zustimmungserklärung verweigert, widerrufen oder verspätet erteilt und stellt der Leistungserbringer Kosten und Honorare dem Versicherten in Rechnung, ist der Versicherer diesem gegenüber nur in dem in der Vereinbarung über die Direktverrechnung festgelegten Ausmaß zur Leistung verpflichtet.

§ 3

Tagesklinische Behandlung in Krankenhäusern

Tagesklinische Heilbehandlungen sind Heilbehandlungen in einem Krankenhaus, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Art der Heilbehandlung erfordert üblicherweise einen Aufenthalt von mindestens 24 Stunden,
- der Versicherte wird noch am Tag der Aufnahme aus dem Krankenhaus entlassen, und
- für die Heilbehandlung wird die Infrastruktur einer Abteilung des Krankenhauses in Anspruch genommen (z.B. Aufnahme in der Bettenstation, Benutzung eines Operationssaales).

Heilbehandlungen und Operationen in der Ambulanz eines Krankenhauses stellen jedenfalls keine tagesklinischen Behandlungen dar.

§ 4

Ambulante Operationen in Krankenhäusern

- (1) Ambulante Operationen sind
 - medizinisch notwendige operative Eingriffe ab Operationsgruppe 3,
 - die üblicherweise einen Aufenthalt von mindestens 24 Stunden erfordern und
 - in Krankenhäusern oder tagesklinischen Einrichtungen, die sowohl rechtlich, wirtschaftlich als auch organisatorisch an ein bettenführendes Krankenhaus angegliedert sind, durchgeführt werden.

Das für die Einstufung eines Eingriffs maßgebliche Operationsgruppenschema kann auf der Homepage des Versicherers unter folgendem Link eingesehen werden:

<https://www.generali.at/service/krankenversicherung-operationsgruppenschema.html>

Für ambulante Operationen in selbstständigen Tageskliniken oder in Ordinationen niedergelassener Fachärzte werden keine Leistungen erbracht.

- (2) Der Versicherer ersetzt die Kosten einer ambulanten Operation, sofern der Versicherte diese zuvor bei seinem Sozialversicherungsträger im Wege der Voreinreichung geltend gemacht hat. Der Versicherer leistet Kostenersatz abzüglich der Leistung des Sozialversicherungsträgers.

§ 5

Akut-Geriatrie und Remobilisation

Für medizinisch notwendige stationäre Akut-Geriatrie und Remobilisation im Anschluss an eine stationäre Heilbehandlung wird eine Leistung für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr erbracht.

Erfolgen Akut-Geriatrie bzw. Remobilisation in einem Krankenhaus (Abteilung), mit dem der Versicherer dafür einen Vertrag abgeschlossen hat, werden die vereinbarten Kosten mit dem Vertragskrankenhaus gemäß § 2 direkt verrechnet. In allen übrigen Fällen wird das dafür im Leistungstarif angeführte Ersatztagelohn ausbezahlt.

§ 6

Hospiz, Palliativstation

Für medizinisch notwendige stationäre Aufenthalte in einem Hospiz oder einer Palliativstation eines Krankenhauses wird eine Leistung für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr erbracht.

Erfolgt der Aufenthalt in einer Einrichtung, mit der der Versicherer dafür einen Vertrag abgeschlossen hat, werden die vereinbarten Kosten mit der Vertragseinrichtung gemäß § 2 direkt verrechnet. In allen übrigen Fällen wird das dafür im Leistungstarif angeführte Ersatztagelohn ausbezahlt.

§ 7

Tarifliche Leistungen

(1) Umfang einzelner tariflicher Leistungen

1. Tageskosten

umfassen die zu bezahlenden Kosten für Verpflegs- und Krankenhausgebühren (für die Unterbringung, Pflege und Verpflegung).

2. Behandlungshonorar

umfasst alle ärztlichen Honorare (auch Honorare für Hebammen) ausgenommen die Honorare für technische Untersuchungen wie bildgebende Verfahren, Labor, Nuklearmedizin etc.

Soweit Kosten aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Vereinbarungen mit dem Versicherer betraglich geregelt sind, ist der Versicherer zum Ersatz darüber hinausgehender Kosten (z.B. Sonderhonorare der Vorstände von Universitätskliniken gemäß § 46 KaKuG und ausführende Landesgesetze) nicht verpflichtet.

3. Technische Leistungen

umfassen die Honorare für technische Untersuchungen wie bildgebende Verfahren, Labor, Nuklearmedizin etc. und sämtlichen Sachaufwand einschließlich der Kosten für Benützung des Operationssaales, der Arzneimittel (Heilmittel) und Heilbehelfe (abweichend von § 5 A) Abs. 1, 2 und 4 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017).

(2) Stationäre Heilbehandlung in Krankenhäusern

Bei stationärer Heilbehandlung in Krankenhäusern, die im Krankenhausverzeichnis nicht enthalten sind, werden für die Kosten des Aufenthaltes die Leistungen gemäß der für

- Tageskosten,
- Behandlungshonorar,
- Technische Leistungen, und
- Summenleistung

festgesetzten Beträgen erbracht.

(3) Tagesklinische Heilbehandlung in Krankenhäusern

Für tagesklinische Heilbehandlungen in Krankenhäusern, mit denen dafür keine vertraglichen Vereinbarungen über die Kostenübernahme bestehen, werden für die Kosten die folgenden tariflichen Leistungen wie für eine eintägige stationäre Heilbehandlung erbracht:

- Tageskosten,
- Behandlungshonorar,

- Technische Leistungen und
- Summenleistung.

(4) **Ambulante Operationen in Krankenhäusern**

Für ambulante Operationen in Krankenhäusern oder an diese angegliederten tagesklinischen Einrichtungen, mit denen dafür keine vertraglichen Vereinbarungen über die Kostenübernahme bestehen, wird das tarifliche Behandlungshonorar für die betreffende Operationsgruppe bezahlt.

§ 8

GesundheitsCoaching

(1) **Informationen über medizinische Einrichtungen und Gesundheitsdienste**

werden bei einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung zu folgenden Themen erteilt:

- Medizinische Einrichtungen weltweit,
- Krankenanstalten in Österreich (öffentlich, privat),
- Transporteinrichtungen in Österreich.

1. **Informationen über medizinische Einrichtungen außerhalb Österreichs**

werden erteilt, wenn für die spezielle medizinische Behandlung kein geeigneter Arzt bzw. keine geeignete medizinische Behandlung in Österreich vorhanden oder ärztliche Hilfe während eines Auslandsaufenthaltes erforderlich ist.

2. **Informationen über Transporteinrichtungen in Österreich**

werden erteilt, wenn der Versicherte aufgrund der Art der Erkrankung bzw. durch die Unfallfolgen oder wegen der ärztlich angeordneten Verhaltensmaßregeln außerstande ist, den Arzt oder die medizinische Einrichtung aus eigener Kraft aufzusuchen.

(2) **Hilfe im Notfall**

Ein medizinischer Notfall liegt vor, wenn der Versicherte von einer unmittelbaren Gefahr (z.B. akute Erkrankung, Unfall, drohende Einwirkung schädigender Stoffe) für Leben, körperliche Unversehrtheit oder Gesundheit bedroht ist.

In allen medizinischen Notfällen ist der Versicherer rund um die Uhr erreichbar und

- unterstützt durch Herstellung der Verbindung und Organisation des Transports zu allen Notfalleinrichtungen in Österreich:
 - Nacht- und Wochenenddienste durch Ärzte für Allgemeinmedizin und Zahnärzte bzw. Apotheken, nächstgelegenes geeignetes Krankenhaus,
 - sonstige Notdienste (z.B. Rotes Kreuz, Vergiftungszentrale, psychosoziale Dienste)

oder

- veranlasst - abhängig vom Gesundheitszustand des Versicherten - einen zeitnahen Rückruf von einem Arzt zur telefonischen Abklärung und Beratung über weitere Maßnahmen.

(3) **Bester Arzt, bester Therapeut**

Bei einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung unterstützt der Versicherer den Versicherten bei der Suche nach dem hinsichtlich

- des konkreten Beschwerdebildes am besten geeigneten Arzt, bzw.
- der ärztlich empfohlenen Maßnahmen am besten geeigneten Therapeuten.

(4) **Ärztliche Zweitmeinung (Second Opinion)**

Bei einer notwendigen medizinischen Heilbehandlung nennt der Versicherer auf Wunsch des Versicherten einen Spezialisten, wenn eine Therapie bzw. ein Eingriff von einem Arzt bereits geplant ist.

(5) **Herstellung der Verbindung**

erfolgt nur auf Wunsch des Versicherten.

Der Versicherer stellt nur den erstmaligen Kontakt her, in weiterer Folge wendet sich der Versicherte selbst an den Arzt/Therapeuten, die medizinische Einrichtung oder den Gesundheitsdienst.

(6) **Haftungsausschluss**

Durch die Informationsleistung bzw. Herstellung der Verbindung gewährleistet der Versicherer nicht die Verfügbarkeit der Leistungen des betreffenden Arztes/Therapeuten, der medizinischen Einrichtung oder des Gesundheitsdienstes in einem bestimmten Umfang oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes.

(7) Leistungen des persönlichen GesundheitsCoaches

werden für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten durch dafür qualifizierte Mitarbeiter eines Vertragspartners des Versicherers erbracht.

Dieser Zeitraum beginnt

- bei der Begleitung während der Genesung und Unterstützung bei der besseren Bewältigung der durch den Versicherungsfall bedingten Lebenssituation mit der medizinisch notwendigen stationären Heilbehandlung;
- bei der Erarbeitung einer Strategie zur Reduktion von Risikofaktoren und Unterstützung bei Maßnahmen zur Umstellung hin zu einem gesünderen Lebensstil mit der erstmaligen Kontaktaufnahme des Versicherten mit dem GesundheitsCoach.

Der Versicherer trägt die Kosten der Begleitung und Unterstützung durch den persönlichen GesundheitsCoach, leistet jedoch keinen Kostenersatz für von diesem erarbeitete oder vorgeschlagene Maßnahmen (z.B. Kosten gesünderer Lebensmittel oder eines Fitnessstrainings).

(8) Nachweis der Anspruchsvoraussetzungen

Außer bei "Hilfe im Notfall" kann der Versicherer verlangen, dass der Versicherte die Anspruchsvoraussetzungen der oben angeführten Leistungen durch entsprechende medizinische Unterlagen (ärztliche Befunde, Rezepte für Arzneien, etc.) nachweist.

§ 9

Änderung der Prämie und des Versicherungsschutzes

- (1) Die Tarife SJ und SJR unterliegen der Anpassung gemäß § 17 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017.
- (2) In Ergänzung zu § 17 Abs. 1 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 gilt:
Kann in einem Bundesland über die Höhe der Krankenhauskosten und Honorare kein Einvernehmen hergestellt werden, wird der Anpassung die jeweilige Veränderung des von Statistik Austria verlautbarten Index der Verbraucherpreise zugrundegelegt.
- (3) In Ergänzung zu § 17 Abs. 2 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 gilt:
Ergibt der Vergleich der in § 17 Abs. 1 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 genannten Faktoren eine Änderung der zu erwartenden Leistungen um mindestens die in der Grundtarifstufe SJ1/SJR1 festgelegten Leistungen, so erfolgt eine Anpassung um die entsprechende Anzahl von Grundtarifstufen.
- (4) Ergibt der Vergleich der in § 17 Abs. 1 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 genannten Faktoren einen Änderungsbedarf für die Prämie der Grundtarifstufe SJ1/SJR1, so wird die Prämie der Grundtarifstufe SJ1/SJR1 entsprechend angepasst.
- (5) In Ergänzung zu § 17 Abs. 3 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 gilt:
Ob und in welchem Umfang der Versicherer zur Kostenübernahme (§ 1 Abs. 1 - 3) verpflichtet ist, ergibt sich aus der zuletzt gültigen Polizze.

Die nachfolgende Bestimmung des § 10 gilt nur für den Tarif SJR:

§ 10

Tarifabrechnungsverband

Die Versicherungen nach Tarif SJR gehören zum Tarifabrechnungsverband H (siehe § 18 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017) und berechtigen bei Leistungsfreiheit zu einer Prämienrückvergütung in Höhe von 15% der für das Kalenderjahr vorgeschriebenen, abgegrenzten Jahresprämie.

Ergänzende Versicherungsbedingungen für MedCare: Sonderklasse - Tarif SJKV (EB_SJKV_17)

Vertragspartner

Diese Vertragsgrundlagen gelten für Verträge mit der Generali Versicherung AG, 1010 Wien, Landskrongasse 1-3.

Aufsichtsbehörde

Finanzmarktaufsicht, 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5



§ 1

Kostenübernahme in Krankenanstalten

(1) Kostenübernahme in den Vertragskrankenhäusern in Österreich laut Krankenhausverzeichnis

Nimmt der Versicherte eine Behandlung in einem Vertragskrankenhaus in Österreich in Anspruch, so werden die vereinbarten Kosten einschließlich der ärztlichen Honorare anstelle der tariflichen Leistungen in voller Höhe übernommen und mit dem Krankenhaus direkt verrechnet.

(2) Kostenübernahme in Europa (Europaliste)

Nimmt der Versicherte eine Behandlung in einem allgemeinen öffentlichen Krankenhaus im europäischen Ausland (siehe Krankenhausverzeichnis/Europaliste) in Anspruch, so werden die Kosten der Pflege und Verpflegung, von Operationen und Behandlung einschließlich der ärztlichen Honorare anstelle der tariflichen Leistungen in voller Höhe übernommen.

(3) Weltweite Kostenübernahme

Nimmt der Versicherte eine Behandlung in einem allgemeinen öffentlichen Krankenhaus außerhalb Österreichs und Europas (siehe Europaliste) in Anspruch, so werden die Kosten der Pflege und Verpflegung, von Operationen und Behandlung einschließlich der ärztlichen Honorare anstelle der tariflichen Leistungen in voller Höhe übernommen, wenn

- a) die Behandlung in Österreich gleichwertig nicht durchgeführt werden kann, diese ärztlich empfohlen wurde und der Versicherer vorher eine Kostenübernahmeerklärung abgegeben hat. Der Versicherer gibt eine Kostenübernahmeerklärung ab, wenn er über die geplante Behandlung informiert wurde und dadurch Gelegenheit hatte, vor Beginn der Behandlung mit dem betreffenden Krankenhaus über die Höhe der Kosten Einvernehmen herzustellen.
- b) wegen eines Unfalles oder einer akut auftretenden Erkrankung während eines Aufenthaltes mit einer geplanten Dauer von bis zu 6 Wochen in diesen Ländern eine Heilbehandlung medizinisch notwendig und eine Rückkehr nach Österreich aus medizinischen Gründen nicht möglich ist.

Bei Kostenübernahme gemäß Pkt. a) wird der für "Kosten des Krankenhaus- und Heimtransportes" festgesetzte Betrag verzehnfacht.

(4) Krankenhausverzeichnis - Garantietarife - Europaliste

Die Vertragskrankenhäuser in Österreich und die Länder der Europaliste sind im Krankenhausverzeichnis angeführt. Für alle Vertragskrankenhäuser sind für die volle Kostenübernahme zumindest erforderliche Tarifstufen definiert (Garantietarife).

Die Kostenübernahme aufgrund des versicherten Tarifs ist in der Polizze beschrieben.

Diese allgemeine Kostendeckungszusage kann im Sinn des § 178c VersVG vom Versicherer in geschriebener Form widerrufen werden. Der Widerruf wird nach Ablauf von drei Wochen wirksam.

(5) Selbstbehalt

1. Selbstbehalt bei Krankheit

Ist der versicherte Tarif niedriger als der für das betreffende Krankenhaus bzw. die betreffende Zimmerkategorie gültige Garantietarif, so gilt die Kostenübernahme (Abs. 1 bis 3) mit dem auf der Polizze angeschriebenen Selbstbehalt pro Aufenthaltstag vereinbart.

Dieser Selbstbehalt ist je Kalenderjahr für höchstens 5 Tage zu bezahlen.

Erstreckt sich ein Krankenhausaufenthalt über den Jahreswechsel hinaus, ist auch für diesen Aufenthalt der Selbstbehalt mit höchstens 5 Tagen begrenzt.

Bei mehreren Krankenhausaufenthalten in unterschiedlichen Krankenhäusern oder Zimmerkategorien innerhalb eines Kalenderjahres sind ab dem 6. Aufenthaltstag die jeweils 5 höchsten Selbstbehalte maßgeblich.

Ist für das betreffende Krankenhaus bzw. die betreffende Zimmerkategorie ein Selbstbehalt vereinbart, der höher ist als die bisher verrechneten Selbstbehalte, so ist dieser höhere Selbstbehalt zu bezahlen. Von diesem wird der jeweils

niedrigste bereits bezahlte Selbstbehalt abgezogen und nur die Differenz vorgeschrieben.

2. Selbstbehalt bei Unfall

Innerhalb von 2 Jahren ab dem Unfalltag gilt die Kostenübernahme (Abs. 1 - 3) ohne die Selbstbehalte, die in der Polizze für die vereinbarte Zimmerkategorie angeführt sind.

Lautet die vereinbarte Zimmerkategorie auf "Zweibettzimmer", wird der Differenzbetrag auf den anzuwendenden höheren Selbstbehalt für "Einbettzimmer" verrechnet.

Neue oder erhöhte Selbstbehalte gemäß Abs. 8 werden jedoch auch nach Unfall bei Kostenübernahme in der vereinbarten Zimmerkategorie verrechnet.

2.1 Ein Unfall liegt vor, wenn der Versicherte durch ein plötzlich von außen auf seinen Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.

2.2 Als Unfall gelten auch:

- a) Zerreißen von an Gliedmaßen und an der Wirbelsäule befindlichen Muskeln, Sehnen, Bändern und Kapseln sowie Meniskusverletzungen infolge plötzlicher Abweichung vom geplanten Bewegungsablauf, wenn sie innerhalb von 7 Tagen ab dem Ereignistag medizinisch dokumentiert und ärztlich behandelt wurden.
- b) Bandscheibenhernien, wenn sie durch eine plötzliche, erhebliche direkte Gewalteinwirkung auf das jeweilige Segment der Wirbelsäule verursacht werden, und
 - diese durch Kraft und Richtung in der Lage war, eine gesunde Bandscheibe zu zerreißen, die bildgebende Untersuchung nach dem Unfall (wie MRT, Röntgen) keine degenerativen Veränderungen zeigt und vor dem Unfall keine Wirbelsäulenbeschwerden bestanden; oder
 - Frakturen ober- oder unterhalb der geschädigten Bandscheibe vorliegen; oder
 - es zu Bänderrissen im Bereich der Wirbelsäule mit Wirbelverrenkungen gekommen ist.
- c) Bauch- und Unterleibsbrüche, wenn sie durch eine plötzlich von außen kommende mechanische Einwirkung direkt herbeigeführt worden sind und nicht anlagenbedingt waren.

2.3 Als Unfälle gelten nicht:

- a) Fehl- und Frühgeburten, die durch einen Unfall herbeigeführt worden sind;
- b) Unfälle als Folgen einer Krankheit.

(6) Differenztagegeld in Vertragskrankenhäusern in Österreich

Besteht Versicherungsschutz nach einem Tarif, der höher ist als für die volle Kostenübernahme lt. gültigem Garantietarif erforderlich, wird für jeden Tag des Aufenthaltes ein Differenztagegeld geleistet.

Die Höhe des Differenztagegeldes ergibt sich aus der Differenz zwischen der Anzahl der Tarifstufen des versicherten Tarifes und des für die volle Kostenübernahme erforderlichen Garantietarifes, multipliziert mit dem für die Grundtarifstufe SJKV1 vorgesehenen Betrag von EUR 0,15.

(7) Gesetzliche Krankenversicherung

Abhängig von der gesetzlichen Krankenversicherung des Versicherten erfolgt die Kostenübernahme unter der Voraussetzung der Erbringung der nachstehenden Leistungen durch Krankenversicherungsträger.

Ohne Leistung eines Krankenversicherungsträgers erfolgt keine Kostenübernahme (Abs. 1 - 3) und die Kosten der stationären Heilbehandlung werden bis zu den in der Polizze angeführten tariflichen Höchstbeträgen ersetzt:

- 1. Für gesetzlich Krankenversicherte nach ASVG (ÖGK usw.), BSVG (SVS - Bauern) und GSVG-Sachleistungsgruppe (SVS - Selbständige):
Der Krankenversicherungsträger erbringt eine Leistung für die Kosten der allgemeinen Gebührenklasse.
- 2. Für gesetzlich Krankenversicherte nach B-KUVG (BVAEB - Beamte):
Der Krankenversicherungsträger erbringt eine Leistung für die Kosten der allgemeinen Gebührenklasse und für einen Teil der Pflege- und/oder Sondergebühren einschließlich der Arzthonorare der Sonderklasse.

3. Für gesetzlich Krankenversicherte nach GSVG-Geldleistungsgruppe (SVS - Selbständige):
Der Krankenversicherungsträger erbringt eine Leistung für die Kosten der allgemeinen Gebührenklasse und für einen Teil der Pflege- und/oder Sondergebühren einschließlich der Arzthonorare der Sonderklasse.
4. Für Anspruchsberechtigte nach den Gemeinschaftsbestimmungen über die Soziale Sicherheit in der Europäischen Union (EU):
Der Versicherte ist aufgrund der Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und Nr. 988/2009 im Krankheitsfall in Österreich sachleistungsberechtigt und der Krankenversicherungsträger erbringt für den konkreten Krankenhausaufenthalt eine Leistung für die Kosten der allgemeinen Gebührenklasse.

(8) Änderung/Ende der gesetzlichen Krankenversicherung

Der Tarif SJKV setzt voraus, dass der Versicherte gegenüber einem Träger der gesetzlichen Krankenversicherung anspruchsberechtigt ist.

Eine Änderung der gesetzlichen Krankenversicherung wirkt sich daher auf den Versicherungsschutz aus - insbesondere kann ein Selbstbehalt anfallen oder ein bestehender Selbstbehalt steigen. Wenn die gesetzliche Krankenversicherung endet, erfolgt keine Kostenübernahme (siehe oben Abs. 7) und die Kosten der stationären Heilbehandlung werden bis zu den in der Polizze angeführten tariflichen Höchstbeträgen ersetzt.

Damit in diesen Fällen weiterhin ein geeigneter Versicherungsschutz besteht, ist es erforderlich, dass der Versicherungsnehmer den Versicherer umgehend verständigt.

§ 2

Direktverrechnung

Sofern eine Vereinbarung mit dem Leistungsträger (Krankenhaus, Arzt) besteht, erfolgt auf Grundlage dieser Vereinbarung die direkte Verrechnung der Kosten und Honorare zwischen dem Versicherer und dem Leistungserbringer.

Weitere Grundlage ist eine vom Versicherten vor Antritt der Heilbehandlung anzufordernde Kostenübernahmeerklärung. Die Art der Erkrankung und die Notwendigkeit der Heilbehandlung sind in dieser Anforderung medizinisch nachzuweisen. Lässt die Dringlichkeit der Heilbehandlung eine vorhergehende Anfrage nicht zu, ist diese spätestens drei Arbeitstage ab Antritt der Heilbehandlung nachzureichen.

Der Versicherte hat der Ermittlung von zum Zwecke der Direktverrechnung erforderlichen Daten zuzustimmen.

Wird die Zustimmungserklärung verweigert, widerrufen oder verspätet erteilt und stellt der Leistungserbringer Kosten und Honorare dem Versicherten in Rechnung, ist der Versicherer diesem gegenüber nur in dem in der Vereinbarung über die Direktverrechnung festgelegten Ausmaß zur Leistung verpflichtet.

§ 3

Tagesklinische Behandlung in Krankenhäusern

Tagesklinische Heilbehandlungen sind Heilbehandlungen in einem Krankenhaus, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Art der Heilbehandlung erfordert üblicherweise einen Aufenthalt von mindestens 24 Stunden,
- der Versicherte wird noch am Tag der Aufnahme aus dem Krankenhaus entlassen, und
- für die Heilbehandlung wird die Infrastruktur einer Abteilung des Krankenhauses in Anspruch genommen (z.B. Aufnahme in der Bettenstation, Benutzung eines Operationssaales).

Heilbehandlungen und Operationen in der Ambulanz eines Krankenhauses stellen jedenfalls keine tagesklinischen Behandlungen dar.

§ 4

Ambulante Operationen in Krankenhäusern

- (1) Ambulante Operationen sind
 - medizinisch notwendige operative Eingriffe ab Operationsgruppe 3,
 - die üblicherweise einen Aufenthalt von mindestens 24 Stunden erfordern und
 - in Krankenhäusern oder tagesklinischen Einrichtungen, die sowohl rechtlich, wirtschaftlich als auch organisatorisch an ein bettenführendes Krankenhaus angegliedert sind, durchgeführt werden.

Das für die Einstufung eines Eingriffs maßgebliche Operationsgruppenschema kann auf der Homepage des Versicherers unter folgendem Link eingesehen werden:

<https://www.generali.at/service/krankenversicherung-operationsgruppenschema.html>

Für ambulante Operationen in selbstständigen Tageskliniken oder in Ordinationen niedergelassener Fachärzte werden keine Leistungen erbracht.

- (2) Der Versicherer ersetzt die Kosten einer ambulanten Operation, sofern der Versicherte diese zuvor bei seinem Sozialversicherungsträger im Wege der Voreinreichung geltend gemacht hat. Der Versicherer leistet Kostenersatz abzüglich der Leistung des Sozialversicherungsträgers.

§ 5

Akut-Geriatrie und Remobilisation

Für medizinisch notwendige stationäre Akut-Geriatrie und Remobilisation im Anschluss an eine stationäre Heilbehandlung wird eine Leistung für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr erbracht.

Erfolgen Akut-Geriatrie bzw. Remobilisation in einem Krankenhaus (Abteilung), mit dem der Versicherer dafür einen Vertrag abgeschlossen hat, werden die vereinbarten Kosten mit dem Vertragskrankenhaus gemäß § 2 direkt verrechnet. In allen übrigen Fällen wird das dafür im Leistungstarif angeführte Ersatztagelohn ausbezahlt.

§ 6

Hospiz, Palliativstation

Für medizinisch notwendige stationäre Aufenthalte in einem Hospiz oder einer Palliativstation eines Krankenhauses wird eine Leistung für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr erbracht.

Erfolgt der Aufenthalt in einer Einrichtung, mit der der Versicherer dafür einen Vertrag abgeschlossen hat, werden die vereinbarten Kosten mit der Vertragseinrichtung gemäß § 2 direkt verrechnet. In allen übrigen Fällen wird das dafür im Leistungstarif angeführte Ersatztagelohn ausbezahlt.

§ 7

Tarifliche Leistungen

(1) Umfang einzelner tariflicher Leistungen

1. Tageskosten

umfassen die zu bezahlenden Kosten für Verpflegs- und Krankenhausgebühren (für die Unterbringung, Pflege und Verpflegung).

2. Behandlungshonorar

umfasst alle ärztlichen Honorare (auch Honorare für Hebammen) ausgenommen die Honorare für technische Untersuchungen wie bildgebende Verfahren, Labor, Nuklearmedizin etc.

Soweit Kosten aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Vereinbarungen mit dem Versicherer betraglich geregelt sind, ist der Versicherer zum Ersatz darüber hinausgehender Kosten (z.B. Sonderhonorare der Vorstände von Universitätskliniken gemäß § 46 KaKuG und ausführende Landesgesetze) nicht verpflichtet.

3. Technische Leistungen

umfassen die Honorare für technische Untersuchungen wie bildgebende Verfahren, Labor, Nuklearmedizin etc. und sämtlichen Sachaufwand einschließlich der Kosten für Benützung des Operationssaales, der Arzneimittel (Heilmittel) und Heilbehelfe (abweichend von § 5 A) Abs. 1, 2 und 4 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017).

(2) Stationäre Heilbehandlung in Krankenhäusern

Bei stationärer Heilbehandlung in Krankenhäusern, die im Krankenhausverzeichnis nicht enthalten sind, werden für die Kosten des Aufenthaltes die Leistungen gemäß der für

- Tageskosten,
- Behandlungshonorar,
- Technische Leistungen, und
- Summenleistung

festgesetzten Beträgen erbracht.

(3) Tagesklinische Heilbehandlung in Krankenhäusern

Für tagesklinische Heilbehandlungen in Krankenhäusern, mit denen dafür keine vertraglichen Vereinbarungen über die Kostenübernahme bestehen, werden für die Kosten die folgenden tariflichen Leistungen wie für eine eintägige stationäre Heilbehandlung erbracht:

- Tageskosten,
- Behandlungshonorar,

- Technische Leistungen und
- Summenleistung.

(4) Ambulante Operationen in Krankenhäusern

Für ambulante Operationen in Krankenhäusern oder an diese angegliederten tagesklinischen Einrichtungen, mit denen dafür keine vertraglichen Vereinbarungen über die Kostenübernahme bestehen, wird das tarifliche Behandlungshonorar für die betreffende Operationsgruppe bezahlt.

§ 8

GesundheitsCoaching

(1) Informationen über medizinische Einrichtungen und Gesundheitsdienste

werden bei einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung zu folgenden Themen erteilt:

- Medizinische Einrichtungen weltweit,
- Krankenanstalten in Österreich (öffentlich, privat),
- Transporteinrichtungen in Österreich.

1. Informationen über medizinische Einrichtungen außerhalb Österreichs

werden erteilt, wenn für die spezielle medizinische Behandlung kein geeigneter Arzt bzw. keine geeignete medizinische Behandlung in Österreich vorhanden oder ärztliche Hilfe während eines Auslandsaufenthaltes erforderlich ist.

2. Informationen über Transporteinrichtungen in Österreich

werden erteilt, wenn der Versicherte aufgrund der Art der Erkrankung bzw. durch die Unfallfolgen oder wegen der ärztlich angeordneten Verhaltensmaßregeln außerstande ist, den Arzt oder die medizinische Einrichtung aus eigener Kraft aufzusuchen.

(2) Hilfe im Notfall

Ein medizinischer Notfall liegt vor, wenn der Versicherte von einer unmittelbaren Gefahr (z.B. akute Erkrankung, Unfall, drohende Einwirkung schädigender Stoffe) für Leben, körperliche Unversehrtheit oder Gesundheit bedroht ist.

In allen medizinischen Notfällen ist der Versicherer rund um die Uhr erreichbar und

- unterstützt durch Herstellung der Verbindung und Organisation des Transports zu allen Notfalleinrichtungen in Österreich:
 - Nacht- und Wochenenddienste durch Ärzte für Allgemeinmedizin und Zahnärzte bzw. Apotheken, nächstgelegenes geeignetes Krankenhaus,
 - sonstige Notdienste (z.B. Rotes Kreuz, Vergiftungszentrale, psychosoziale Dienste)

oder

- veranlasst - abhängig vom Gesundheitszustand des Versicherten - einen zeitnahen Rückruf von einem Arzt zur telefonischen Abklärung und Beratung über weitere Maßnahmen.

(3) Bester Arzt, bester Therapeut

Bei einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung unterstützt der Versicherer den Versicherten bei der Suche nach dem hinsichtlich

- des konkreten Beschwerdebildes am besten geeigneten Arzt, bzw.
- der ärztlich empfohlenen Maßnahmen am besten geeigneten Therapeuten.

(4) Ärztliche Zweitmeinung (Second Opinion)

Bei einer notwendigen medizinischen Heilbehandlung nennt der Versicherer auf Wunsch des Versicherten einen Spezialisten, wenn eine Therapie bzw. ein Eingriff von einem Arzt bereits geplant ist.

(5) Herstellung der Verbindung

erfolgt nur auf Wunsch des Versicherten.

Der Versicherer stellt nur den erstmaligen Kontakt her, in weiterer Folge wendet sich der Versicherte selbst an den Arzt/Therapeuten, die medizinische Einrichtung oder den Gesundheitsdienst.

(6) Haftungsausschluss

Durch die Informationsleistung bzw. Herstellung der Verbindung gewährleistet der Versicherer nicht die Verfügbarkeit der Leistungen des betreffenden Arztes/Therapeuten, der medizinischen Einrichtung oder des Gesundheitsdienstes in einem bestimmten Umfang oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes.

(7) **Leistungen des persönlichen GesundheitsCoaches**

werden für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten durch dafür qualifizierte Mitarbeiter eines Vertragspartners des Versicherers erbracht.

Dieser Zeitraum beginnt

- bei der Begleitung während der Genesung und Unterstützung bei der besseren Bewältigung der durch den Versicherungsfall bedingten Lebenssituation mit der medizinisch notwendigen stationären Heilbehandlung;
- bei der Erarbeitung einer Strategie zur Reduktion von Risikofaktoren und Unterstützung bei Maßnahmen zur Umstellung hin zu einem gesünderen Lebensstil mit der erstmaligen Kontaktaufnahme des Versicherten mit dem GesundheitsCoach.

Der Versicherer trägt die Kosten der Begleitung und Unterstützung durch den persönlichen GesundheitsCoach, leistet jedoch keinen Kostenersatz für von diesem erarbeitete oder vorgeschlagene Maßnahmen (z.B. Kosten gesünderer Lebensmittel oder eines Fitnessstrainings).

(8) **Nachweis der Anspruchsvoraussetzungen**

Außer bei "Hilfe im Notfall" kann der Versicherer verlangen, dass der Versicherte die Anspruchsvoraussetzungen der oben angeführten Leistungen durch entsprechende medizinische Unterlagen (ärztliche Befunde, Rezepte für Arzneien, etc.) nachweist.

§ 9

Änderung der Prämie und des Versicherungsschutzes

- (1) Der Tarif SJKV unterliegt der Anpassung gemäß § 17 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017.
- (2) In Ergänzung zu § 17 Abs. 1 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 gilt:
Kann in einem Bundesland über die Höhe der Krankenhauskosten und Honorare kein Einvernehmen hergestellt werden, wird der Anpassung die jeweilige Veränderung des von Statistik Austria verlautbarten Index der Verbraucherpreise zugrundegelegt.
- (3) In Ergänzung zu § 17 Abs. 2 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 gilt:
Ergibt der Vergleich der in § 17 Abs. 1 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 genannten Faktoren eine Änderung der zu erwartenden Leistungen um mindestens die in der Grundtarifstufe SJKV1 festgelegten Leistungen, so erfolgt eine Anpassung um die entsprechende Anzahl von Grundtarifstufen.
- (4) Ergibt der Vergleich der in § 17 Abs. 1 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 genannten Faktoren einen Änderungsbedarf für die Prämie der Grundtarifstufe SJKV1, so wird die Prämie der Grundtarifstufe SJKV1 entsprechend angepasst.
- (5) In Ergänzung zu § 17 Abs. 3 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 gilt:
Ob und in welchem Umfang der Versicherer zur Kostenübernahme (§ 1 Abs. 1 - 3) verpflichtet ist, ergibt sich aus der zuletzt gültigen Polizze.

Ergänzende Versicherungsbedingungen für MedCare: Smart Sonderklasse - Tarif SJMV (EB_SJMV_17)

Vertragspartner

Diese Vertragsgrundlagen gelten für Verträge mit der Generali Versicherung AG, 1010 Wien, Landskronergasse 1-3.

Aufsichtsbehörde

Finanzmarktaufsicht, 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5



§ 1

Kostenübernahme in Krankenanstalten

(1) Kostenübernahme in den Vertragskrankenhäusern in Österreich laut Krankenhausverzeichnis

Nimmt der Versicherte eine Behandlung in einem Vertragskrankenhaus in Österreich in Anspruch, so werden die vereinbarten Kosten einschließlich der ärztlichen Honorare anstelle der tariflichen Leistungen in voller Höhe übernommen und mit dem Krankenhaus direkt verrechnet.

(2) Kostenübernahme in Europa (Europaliste)

Nimmt der Versicherte eine Behandlung in einem allgemeinen öffentlichen Krankenhaus im europäischen Ausland (siehe Krankenhausverzeichnis/Europaliste) in Anspruch, so werden die Kosten der Pflege und Verpflegung, von Operationen und Behandlung einschließlich der ärztlichen Honorare anstelle der tariflichen Leistungen in voller Höhe übernommen.

(3) Weltweite Kostenübernahme

Nimmt der Versicherte eine Behandlung in einem allgemeinen öffentlichen Krankenhaus außerhalb Österreichs und Europas (siehe Europaliste) in Anspruch, so werden die Kosten der Pflege und Verpflegung, von Operationen und Behandlung einschließlich der ärztlichen Honorare anstelle der tariflichen Leistungen in voller Höhe übernommen, wenn

- a) die Behandlung in Österreich gleichwertig nicht durchgeführt werden kann, diese ärztlich empfohlen wurde und der Versicherer vorher eine Kostenübernahmeerklärung abgegeben hat. Der Versicherer gibt eine Kostenübernahmeerklärung ab, wenn er über die geplante Behandlung informiert wurde und dadurch Gelegenheit hatte, vor Beginn der Behandlung mit dem betreffenden Krankenhaus über die Höhe der Kosten Einvernehmen herzustellen.
- b) wegen eines Unfalles oder einer akut auftretenden Erkrankung während eines Aufenthaltes mit einer geplanten Dauer von bis zu 6 Wochen in diesen Ländern eine Heilbehandlung medizinisch notwendig und eine Rückkehr nach Österreich aus medizinischen Gründen nicht möglich ist.

Bei Kostenübernahme gemäß Pkt. a) wird der für "Kosten des Krankenhaus- und Heimtransportes" festgesetzte Betrag verzehnfacht.

(4) Krankenhausverzeichnis - Garantietarife - Europaliste

Die Vertragskrankenhäuser in Österreich und die Länder der Europaliste sind im Krankenhausverzeichnis angeführt. Für alle Vertragskrankenhäuser sind für die volle Kostenübernahme zumindest erforderliche Tarifstufen definiert (Garantietarife).

Die Kostenübernahme aufgrund des versicherten Tarifs ist in der Polizze beschrieben.

Diese allgemeine Kostendeckungszusage kann im Sinn des § 178c VersVG vom Versicherer in geschriebener Form widerrufen werden. Der Widerruf wird nach Ablauf von drei Wochen wirksam.

(5) Selbstbehalt

1. Selbstbehalt bei Krankheit

Ist der versicherte Tarif niedriger als der für das betreffende Krankenhaus bzw. die betreffende Zimmerkategorie gültige Garantietarif, so gilt die Kostenübernahme (Abs. 1 bis 3) mit dem auf der Polizze angeschriebenen Selbstbehalt pro Aufenthaltstag vereinbart.

Dieser Selbstbehalt ist je Kalenderjahr für höchstens 5 Tage zu bezahlen.

Erstreckt sich ein Krankenhausaufenthalt über den Jahreswechsel hinaus, ist auch für diesen Aufenthalt der Selbstbehalt mit höchstens 5 Tagen begrenzt.

Bei mehreren Krankenhausaufenthalten in unterschiedlichen Krankenhäusern oder Zimmerkategorien innerhalb eines Kalenderjahres sind ab dem 6. Aufenthaltstag die jeweils 5 höchsten Selbstbehalte maßgeblich.

Ist für das betreffende Krankenhaus bzw. die betreffende Zimmerkategorie ein Selbstbehalt vereinbart, der höher ist als die bisher verrechneten Selbstbehalte, so ist dieser höhere Selbstbehalt zu bezahlen. Von diesem wird der jeweils

niedrigste bereits bezahlte Selbstbehalt abgezogen und nur die Differenz vorgeschrieben.

2. Selbstbehalt bei Unfall

Innerhalb von 2 Jahren ab dem Unfalltag gilt die Kostenübernahme (Abs. 1 - 3) ohne die Selbstbehalte, die in der Polizze für die vereinbarte Zimmerkategorie angeführt sind.

Lautet die vereinbarte Zimmerkategorie auf "Zweibettzimmer", wird der Differenzbetrag auf den anzuwendenden höheren Selbstbehalt für "Einbettzimmer" verrechnet.

Neue oder erhöhte Selbstbehalte gemäß Abs. 8 werden jedoch auch nach Unfall bei Kostenübernahme in der vereinbarten Zimmerkategorie verrechnet.

2.1 Ein Unfall liegt vor, wenn der Versicherte durch ein plötzlich von außen auf seinen Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.

2.2 Als Unfall gelten auch:

- a) Zerreißen von an Gliedmaßen und an der Wirbelsäule befindlichen Muskeln, Sehnen, Bändern und Kapseln sowie Meniskusverletzungen infolge plötzlicher Abweichung vom geplanten Bewegungsablauf, wenn sie innerhalb von 7 Tagen ab dem Ereignistag medizinisch dokumentiert und ärztlich behandelt wurden.
- b) Bandscheibenhernien, wenn sie durch eine plötzliche, erhebliche direkte Gewalteinwirkung auf das jeweilige Segment der Wirbelsäule verursacht werden, und
 - diese durch Kraft und Richtung in der Lage war, eine gesunde Bandscheibe zu zerreißen, die bildgebende Untersuchung nach dem Unfall (wie MRT, Röntgen) keine degenerativen Veränderungen zeigt und vor dem Unfall keine Wirbelsäulenbeschwerden bestanden; oder
 - Frakturen ober- oder unterhalb der geschädigten Bandscheibe vorliegen; oder
 - es zu Bänderrissen im Bereich der Wirbelsäule mit Wirbelverrenkungen gekommen ist.
- c) Bauch- und Unterleibsbrüche, wenn sie durch eine plötzlich von außen kommende mechanische Einwirkung direkt herbeigeführt worden sind und nicht anlagenbedingt waren.

2.3 Als Unfälle gelten nicht:

- a) Fehl- und Frühgeburten, die durch einen Unfall herbeigeführt worden sind;
- b) Unfälle als Folgen einer Krankheit.

(6) Differenztagegeld in Vertragskrankenhäusern in Österreich

Besteht Versicherungsschutz nach einem Tarif, der höher ist als für die volle Kostenübernahme lt. gültigem Garantietarif erforderlich, wird für jeden Tag des Aufenthaltes ein Differenztagegeld geleistet.

Die Höhe des Differenztagegeldes ergibt sich aus der Differenz zwischen der Anzahl der Tarifstufen des versicherten Tarifes und des für die volle Kostenübernahme erforderlichen Garantietarifes, multipliziert mit dem für die Grundtarifstufe SJMV1 vorgesehenen Betrag von EUR 0,15.

(7) Gesetzliche Krankenversicherung

Abhängig von der gesetzlichen Krankenversicherung des Versicherten erfolgt die Kostenübernahme unter der Voraussetzung der Erbringung der nachstehenden Leistungen durch Krankenversicherungsträger.

Ohne Leistung eines Krankenversicherungsträgers erfolgt keine Kostenübernahme (Abs. 1 - 3) und die Kosten der stationären Heilbehandlung werden bis zu den in der Polizze angeführten tariflichen Höchstbeträgen ersetzt:

- 1. Für gesetzlich Krankenversicherte nach ASVG (ÖGK usw.), BSVG (SVS - Bauern) und GSVG-Sachleistungsgruppe (SVS - Selbständige):
Der Krankenversicherungsträger erbringt eine Leistung für die Kosten der allgemeinen Gebührenklasse.
- 2. Für gesetzlich Krankenversicherte nach B-KUVG (BVAEB - Beamte):
Der Krankenversicherungsträger erbringt eine Leistung für die Kosten der allgemeinen Gebührenklasse und für einen Teil der Pflege- und/oder Sondergebühren einschließlich der Arzthonorare der Sonderklasse.

3. Für gesetzlich Krankenversicherte nach GSVG-Geldleistungsgruppe (SVS - Selbständige):
Der Krankenversicherungsträger erbringt eine Leistung für die Kosten der allgemeinen Gebührenklasse und für einen Teil der Pflege- und/oder Sondergebühren einschließlich der Arzthonorare der Sonderklasse.
4. Für Anspruchsberechtigte nach den Gemeinschaftsbestimmungen über die Soziale Sicherheit in der Europäischen Union (EU):
Der Versicherte ist aufgrund der Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und Nr. 988/2009 im Krankheitsfall in Österreich sachleistungsberechtigt und der Krankenversicherungsträger erbringt für den konkreten Krankenhausaufenthalt eine Leistung für die Kosten der allgemeinen Gebührenklasse.

(8) Änderung/Ende der gesetzlichen Krankenversicherung

Der Tarif SJMV setzt voraus, dass der Versicherte gegenüber einem Träger der gesetzlichen Krankenversicherung anspruchsberechtigt ist.

Eine Änderung der gesetzlichen Krankenversicherung wirkt sich daher auf den Versicherungsschutz aus - insbesondere kann ein Selbstbehalt anfallen oder ein bestehender Selbstbehalt steigen. Wenn die gesetzliche Krankenversicherung endet, erfolgt keine Kostenübernahme (siehe oben Abs. 7) und die Kosten der stationären Heilbehandlung werden bis zu den in der Polizza angeführten tariflichen Höchstbeträgen ersetzt.

Damit in diesen Fällen weiterhin ein geeigneter Versicherungsschutz besteht, ist es erforderlich, dass der Versicherungsnehmer den Versicherer umgehend verständigt.

§ 2

Selbstbehaltsverzicht

- (1) Der vereinbarte Selbstbehaltsverzicht verringert die für die Zimmerkategorien Zweibettzimmer und Einbettzimmer geltenden Selbstbehalte des versicherten Tarifs (siehe oben, § 1 Abs. 5 Pkt. 1. und 2.). In der Polizza sind angeführt:
 - der Betrag des Selbstbehaltsverzichts und
 - die um diesen Betrag verringerten Selbstbehalte.
- (2) **Vertragsänderung nach dem 45. Geburtstag des Versicherten**
 1. Der vereinbarte Selbstbehaltsverzicht entfällt mit dem Monatsersten, der auf den 45. Geburtstag des Versicherten folgt. Damit gelten für die bisher versicherte Garantietarifstufe die vollen Selbstbehalte für Zweibettzimmer und Einbettzimmer.
 2. Für diesen Fall gilt als vereinbart, dass der Versicherer mit Wirkung zum Änderungszeitpunkt (siehe oben Pkt. 1) ohne Prüfung des Gesundheitszustandes des Versicherten die bisher versicherte Garantietarifstufe auf Sonderklasse Einbettzimmer Österreich erhöht.
Das bedeutet: Ab diesem Zeitpunkt gilt die Kostenübernahme (siehe oben, § 1 Abs. 1 - 3) ohne Selbstbehalt vereinbart und der Versicherungsnehmer bezahlt die für die Garantietarifstufe Sonderklasse Einbettzimmer Österreich jeweils geltende Prämie.
Zu dieser Vertragsänderung schickt der Versicherer dem Versicherungsnehmer eine neue Polizza zu.
 3. Der Versicherungsnehmer kann innerhalb von 4 Wochen ab Erhalt der neuen Polizza mit Wirkung zum Änderungszeitpunkt (siehe oben Pkt. 1)
 - a. die Fortsetzung des Vertrages mit der bisher versicherten Garantietarifstufe (bei vollen Selbsthalten) verlangen oder
 - b. die Fortsetzung des Vertrages mit jeder niedrigeren Garantietarifstufe (unterhalb der Sonderklasse Einbettzimmer Österreich oder auch unterhalb der bisher versicherten Garantietarifstufe) verlangen oder
 - c. den Tarif hinsichtlich des Versicherten kündigen.

Auf diese Rechte und wie diese auszuüben sind, wird der Versicherer den Versicherungsnehmer bei Übermittlung der neuen Polizza ausdrücklich nochmals hinweisen.

§ 3

Direktverrechnung

Sofern eine Vereinbarung mit dem Leistungsträger (Krankenhaus, Arzt) besteht, erfolgt auf Grundlage dieser Vereinbarung die direkte Verrechnung der Kosten und Honorare zwischen dem Versicherer und dem Leistungserbringer.

Weitere Grundlage ist eine vom Versicherten vor Antritt der Heilbehandlung anzufordernde Kostenübernahmeerklärung. Die Art der Erkrankung und die Notwendigkeit der Heilbehandlung sind in dieser Anforderung medizinisch nachzuweisen. Lässt die Dringlichkeit der Heilbehandlung eine vorhergehende Anfrage nicht zu, ist diese spätestens drei Arbeitstage ab Antritt der Heilbehandlung nachzureichen.

Der Versicherte hat der Ermittlung von zum Zwecke der Direktverrechnung erforderlichen Daten zuzustimmen. Wird die Zustimmungserklärung verweigert, widerrufen oder verspätet erteilt und stellt der Leistungserbringer Kosten und Honorare dem Versicherten in Rechnung, ist der Versicherer diesem gegenüber nur in dem in der Vereinbarung über die Direktverrechnung festgelegten Ausmaß zur Leistung verpflichtet.

§ 4

Tagesklinische Behandlung in Krankenhäusern

Tagesklinische Heilbehandlungen sind Heilbehandlungen in einem Krankenhaus, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Art der Heilbehandlung erfordert üblicherweise einen Aufenthalt von mindestens 24 Stunden,
- der Versicherte wird noch am Tag der Aufnahme aus dem Krankenhaus entlassen, und
- für die Heilbehandlung wird die Infrastruktur einer Abteilung des Krankenhauses in Anspruch genommen (z.B. Aufnahme in der Bettenstation, Benutzung eines Operationssaales).

Heilbehandlungen und Operationen in der Ambulanz eines Krankenhauses stellen jedenfalls keine tagesklinischen Behandlungen dar.

§ 5

Ambulante Operationen in Krankenhäusern

(1) Ambulante Operationen sind

- medizinisch notwendige operative Eingriffe ab Operationsgruppe 3,
- die üblicherweise einen Aufenthalt von mindestens 24 Stunden erfordern und
- in Krankenhäusern oder tagesklinischen Einrichtungen, die sowohl rechtlich, wirtschaftlich als auch organisatorisch an ein bettenführendes Krankenhaus angegliedert sind, durchgeführt werden.

Das für die Einstufung eines Eingriffs maßgebliche Operationsgruppenschema kann auf der Homepage des Versicherers unter folgendem Link eingesehen werden:

<https://www.generali.at/service/krankenversicherung-operationsgruppenschema.html>

Für ambulante Operationen in selbstständigen Tageskliniken oder in Ordinationen niedergelassener Fachärzte werden keine Leistungen erbracht.

(2) Der Versicherer ersetzt die Kosten einer ambulanten Operation, sofern der Versicherte diese zuvor bei seinem Sozialversicherungsträger im Wege der Voreinreichung geltend gemacht hat. Der Versicherer leistet Kostenersatz abzüglich der Leistung des Sozialversicherungsträgers.

§ 6

Akut-Geriatrie und Remobilisation

Für medizinisch notwendige stationäre Akut-Geriatrie und Remobilisation im Anschluss an eine stationäre Heilbehandlung wird eine Leistung für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr erbracht.

Erfolgen Akut-Geriatrie bzw. Remobilisation in einem Krankenhaus (Abteilung), mit dem der Versicherer dafür einen Vertrag abgeschlossen hat, werden die vereinbarten Kosten mit dem Vertragskrankenhaus gemäß § 2 direkt verrechnet. In allen übrigen Fällen wird das dafür im Leistungstarif angeführte Ersatztaggeld ausbezahlt.

§ 7

Hospiz, Palliativstation

Für medizinisch notwendige stationäre Aufenthalte in einem Hospiz oder einer Palliativstation eines Krankenhauses wird eine Leistung für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr erbracht.

Erfolgt der Aufenthalt in einer Einrichtung, mit der der Versicherer dafür einen Vertrag abgeschlossen hat, werden die vereinbarten Kosten mit der Vertragseinrichtung gemäß § 2 direkt verrechnet. In allen übrigen Fällen wird das dafür im Leistungstarif angeführte Ersatztagegeld ausbezahlt.

§ 8

Tarifliche Leistungen

(1) Umfang einzelner tariflicher Leistungen

1. Tageskosten

umfassen die zu bezahlenden Kosten für Verpflegs- und Krankenhausgebühren (für die Unterbringung, Pflege und Verpflegung).

2. Behandlungshonorar

umfasst alle ärztlichen Honorare (auch Honorare für Hebammen) ausgenommen die Honorare für technische Untersuchungen wie bildgebende Verfahren, Labor, Nuklearmedizin etc.

Soweit Kosten aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Vereinbarungen mit dem Versicherer betraglich geregelt sind, ist der Versicherer zum Ersatz darüber hinausgehender Kosten (z.B. Sonderhonorare der Vorstände von Universitätskliniken gemäß § 46 KaKuG und ausführende Landesgesetze) nicht verpflichtet.

3. Technische Leistungen

umfassen die Honorare für technische Untersuchungen wie bildgebende Verfahren, Labor, Nuklearmedizin etc. und sämtlichen Sachaufwand einschließlich der Kosten für Benützung des Operationssaales, der Arzneimittel (Heilmittel) und Heilbehelfe (abweichend von § 5 A) Abs. 1, 2 und 4 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017).

(2) Stationäre Heilbehandlung in Krankenhäusern

Bei stationärer Heilbehandlung in Krankenhäusern, die im Krankenhausverzeichnis nicht enthalten sind, werden für die Kosten des Aufenthaltes die Leistungen gemäß der für

- Tageskosten,
 - Behandlungshonorar,
 - Technische Leistungen, und
 - Summenleistung
- festgesetzten Beträgen erbracht.

(3) Tagesklinische Heilbehandlung in Krankenhäusern

Für tagesklinische Heilbehandlungen in Krankenhäusern, mit denen dafür keine vertraglichen Vereinbarungen über die Kostenübernahme bestehen, werden für die Kosten die folgenden tariflichen Leistungen wie für eine eintägige stationäre Heilbehandlung erbracht:

- Tageskosten,
- Behandlungshonorar,
- Technische Leistungen und
- Summenleistung.

(4) Ambulante Operationen in Krankenhäusern

Für ambulante Operationen in Krankenhäusern oder an diese angegliederten tagesklinischen Einrichtungen, mit denen dafür keine vertraglichen Vereinbarungen über die Kostenübernahme bestehen, wird das tarifliche Behandlungshonorar für die betreffende Operationsgruppe bezahlt.

§ 9

GesundheitsCoaching

(1) Informationen über medizinische Einrichtungen und Gesundheitsdienste

werden bei einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung zu folgenden Themen erteilt:

- Medizinische Einrichtungen weltweit,
- Krankenanstalten in Österreich (öffentlich, privat),
- Transporteinrichtungen in Österreich.

1. Informationen über medizinische Einrichtungen außerhalb Österreichs

werden erteilt, wenn für die spezielle medizinische Behandlung kein geeigneter Arzt bzw. keine geeignete medizinische Behandlung in Österreich vorhanden oder ärztliche Hilfe während eines Auslandsaufenthaltes erforderlich ist.

2. Informationen über Transporteinrichtungen in Österreich

werden erteilt, wenn der Versicherte aufgrund der Art der Erkrankung bzw. durch die Unfallfolgen oder wegen der ärztlich angeordneten Verhaltensmaßregeln außerstande ist, den Arzt oder die medizinische Einrichtung aus eigener Kraft aufzusuchen.

(2) Hilfe im Notfall

Ein medizinischer Notfall liegt vor, wenn der Versicherte von einer unmittelbaren Gefahr (z.B. akute Erkrankung, Unfall, drohende Einwirkung schädigender Stoffe) für Leben, körperliche Unversehrtheit oder Gesundheit bedroht ist.

In allen medizinischen Notfällen ist der Versicherer rund um die Uhr erreichbar und

- unterstützt durch Herstellung der Verbindung und Organisation des Transports zu allen Notfalleinrichtungen in Österreich:
 - Nacht- und Wochenenddienste durch Ärzte für Allgemeinmedizin und Zahnärzte bzw. Apotheken, nächstgelegenes geeignetes Krankenhaus,
 - sonstige Notdienste (z.B. Rotes Kreuz, Vergiftungszentrale, psychosoziale Dienste)

oder

- veranlasst - abhängig vom Gesundheitszustand des Versicherten - einen zeitnahen Rückruf von einem Arzt zur telefonischen Abklärung und Beratung über weitere Maßnahmen.

(3) Bester Arzt, bester Therapeut

Bei einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung unterstützt der Versicherer den Versicherten bei der Suche nach dem hinsichtlich

- des konkreten Beschwerdebildes am besten geeigneten Arzt, bzw.
- der ärztlich empfohlenen Maßnahmen am besten geeigneten Therapeuten.

(4) Ärztliche Zweitmeinung (Second Opinion)

Bei einer notwendigen medizinischen Heilbehandlung nennt der Versicherer auf Wunsch des Versicherten einen Spezialisten, wenn eine Therapie bzw. ein Eingriff von einem Arzt bereits geplant ist.

(5) Herstellung der Verbindung

erfolgt nur auf Wunsch des Versicherten.

Der Versicherer stellt nur den erstmaligen Kontakt her, in weiterer Folge wendet sich der Versicherte selbst an den Arzt/Therapeuten, die medizinische Einrichtung oder den Gesundheitsdienst.

(6) Haftungsausschluss

Durch die Informationsleistung bzw. Herstellung der Verbindung gewährleistet der Versicherer nicht die Verfügbarkeit der Leistungen des betreffenden Arztes/Therapeuten, der medizinischen Einrichtung oder des Gesundheitsdienstes in einem bestimmten Umfang oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes.

(7) Leistungen des persönlichen GesundheitsCoaches

werden für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten durch dafür qualifizierte Mitarbeiter eines Vertragspartners des Versicherers erbracht.

Dieser Zeitraum beginnt

- bei der Begleitung während der Genesung und Unterstützung bei der besseren Bewältigung der durch den Versicherungsfall bedingten Lebenssituation mit der medizinisch notwendigen stationären Heilbehandlung;
- bei der Erarbeitung einer Strategie zur Reduktion von Risikofaktoren und Unterstützung bei Maßnahmen zur Umstellung hin zu einem gesünderen Lebensstil mit der erstmaligen Kontaktaufnahme des Versicherten mit dem GesundheitsCoach.

Der Versicherer trägt die Kosten der Begleitung und Unterstützung durch den persönlichen GesundheitsCoach, leistet jedoch keinen Kostenersatz für von diesem erarbeitete oder vorgeschlagene Maßnahmen (z.B. Kosten gesünderer Lebensmittel oder eines Fitnesstrainings).

(8) Nachweis der Anspruchsvoraussetzungen

Außer bei "Hilfe im Notfall" kann der Versicherer verlangen, dass der Versicherte die Anspruchsvoraussetzungen der oben angeführten Leistungen durch entsprechende medizinische Unterlagen (ärztliche Befunde, Rezepte für Arzneien, etc.) nachweist.

§ 10

Änderung der Prämie und des Versicherungsschutzes

- (1) Der Tarif SJMV unterliegt der Anpassung gemäß § 17 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017.
- (2) In Ergänzung zu § 17 Abs. 1 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 gilt:
Kann in einem Bundesland über die Höhe der Krankenhauskosten und Honorare kein Einvernehmen hergestellt werden, wird der Anpassung die jeweilige Veränderung des von Statistik Austria verlautbarten Index der Verbraucherpreise zugrundegelegt.
- (3) In Ergänzung zu § 17 Abs. 2 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 gilt:
Ergibt der Vergleich der in § 17 Abs. 1 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 genannten Faktoren eine Änderung der zu erwartenden Leistungen um mindestens die in der Grundtarifstufe SJMV1 festgelegten Leistungen, so erfolgt eine Anpassung um die entsprechende Anzahl von Grundtarifstufen.
- (4) Ergibt der Vergleich der in § 17 Abs. 1 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 genannten Faktoren einen Änderungsbedarf für die Prämie der Grundtarifstufe SJMV1, so wird die Prämie der Grundtarifstufe SJMV1 entsprechend angepasst.
- (5) In Ergänzung zu § 17 Abs. 3 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 gilt:
Ob und in welchem Umfang der Versicherer zur Kostenübernahme (§ 1 Abs. 1 - 3) verpflichtet ist, ergibt sich aus der zuletzt gültigen Polizze.

Ergänzende Versicherungsbedingungen für MedCare: Sonderklasse - Tarif SJN (EB_SJN_17)

Vertragspartner

Diese Vertragsgrundlagen gelten für Verträge mit der Generali Versicherung AG, 1010 Wien, Landskronergasse 1-3.

Aufsichtsbehörde

Finanzmarktaufsicht, 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5



§ 1

Kostenübernahme in Krankenanstalten

(1) Kostenübernahme in den Vertragskrankenhäusern in Österreich laut Krankenhausverzeichnis

Nimmt der Versicherte eine Behandlung in einem Vertragskrankenhaus in Österreich in Anspruch, so werden die vereinbarten Kosten einschließlich der ärztlichen Honorare anstelle der tariflichen Leistungen in voller Höhe übernommen und mit dem Krankenhaus direkt verrechnet.

(2) Kostenübernahme in Europa (Europaliste)

Nimmt der Versicherte eine Behandlung in einem allgemeinen öffentlichen Krankenhaus im europäischen Ausland (siehe Krankenhausverzeichnis/Europaliste) in Anspruch, so werden die Kosten der Pflege und Verpflegung, von Operationen und Behandlung einschließlich der ärztlichen Honorare anstelle der tariflichen Leistungen in voller Höhe übernommen.

(3) Weltweite Kostenübernahme

Nimmt der Versicherte eine Behandlung in einem allgemeinen öffentlichen Krankenhaus außerhalb Österreichs und Europas (siehe Europaliste) in Anspruch, so werden die Kosten der Pflege und Verpflegung, von Operationen und Behandlung einschließlich der ärztlichen Honorare anstelle der tariflichen Leistungen in voller Höhe übernommen, wenn

- a) die Behandlung in Österreich gleichwertig nicht durchgeführt werden kann, diese ärztlich empfohlen wurde und der Versicherer vorher eine Kostenübernahmeerklärung abgegeben hat. Der Versicherer gibt eine Kostenübernahmeerklärung ab, wenn er über die geplante Behandlung informiert wurde und dadurch Gelegenheit hatte, vor Beginn der Behandlung mit dem betreffenden Krankenhaus über die Höhe der Kosten Einvernehmen herzustellen.
- b) wegen eines Unfalles oder einer akut auftretenden Erkrankung während eines Aufenthaltes mit einer geplanten Dauer von bis zu 6 Wochen in diesen Ländern eine Heilbehandlung medizinisch notwendig und eine Rückkehr nach Österreich aus medizinischen Gründen nicht möglich ist.

Bei Kostenübernahme gemäß Pkt. a) wird der für "Kosten des Krankenhaus- und Heimtransportes" festgesetzte Betrag verzehnfacht.

(4) Krankenhausverzeichnis - Garantietarife - Europaliste

Die Vertragskrankenhäuser in Österreich und die Länder der Europaliste sind im Krankenhausverzeichnis angeführt. Für alle Vertragskrankenhäuser sind für die volle Kostenübernahme zumindest erforderliche Tarifstufen definiert (Garantietarife).

Die Kostenübernahme aufgrund des versicherten Tarifs ist in der Polizze beschrieben.

Diese allgemeine Kostendeckungszusage kann im Sinn des § 178c VersVG vom Versicherer in geschriebener Form widerrufen werden. Der Widerruf wird nach Ablauf von drei Wochen wirksam.

(5) Selbstbehalt

1. Selbstbehalt bei Krankheit

Ist der versicherte Tarif niedriger als der für das betreffende Krankenhaus bzw. die betreffende Zimmerkategorie gültige Garantietarif, so gilt die Kostenübernahme (Abs. 1 bis 3) mit dem auf der Polizze angeschriebenen Selbstbehalt pro Aufenthaltstag vereinbart.

Dieser Selbstbehalt ist je Kalenderjahr für höchstens 5 Tage, zu bezahlen.

Erstreckt sich ein Krankenhausaufenthalt über den Jahreswechsel hinaus, ist auch für diesen Aufenthalt der Selbstbehalt mit höchstens 5 Tagen begrenzt.

Bei mehreren Krankenhausaufenthalten in unterschiedlichen Krankenhäusern oder Zimmerkategorien innerhalb eines Kalenderjahres sind ab dem 6. Aufenthaltstag die jeweils 5 höchsten Selbstbehalte maßgeblich.

Ist für das betreffende Krankenhaus bzw. die betreffende Zimmerkategorie ein Selbstbehalt vereinbart, der höher ist als die bisher verrechneten Selbstbehalte, so ist dieser höhere Selbstbehalt zu bezahlen. Von diesem wird der jeweils

niedrigste bereits bezahlte Selbstbehalt abgezogen und nur die Differenz vorgeschrieben.

2. Selbstbehalt bei Unfall

Innerhalb von 2 Jahren ab dem Unfalltag gilt die Kostenübernahme (Abs. 1 - 3) ohne die Selbstbehalte, die in der Polizze für die vereinbarte Zimmerkategorie angeführt sind.

Lautet die vereinbarte Zimmerkategorie auf "Zweibettzimmer", wird der Differenzbetrag auf den anzuwendenden höheren Selbstbehalt für "Einbettzimmer" verrechnet.

2.1 Ein Unfall liegt vor, wenn der Versicherte durch ein plötzlich von außen auf seinen Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.

2.2 Als Unfall gelten auch:

- a) Zerreißen von an Gliedmaßen und an der Wirbelsäule befindlichen Muskeln, Sehnen, Bändern und Kapseln sowie Meniskusverletzungen infolge plötzlicher Abweichung vom geplanten Bewegungsablauf, wenn sie innerhalb von 7 Tagen ab dem Ereignistag medizinisch dokumentiert und ärztlich behandelt wurden.
- b) Bandscheibenhernien, wenn sie durch eine plötzliche, erhebliche direkte Gewalteinwirkung auf das jeweilige Segment der Wirbelsäule verursacht werden, und
 - diese durch Kraft und Richtung in der Lage war, eine gesunde Bandscheibe zu zerreißen, die bildgebende Untersuchung nach dem Unfall (wie MRT, Röntgen) keine degenerativen Veränderungen zeigt und vor dem Unfall keine Wirbelsäulenbeschwerden bestanden; oder
 - Frakturen ober- oder unterhalb der geschädigten Bandscheibe vorliegen; oder
 - es zu Bänderrissen im Bereich der Wirbelsäule mit Wirbelverrenkungen gekommen ist.
- c) Bauch- und Unterleibsbrüche, wenn sie durch eine plötzlich von außen kommende mechanische Einwirkung direkt herbeigeführt worden sind und nicht anlagenbedingt waren.

2.3 Als Unfälle gelten nicht:

- a) Fehl- und Frühgeburten, die durch einen Unfall herbeigeführt worden sind;
- b) Unfälle als Folgen einer Krankheit.

(6) Differenztagegeld in Vertragskrankenhäusern in Österreich

Besteht Versicherungsschutz nach einem Tarif, der höher ist als für die volle Kostenübernahme lt. gültigem Garantietarif erforderlich, wird für jeden Tag des Aufenthaltes ein Differenztagegeld geleistet.

Die Höhe des Differenztagegeldes ergibt sich aus der Differenz zwischen der Anzahl der Tarifstufen des versicherten Tarifes und des für die volle Kostenübernahme erforderlichen Garantietarifes, multipliziert mit dem für die Grundtarifstufe SJN1 vorgesehenen Betrag von EUR 0,15.

(7) Gesetzliche Krankenversicherung

Der Tarif SJN setzt voraus, dass der Versicherte in Österreich keiner gesetzlichen Krankenversicherung unterliegt.

Der Eintritt in die gesetzliche Krankenversicherung wirkt sich daher auf den Versicherungsschutz aus.

Damit in diesem Fall weiterhin ein geeigneter Versicherungsschutz besteht, ist es erforderlich, dass der Versicherungsnehmer den Versicherer umgehend verständigt.

§ 2

Direktverrechnung

Sofern eine Vereinbarung mit dem Leistungsträger (Krankenhaus, Arzt) besteht, erfolgt auf Grundlage dieser Vereinbarung die direkte Verrechnung der Kosten und Honorare zwischen dem Versicherer und dem Leistungserbringer.

Weitere Grundlage ist eine vom Versicherten vor Antritt der Heilbehandlung anzufordernde Kostenübernahmeerklärung. Die Art der Erkrankung und die Notwendigkeit der Heilbehandlung sind in dieser Anforderung medizinisch nachzuweisen. Lässt die Dringlichkeit der Heilbehandlung eine vorhergehende Anfrage nicht zu, ist diese spätestens drei Arbeitstage ab Antritt der Heilbehandlung nachzureichen.

Der Versicherte hat der Ermittlung von zum Zwecke der Direktverrechnung erforderlichen Daten zuzustimmen.

Wird die Zustimmungserklärung verweigert, widerrufen oder verspätet erteilt und stellt der Leistungserbringer Kosten und Honorare dem Versicherten in Rechnung, ist der Versicherer diesem gegenüber nur in dem in der Vereinbarung über die Direktverrechnung festgelegten Ausmaß zur Leistung verpflichtet.

§ 3

Tagesklinische Behandlung in Krankenhäusern

Tagesklinische Heilbehandlungen sind Heilbehandlungen in einem Krankenhaus, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Art der Heilbehandlung erfordert üblicherweise einen Aufenthalt von mindestens 24 Stunden,
- der Versicherte wird noch am Tag der Aufnahme aus dem Krankenhaus entlassen, und
- für die Heilbehandlung wird die Infrastruktur einer Abteilung des Krankenhauses in Anspruch genommen (z.B. Aufnahme in der Bettenstation, Benutzung eines Operationssaales).

Heilbehandlungen und Operationen in der Ambulanz eines Krankenhauses stellen jedenfalls keine tagesklinischen Behandlungen dar.

§ 4

Ambulante Operationen in Krankenhäusern

Ambulante Operationen sind

- medizinisch notwendige operative Eingriffe ab Operationsgruppe 3,
- die üblicherweise einen Aufenthalt von mindestens 24 Stunden erfordern und
- in Krankenhäusern oder tagesklinischen Einrichtungen, die sowohl rechtlich, wirtschaftlich als auch organisatorisch an ein bettenführendes Krankenhaus angegliedert sind, durchgeführt werden.

Das für die Einstufung eines Eingriffs maßgebliche Operationsgruppenschema kann auf der Homepage des Versicherers unter folgendem Link eingesehen werden:

<https://www.generali.at/service/krankenversicherung-operationsgruppenschema.html>

Für ambulante Operationen in selbstständigen Tageskliniken oder in Ordinationen niedergelassener Fachärzte werden keine Leistungen erbracht.

§ 5

Akut-Geriatrie und Remobilisation

Für medizinisch notwendige stationäre Akut-Geriatrie und Remobilisation im Anschluss an eine stationäre Heilbehandlung wird eine Leistung für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr erbracht.

Erfolgen Akut-Geriatrie bzw. Remobilisation in einem Krankenhaus (Abteilung), mit dem der Versicherer dafür einen Vertrag abgeschlossen hat, werden die vereinbarten Kosten mit dem Vertragskrankenhaus gemäß § 2 direkt verrechnet. In allen übrigen Fällen wird das dafür im Leistungstarif angeführte Ersatztagegeld ausbezahlt.

§ 6

Hospiz, Palliativstation

Für medizinisch notwendige stationäre Aufenthalte in einem Hospiz oder einer Palliativstation eines Krankenhauses wird eine Leistung für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr erbracht.

Erfolgt der Aufenthalt in einer Einrichtung, mit der der Versicherer dafür einen Vertrag abgeschlossen hat, werden die vereinbarten Kosten mit der Vertragseinrichtung gemäß § 2 direkt verrechnet. In allen übrigen Fällen wird das dafür im Leistungstarif angeführte Ersatztagegeld ausbezahlt.

§ 7

Tarifliche Leistungen

(1) Umfang einzelner tariflicher Leistungen

1. Tageskosten

umfassen die zu bezahlenden Kosten für Verpflegungs- und Krankenhausgebühren (für die Unterbringung, Pflege und Verpflegung).

2. Behandlungshonorar

umfasst alle ärztlichen Honorare (auch Honorare für Hebammen) ausgenommen die Honorare für technische Untersuchungen wie bildgebende Verfahren, Labor, Nuklearmedizin etc.

Soweit Kosten aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Vereinbarungen mit dem Versicherer betraglich

geregelt sind, ist der Versicherer zum Ersatz darüber hinausgehender Kosten (z.B. Sonderhonorare der Vorstände von Universitätskliniken gemäß § 46 KaKuG und ausführende Landesgesetze) nicht verpflichtet.

3. Technische Leistungen

umfassen die Honorare für technische Untersuchungen wie bildgebende Verfahren, Labor, Nuklearmedizin etc. und sämtlichen Sachaufwand einschließlich der Kosten für Benützung des Operationssaales, der Arzneimittel (Heilmittel) und Heilbehelfe.

(2) Stationäre Heilbehandlung in Krankenhäusern

Bei stationärer Heilbehandlung in Krankenhäusern, die im Krankenhausverzeichnis nicht enthalten sind, werden für die Kosten des Aufenthaltes die Leistungen gemäß der für

- Tageskosten,
 - Behandlungshonorar,
 - Technische Leistungen, und
 - Summenleistung
- festgesetzten Beträgen erbracht.

(3) Tagesklinische Heilbehandlung in Krankenhäusern

Für tagesklinische Heilbehandlungen in Krankenhäusern, mit denen dafür keine vertraglichen Vereinbarungen über die Kostenübernahme bestehen, werden für die Kosten die folgenden tariflichen Leistungen wie für eine eintägige stationäre Heilbehandlung erbracht:

- Tageskosten,
- Behandlungshonorar,
- Technische Leistungen und
- Summenleistung.

(4) Ambulante Operationen in Krankenhäusern

Für ambulante Operationen in Krankenhäusern oder an diese angegliederten tagesklinischen Einrichtungen, mit denen dafür keine vertraglichen Vereinbarungen über die Kostenübernahme bestehen, wird das tarifliche Behandlungshonorar für die betreffende Operationsgruppe bezahlt.

§ 8

GesundheitsCoaching

(1) Informationen über medizinische Einrichtungen und Gesundheitsdienste

werden bei einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung zu folgenden Themen erteilt:

- Medizinische Einrichtungen weltweit,
- Krankenanstalten in Österreich (öffentlich, privat),
- Transporteinrichtungen in Österreich.

1. Informationen über medizinische Einrichtungen außerhalb Österreichs

werden erteilt, wenn für die spezielle medizinische Behandlung kein geeigneter Arzt bzw. keine geeignete medizinische Einrichtung in Österreich vorhanden oder ärztliche Hilfe während eines Auslandsaufenthaltes erforderlich ist.

2. Informationen über Transporteinrichtungen in Österreich

werden erteilt, wenn der Versicherte aufgrund der Art der Erkrankung bzw. durch die Unfallfolgen oder wegen der ärztlich angeordneten Verhaltensmaßregeln außerstande ist, den Arzt oder die medizinische Einrichtung aus eigener Kraft aufzusuchen.

(2) Hilfe im Notfall

Ein medizinischer Notfall liegt vor, wenn der Versicherte von einer unmittelbaren Gefahr (z.B. akute Erkrankung, Unfall, drohende Einwirkung schädigender Stoffe) für Leben, körperliche Unversehrtheit oder Gesundheit bedroht ist.

In allen medizinischen Notfällen ist der Versicherer rund um die Uhr erreichbar und

- unterstützt durch Herstellung der Verbindung und Organisation des Transports zu allen Notfalleinrichtungen in Österreich:

- Nacht- und Wochenenddienste durch Ärzte für Allgemeinmedizin und Zahnärzte bzw. Apotheken, nächstgelegenes geeignetes Krankenhaus,
- sonstige Notdienste (z.B. Rotes Kreuz, Vergiftungszentrale, psychosoziale Dienste)

oder

- veranlasst - abhängig vom Gesundheitszustand des Versicherten - einen zeitnahen Rückruf von einem Arzt zur telefonischen Abklärung und Beratung über weitere Maßnahmen.

(3) **Bester Arzt, bester Therapeut**

Bei einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung unterstützt der Versicherer den Versicherten bei der Suche nach dem hinsichtlich

- des konkreten Beschwerdebildes am besten geeigneten Arzt, bzw.
- der ärztlich empfohlenen Maßnahmen am besten geeigneten Therapeuten.

(4) **Ärztliche Zweitmeinung (Second Opinion)**

Bei einer notwendigen medizinischen Heilbehandlung nennt der Versicherer auf Wunsch des Versicherten einen Spezialisten, wenn eine Therapie bzw. ein Eingriff von einem Arzt bereits geplant ist.

(5) **Herstellung der Verbindung**

erfolgt nur auf Wunsch des Versicherten.

Der Versicherer stellt nur den erstmaligen Kontakt her, in weiterer Folge wendet sich der Versicherte selbst an den Arzt/Therapeuten, die medizinische Einrichtung oder den Gesundheitsdienst.

(6) **Haftungsausschluss**

Durch die Informationsleistung bzw. Herstellung der Verbindung gewährleistet der Versicherer nicht die Verfügbarkeit der Leistungen des betreffenden Arztes/Therapeuten, der medizinischen Einrichtung oder des Gesundheitsdienstes in einem bestimmten Umfang oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes.

(7) **Leistungen des persönlichen GesundheitsCoaches**

werden für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten durch dafür qualifizierte Mitarbeiter eines Vertragspartners des Versicherers erbracht.

Dieser Zeitraum beginnt

- bei der Begleitung während der Genesung und Unterstützung bei der besseren Bewältigung der durch den Versicherungsfall bedingten Lebenssituation mit der medizinisch notwendigen stationären Heilbehandlung;
- bei der Erarbeitung einer Strategie zur Reduktion von Risikofaktoren und Unterstützung bei Maßnahmen zur Umstellung hin zu einem gesünderen Lebensstil mit der erstmaligen Kontaktaufnahme des Versicherten mit dem GesundheitsCoach.

Der Versicherer trägt die Kosten der Begleitung und Unterstützung durch den persönlichen GesundheitsCoach, leistet jedoch keinen Kostenersatz für von diesem erarbeitete oder vorgeschlagene Maßnahmen (z.B. Kosten gesünderer Lebensmittel oder eines Fitnesstrainings).

(8) **Nachweis der Anspruchsvoraussetzungen**

Außer bei "Hilfe im Notfall" kann der Versicherer verlangen, dass der Versicherte die Anspruchsvoraussetzungen der oben angeführten Leistungen durch entsprechende medizinische Unterlagen (ärztliche Befunde, Rezepte für Arzneien, etc.) nachweist.

§ 9

Änderung der Prämie und des Versicherungsschutzes

(1) Der Tarif SJN unterliegt der Anpassung gemäß § 17 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017.

(2) In Ergänzung zu § 17 Abs. 1 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 gilt:

Kann in einem Bundesland über die Höhe der Krankenhauskosten und Honorare kein Einvernehmen hergestellt werden, wird der Anpassung die jeweilige Veränderung des von Statistik Austria verlautbarten Index der Verbraucherpreise zugrundegelegt.

(3) In Ergänzung zu § 17 Abs. 2 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 gilt:

Ergibt der Vergleich der in § 17 Abs. 1 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 genannten Faktoren eine Änderung der zu erwartenden Leistungen um mindestens die in der Grundtarifstufe SJN1 festgelegten Leistungen, so erfolgt eine Anpassung um die entsprechende Anzahl von Grundtarifstufen.

(4) Ergibt der Vergleich der in § 17 Abs. 1 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 genannten Faktoren einen Änderungsbedarf für die Prämie der Grundtarifstufe SJN1, so wird die Prämie der Grundtarifstufe SJN1 entsprechend angepasst.

(5) In Ergänzung zu § 17 Abs. 3 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 gilt:

Ob und in welchem Umfang der Versicherer zur Kostenübernahme (§ 1 Abs. 1 - 3) verpflichtet ist, ergibt sich aus der zuletzt gültigen Polizza.

Ergänzende Versicherungsbedingungen für MedCare: Allgemeine Gebührenklasse - Tarif SJN (EB_SJNA_17)

Vertragspartner

Diese Vertragsgrundlagen gelten für Verträge mit der Generali Versicherung AG, 1010 Wien, Landskrongasse 1-3.

Aufsichtsbehörde

Finanzmarktaufsicht, 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5



§ 1

Kostenübernahme in Krankenanstalten

(1) Kostenübernahme in öffentlichen Krankenhäusern in Österreich

Nimmt der Versicherte eine Behandlung in der Allgemeinen Gebührenklasse eines öffentlichen Krankenhauses in Österreich in Anspruch, so werden die vereinbarten Kosten anstelle der tariflichen Leistungen in voller Höhe übernommen und mit dem Krankenhaus direkt verrechnet.

(2) Kostenübernahme in Europa (Europaliste)

Nimmt der Versicherte eine Behandlung in der Allgemeinen Gebührenklasse eines öffentlichen Krankenhauses im europäischen Ausland (siehe Krankenhausverzeichnis/Europaliste) in Anspruch, so werden die Kosten der Pflege und Verpflegung, von Operationen und Behandlung anstelle der tariflichen Leistungen in voller Höhe übernommen.

(3) Weltweite Kostenübernahme

Nimmt der Versicherte eine Behandlung in der Allgemeinen Gebührenklasse eines öffentlichen Krankenhauses außerhalb Österreichs und Europas (siehe Europaliste) in Anspruch, so werden die Kosten der Pflege und Verpflegung, von Operationen und Behandlung anstelle der tariflichen Leistungen in voller Höhe übernommen, wenn

- a) die Behandlung in Österreich gleichwertig nicht durchgeführt werden kann, diese ärztlich empfohlen wurde und der Versicherer vorher eine Kostenübernahmeerklärung abgegeben hat. Der Versicherer gibt eine Kostenübernahmeerklärung ab, wenn er über die geplante Behandlung informiert wurde und dadurch Gelegenheit hatte, vor Beginn der Behandlung mit dem betreffenden Krankenhaus über die Höhe der Kosten Einvernehmen herzustellen.
- b) wegen eines Unfalles oder einer akut auftretenden Erkrankung während eines Aufenthaltes mit einer geplanten Dauer von bis zu 6 Wochen in diesen Ländern eine Heilbehandlung medizinisch notwendig und eine Rückkehr nach Österreich aus medizinischen Gründen nicht möglich ist.

Bei Kostenübernahme gemäß Pkt. a) wird der für "Kosten des Krankenhaus- und Heimtransportes" festgesetzte Betrag verzehnfacht.

(4) Krankenhausverzeichnis - Garantietarife - Europaliste

Die öffentlichen Krankenhäuser in Österreich und die Länder der Europaliste sind im Krankenhausverzeichnis angeführt. Für alle öffentlichen Krankenhäuser sind für die volle Kostenübernahme zumindest erforderliche Tarifstufen definiert (Garantietarife).

Die Kostenübernahme aufgrund des versicherten Tarifs ist in der Polizza beschrieben.

Diese allgemeine Kostendeckungszusage kann im Sinn des § 178c VersVG vom Versicherer in geschriebener Form widerrufen werden. Der Widerruf wird nach Ablauf von drei Wochen wirksam.

(5) Selbstbehalt

1. Selbstbehalt bei Krankheit

Ist der versicherte Tarif niedriger als der für das betreffende Krankenhaus gültige Garantietarif, so gilt die Kostenübernahme für die Allgemeine Gebührenklasse (Abs. 1 bis 3) mit dem auf der Polizze angeschriebenen Selbstbehalt pro Aufenthaltstag vereinbart.

Dieser Selbstbehalt ist je Kalenderjahr für höchstens 5 Tage, zu bezahlen.

Erstreckt sich ein Krankenhausaufenthalt über den Jahreswechsel hinaus, ist auch für diesen Aufenthalt der Selbstbehalt mit höchstens 5 Tagen begrenzt.

Bei mehreren Krankenhausaufenthalten in unterschiedlichen Krankenhäusern innerhalb eines Kalenderjahres sind ab dem 6. Aufenthaltstag die jeweils 5 höchsten Selbstbehalte maßgeblich.

Ist für das betreffende Krankenhaus ein Selbstbehalt vereinbart, der höher ist als die bisher verrechneten Selbstbehalte, so ist dieser höhere Selbstbehalt zu bezahlen. Von diesem wird der jeweils niedrigste bereits bezahlte Selbstbehalt abgezogen und nur die Differenz vorgeschrieben.

2. Selbstbehalt bei Unfall

Nach einem Unfall gilt die Kostenübernahme für die Allgemeine Gebührenklasse eines Öffentlichen Krankenhauses (Abs. 1 bis 3) innerhalb von 2 Jahren ab dem Unfalltag ohne Selbstbehalt.

2.1 Ein Unfall liegt vor, wenn der Versicherte durch ein plötzlich von außen auf seinen Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.

2.2 Als Unfall gelten auch:

- a) Zerreißen von an Gliedmaßen und an der Wirbelsäule befindlichen Muskeln, Sehnen, Bändern und Kapseln sowie Meniskusverletzungen infolge plötzlicher Abweichung vom geplanten Bewegungsablauf, wenn sie innerhalb von 7 Tagen ab dem Ereignistag medizinisch dokumentiert und ärztlich behandelt wurden.
- b) Bandscheibenhernien, wenn sie durch eine plötzliche, erhebliche direkte Gewalteinwirkung auf das jeweilige Segment der Wirbelsäule verursacht werden, und
 - diese durch Kraft und Richtung in der Lage war, eine gesunde Bandscheibe zu zerreißen, die bildgebende Untersuchung nach dem Unfall (wie MRT, Röntgen) keine degenerativen Veränderungen zeigt und vor dem Unfall keine Wirbelsäulenbeschwerden bestanden; oder
 - Frakturen ober- oder unterhalb der geschädigten Bandscheibe vorliegen; oder
 - es zu Bänderissen im Bereich der Wirbelsäule mit Wirbelverrenkungen gekommen ist.
- c) Bauch- und Unterleibsbrüche, wenn sie durch eine plötzlich von außen kommende mechanische Einwirkung direkt herbeigeführt worden sind und nicht anlagenbedingt waren.

2.3 Als Unfälle gelten nicht:

- a) Fehl- und Frühgeburten, die durch einen Unfall herbeigeführt worden sind;
- b) Unfälle als Folgen einer Krankheit.

(6) Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung

Ist für eine stationäre Heilbehandlung Kostenersatz oder Kostenbeteiligung durch einen Träger der gesetzlichen Unfallversicherung vorgesehen, erfolgt die Kostenübernahme unter der Voraussetzung, dass der betreffende Versicherungsträger die ihm obliegende Leistung erbringt.

(7) Gesetzliche Krankenversicherung

Der Tarif SJN setzt voraus, dass der Versicherte in Österreich keiner gesetzlichen Krankenversicherung unterliegt. Der Eintritt in die gesetzliche Krankenversicherung wirkt sich daher auf den Versicherungsschutz aus. Damit in diesem Fall weiterhin ein geeigneter Versicherungsschutz besteht, ist es erforderlich, dass der Versicherungsnehmer den Versicherer umgehend verständigt.

§ 2

Direktverrechnung

Sofern eine Vereinbarung mit dem Leistungsträger (Krankenhaus, Arzt) besteht, erfolgt auf Grundlage dieser Vereinbarung die direkte Verrechnung der Kosten und Honorare zwischen dem Versicherer und dem Leistungserbringer.

Weitere Grundlage ist eine vom Versicherten vor Antritt der Heilbehandlung anzufordernde Kostenübernahmeerklärung. Die Art der Erkrankung und die Notwendigkeit der Heilbehandlung sind in dieser Anforderung medizinisch nachzuweisen. Lässt die Dringlichkeit der Heilbehandlung eine vorhergehende Anfrage nicht zu, ist diese spätestens drei Arbeitstage ab Antritt der Heilbehandlung nachzureichen.

Der Versicherte hat der Ermittlung von zum Zwecke der Direktverrechnung erforderlichen Daten zuzustimmen. Wird die Zustimmungserklärung verweigert, widerrufen oder verspätet erteilt und stellt der Leistungserbringer Kosten und Honorare dem Versicherten in Rechnung, ist der Versicherer diesem gegenüber nur in dem in der Vereinbarung über die Direktverrechnung festgelegten Ausmaß zur Leistung verpflichtet.

§ 3

Tagesklinische Behandlung in Krankenhäusern

Tagesklinische Heilbehandlungen sind Heilbehandlungen in einem Krankenhaus, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Art der Heilbehandlung erfordert üblicherweise einen Aufenthalt von mindestens 24 Stunden,
 - der Versicherte wird noch am Tag der Aufnahme aus dem Krankenhaus entlassen, und
 - für die Heilbehandlung wird die Infrastruktur einer Abteilung des Krankenhauses in Anspruch genommen (z.B. Aufnahme in der Bettenstation, Benutzung eines Operationssaales).
- Heilbehandlungen und Operationen in der Ambulanz eines Krankenhauses stellen jedenfalls keine tagesklinischen Behandlungen dar.

§ 4

Ambulante Operationen in Krankenhäusern

Ambulante Operationen sind

- medizinisch notwendige operative Eingriffe ab Operationsgruppe 3,
- die üblicherweise einen Aufenthalt von mindestens 24 Stunden erfordern und
- in Krankenhäusern oder tagesklinischen Einrichtungen, die sowohl rechtlich, wirtschaftlich als auch organisatorisch an ein bettenführendes Krankenhaus angegliedert sind, durchgeführt werden.

Das für die Einstufung eines Eingriffs maßgebliche Operationsgruppenschema kann auf der Homepage des Versicherers unter folgendem Link eingesehen werden:

<https://www.generali.at/service/krankenversicherung-operationsgruppenschema.html>

Für ambulante Operationen in selbstständigen Tageskliniken oder in Ordinationen niedergelassener Fachärzte werden keine Leistungen erbracht.

§ 5

Akut-Geriatrie und Remobilisation

Für medizinisch notwendige stationäre Akut-Geriatrie und Remobilisation im Anschluss an eine stationäre Heilbehandlung wird eine Leistung für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr erbracht.

Erfolgen Akut-Geriatrie bzw. Remobilisation in einem Krankenhaus (Abteilung), mit dem der Versicherer dafür einen Vertrag abgeschlossen hat, werden die vereinbarten Kosten mit dem Vertragskrankenhaus gemäß § 2 direkt verrechnet. In allen übrigen Fällen wird das dafür im Leistungstarif angeführte Ersatztaggeld ausbezahlt.

§ 6

Hospiz, Palliativstation

Für medizinisch notwendige stationäre Aufenthalte in einem Hospiz oder einer Palliativstation eines Krankenhauses wird eine Leistung für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr erbracht.

Erfolgt der Aufenthalt in einer Einrichtung, mit der der Versicherer dafür einen Vertrag abgeschlossen hat, werden die vereinbarten Kosten mit der Vertragseinrichtung gemäß § 2 direkt verrechnet. In allen übrigen Fällen wird das dafür im Leistungstarif angeführte Ersatztaggeld ausbezahlt.

§ 7

Tarifliche Leistungen

(1) Umfang einzelner tariflicher Leistungen

1. Tageskosten

umfassen die zu bezahlenden Kosten für Verpflegs- und Krankenhausgebühren (für die Unterbringung, Pflege und Verpflegung).

2. Behandlungshonorar

umfasst alle ärztlichen Honorare (auch Honorare für Hebammen) ausgenommen die Honorare für technische Untersuchungen wie bildgebende Verfahren, Labor, Nuklearmedizin etc.

Soweit Kosten aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Vereinbarungen mit dem Versicherer betraglich geregelt sind, ist der Versicherer zum Ersatz darüber hinausgehender Kosten (z.B. Sonderhonorare der Vorstände von Universitätskliniken gemäß § 46 KaKuG und ausführende Landesgesetze) nicht verpflichtet.

3. Technische Leistungen

umfassen die Honorare für technische Untersuchungen wie bildgebende Verfahren, Labor, Nuklearmedizin etc. und sämtlichen Sachaufwand einschließlich der Kosten für Benützung des Operationssaales, der Arzneimittel (Heilmittel) und Heilbeihilfe.

(2) Stationäre Heilbehandlung in Krankenhäusern

Bei stationärer Heilbehandlung in Krankenhäusern, die im Krankenhausverzeichnis nicht enthalten sind, werden für die Kosten des Aufenthaltes die Leistungen gemäß der für

- Tageskosten,
- Behandlungshonorar,
- Technische Leistungen, und
- Summenleistung

festgesetzten Beträgen erbracht.

(3) Tagesklinische Heilbehandlung in Krankenhäusern

Für tagesklinische Heilbehandlungen in Krankenhäusern, mit denen dafür keine vertraglichen Vereinbarungen über die Kostenübernahme bestehen, werden für die Kosten die folgenden tariflichen Leistungen wie für eine eintägige stationäre Heilbehandlung erbracht:

- Tageskosten,
- Behandlungshonorar,
- Technische Leistungen und
- Summenleistung.

(4) Ambulante Operationen in Krankenhäusern

Für ambulante Operationen in Krankenhäusern oder an diese angegliederten tagesklinischen Einrichtungen, mit denen dafür keine vertraglichen Vereinbarungen über die Kostenübernahme bestehen, wird das tarifliche Behandlungshonorar für die betreffende Operationsgruppe bezahlt.

§ 8

GesundheitsCoaching

(1) Informationen über medizinische Einrichtungen und Gesundheitsdienste

werden bei einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung zu folgenden Themen erteilt:

- Medizinische Einrichtungen weltweit,
- Krankenanstalten in Österreich (öffentlich, privat),
- Transporteinrichtungen in Österreich.

1. Informationen über medizinische Einrichtungen außerhalb Österreichs

werden erteilt, wenn für die spezielle medizinische Behandlung kein geeigneter Arzt bzw. keine geeignete medizinische Einrichtung in Österreich vorhanden oder ärztliche Hilfe während eines Auslandsaufenthaltes erforderlich ist.

2. Informationen über Transporteinrichtungen in Österreich

werden erteilt, wenn der Versicherte aufgrund der Art der Erkrankung bzw. durch die Unfallfolgen oder wegen der

ärztlich angeordneten Verhaltensmaßnahmen außerstande ist, den Arzt oder die medizinische Einrichtung aus eigener Kraft aufzusuchen.

(2) **Hilfe im Notfall**

Ein medizinischer Notfall liegt vor, wenn der Versicherte von einer unmittelbaren Gefahr (z.B. akute Erkrankung, Unfall, drohende Einwirkung schädigender Stoffe) für Leben, körperliche Unversehrtheit oder Gesundheit bedroht ist.

In allen medizinischen Notfällen ist der Versicherer rund um die Uhr erreichbar und

- unterstützt durch Herstellung der Verbindung und Organisation des Transports zu allen Notfalleinrichtungen in Österreich:

- Nacht- und Wochenenddienste durch Ärzte für Allgemeinmedizin und Zahnärzte bzw. Apotheken, nächstgelegenes geeignetes Krankenhaus,
- sonstige Notdienste (z.B. Rotes Kreuz, Vergiftungszentrale, psychosoziale Dienste)

oder

- veranlasst - abhängig vom Gesundheitszustand des Versicherten - einen zeitnahen Rückruf von einem Arzt zur telefonischen Abklärung und Beratung über weitere Maßnahmen.

(3) **Bester Arzt, bester Therapeut**

Bei einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung unterstützt der Versicherer den Versicherten bei der Suche nach dem hinsichtlich

- des konkreten Beschwerdebildes am besten geeigneten Arzt, bzw.
- der ärztlich empfohlenen Maßnahmen am besten geeigneten Therapeuten.

(4) **Ärztliche Zweitmeinung (Second Opinion)**

Bei einer notwendigen medizinischen Heilbehandlung nennt der Versicherer auf Wunsch des Versicherten einen Spezialisten, wenn eine Therapie bzw. ein Eingriff von einem Arzt bereits geplant ist.

(5) **Herstellung der Verbindung**

erfolgt nur auf Wunsch des Versicherten.

Der Versicherer stellt nur den erstmaligen Kontakt her, in weiterer Folge wendet sich der Versicherte selbst an den Arzt/Therapeuten, die medizinische Einrichtung oder den Gesundheitsdienst.

(6) **Haftungsausschluss**

Durch die Informationsleistung bzw. Herstellung der Verbindung gewährleistet der Versicherer nicht die Verfügbarkeit der Leistungen des betreffenden Arztes/Therapeuten, der medizinischen Einrichtung oder des Gesundheitsdienstes in einem bestimmten Umfang oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes.

(7) **Leistungen des persönlichen GesundheitsCoaches**

werden für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten durch dafür qualifizierte Mitarbeiter eines Vertragspartners des Versicherers erbracht.

Dieser Zeitraum beginnt

- bei der Begleitung während der Genesung und Unterstützung bei der besseren Bewältigung der durch den Versicherungsfall bedingten Lebenssituation mit der medizinisch notwendigen stationären Heilbehandlung;
- bei der Erarbeitung einer Strategie zur Reduktion von Risikofaktoren und Unterstützung bei Maßnahmen zur Umstellung hin zu einem gesünderen Lebensstil mit der erstmaligen Kontaktaufnahme des Versicherten mit dem GesundheitsCoach.

Der Versicherer trägt die Kosten der Begleitung und Unterstützung durch den persönlichen GesundheitsCoach, leistet jedoch keinen Kostenersatz für von diesem erarbeitete oder vorgeschlagene Maßnahmen (z.B. Kosten gesünderer Lebensmittel oder eines Fitnesstrainings).

(8) **Nachweis der Anspruchsvoraussetzungen**

Außer bei "Hilfe im Notfall" kann der Versicherer verlangen, dass der Versicherte die Anspruchsvoraussetzungen der oben angeführten Leistungen durch entsprechende medizinische Unterlagen (ärztliche Befunde, Rezepte für Arzneien, etc.) nachweist.

§ 9

Änderung der Prämie und des Versicherungsschutzes

- (1) Der Tarif SJN unterliegt der Anpassung gemäß § 17 AVBKV 2017 / AVBKV 2017.

- (2) In Ergänzung zu § 17 Abs. 1 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 gilt:
Kann in einem Bundesland über die Höhe der Krankenhauskosten und Honorare kein Einvernehmen hergestellt werden, wird der Anpassung die jeweilige Veränderung des von Statistik Austria verlautbarten Index der Verbraucherpreise zugrundegelegt.
- (3) In Ergänzung zu § 17 Abs. 2 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 gilt:
Ergibt der Vergleich der in § 17 Abs. 1 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 genannten Faktoren eine Änderung der zu erwartenden Leistungen um mindestens die in der Grundtarifstufe SJN1 festgelegten Leistungen, so erfolgt eine Anpassung um die entsprechende Anzahl von Grundtarifstufen.
- (4) Ergibt der Vergleich der in § 17 Abs. 1 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 genannten Faktoren einen Änderungsbedarf für die Prämie der Grundtarifstufe SJN1, so wird die Prämie der Grundtarifstufe SJN1 entsprechend angepasst.
- (5) In Ergänzung zu § 17 Abs. 3 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 gilt:
Ob und in welchem Umfang der Versicherer zur Kostenübernahme (§ 1 Abs. 1 - 3) verpflichtet ist, ergibt sich aus der zuletzt gültigen Polizze.

Ergänzende Versicherungsbedingungen für MedCare: Sonderklasse für Grenzgänger - Tarif SJN (EB_SJNG_17)

Vertragspartner

Diese Vertragsgrundlagen gelten für Verträge mit der Generali Versicherung AG, 1010 Wien, Landskronergasse 1-3.

Aufsichtsbehörde

Finanzmarktaufsicht, 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5



§ 1

Kostenübernahme in Krankenanstalten

(1) Kostenübernahme in den Vertragskrankenhäusern in Österreich laut Krankenhausverzeichnis

Nimmt der Versicherte eine Behandlung in einem Vertragskrankenhaus in Österreich in Anspruch, so werden die vereinbarten Kosten einschließlich der ärztlichen Honorare anstelle der tariflichen Leistungen in voller Höhe übernommen und mit dem Krankenhaus direkt verrechnet.

(2) Kostenübernahme in Europa (Europaliste)

Nimmt der Versicherte eine Behandlung in einem allgemeinen öffentlichen Krankenhaus im europäischen Ausland (siehe Krankenhausverzeichnis/Europaliste) in Anspruch, so werden die Kosten der Pflege und Verpflegung, von Operationen und Behandlung einschließlich der ärztlichen Honorare anstelle der tariflichen Leistungen in voller Höhe übernommen.

(3) Weltweite Kostenübernahme

Nimmt der Versicherte eine Behandlung in einem allgemeinen öffentlichen Krankenhaus außerhalb Österreichs und Europas (siehe Europaliste) in Anspruch, so werden die Kosten der Pflege und Verpflegung, von Operationen und Behandlung einschließlich der ärztlichen Honorare anstelle der tariflichen Leistungen in voller Höhe übernommen, wenn

- a) die Behandlung in Österreich gleichwertig nicht durchgeführt werden kann, diese ärztlich empfohlen wurde und der Versicherer vorher eine Kostenübernahmeerklärung abgegeben hat. Der Versicherer gibt eine Kostenübernahmeerklärung ab, wenn er über die geplante Behandlung informiert wurde und dadurch Gelegenheit hatte, vor Beginn der Behandlung mit dem betreffenden Krankenhaus über die Höhe der Kosten Einvernehmen herzustellen.
- b) wegen eines Unfalles oder einer akut auftretenden Erkrankung während eines Aufenthaltes mit einer geplanten Dauer von bis zu 6 Wochen in diesen Ländern eine Heilbehandlung medizinisch notwendig und eine Rückkehr nach Österreich aus medizinischen Gründen nicht möglich ist.

Bei Kostenübernahme gemäß Pkt. a) wird der für "Kosten des Krankenhaus- und Heimtransportes" festgesetzte Betrag verzehnfacht.

(4) Krankenhausverzeichnis - Garantietarife - Europaliste

Die Vertragskrankenhäuser in Österreich und die Länder der Europaliste sind im Krankenhausverzeichnis angeführt. Für alle Vertragskrankenhäuser sind für die volle Kostenübernahme zumindest erforderliche Tarifstufen definiert (Garantietarife).

Die Kostenübernahme aufgrund des versicherten Tarifs ist in der Polizze beschrieben.

Diese allgemeine Kostendeckungszusage kann im Sinn des § 178c VersVG vom Versicherer in geschriebener Form widerrufen werden. Der Widerruf wird nach Ablauf von drei Wochen wirksam.

(5) Selbstbehalt

1. Selbstbehalt bei Krankheit

Ist der versicherte Tarif niedriger als der für das betreffende Krankenhaus bzw. die betreffende Zimmerkategorie gültige Garantietarif, so gilt die Kostenübernahme (Abs. 1 bis 3) mit dem auf der Polizze angeschriebenen Selbstbehalt pro Aufenthaltstag vereinbart.

Dieser Selbstbehalt ist je Kalenderjahr für höchstens 5 Tage, zu bezahlen.

Erstreckt sich ein Krankenhausaufenthalt über den Jahreswechsel hinaus, ist auch für diesen Aufenthalt der Selbstbehalt mit höchstens 5 Tagen begrenzt.

Bei mehreren Krankenhausaufenthalten in unterschiedlichen Krankenhäusern oder Zimmerkategorien innerhalb eines Kalenderjahres sind ab dem 6. Aufenthaltstag die jeweils 5 höchsten Selbstbehalte maßgeblich.

Ist für das betreffende Krankenhaus bzw. die betreffende Zimmerkategorie ein Selbstbehalt vereinbart, der höher ist als die bisher verrechneten Selbstbehalte, so ist dieser höhere Selbstbehalt zu bezahlen. Von diesem wird der jeweils niedrigste bereits bezahlte Selbstbehalt abgezogen und nur die Differenz vorgeschrieben.

2. Selbstbehalt bei Unfall

Innerhalb von 2 Jahren ab dem Unfalltag gilt die Kostenübernahme (Abs. 1 - 3) ohne die Selbstbehalte, die in der Polizze für die vereinbarte Zimmerkategorie angeführt sind.

Lautet die vereinbarte Zimmerkategorie auf "Zweibettzimmer", wird der Differenzbetrag auf den anzuwendenden höheren Selbstbehalt für "Einbettzimmer" verrechnet.

2.1 Ein Unfall liegt vor, wenn der Versicherte durch ein plötzlich von außen auf seinen Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.

2.2 Als Unfall gelten auch:

- a) Zerreißen von an Gliedmaßen und an der Wirbelsäule befindlichen Muskeln, Sehnen, Bändern und Kapseln sowie Meniskusverletzungen infolge plötzlicher Abweichung vom geplanten Bewegungsablauf, wenn sie innerhalb von 7 Tagen ab dem Ereignistag medizinisch dokumentiert und ärztlich behandelt wurden.
- b) Bandscheibenhernien, wenn sie durch eine plötzliche, erhebliche direkte Gewalteinwirkung auf das jeweilige Segment der Wirbelsäule verursacht werden, und
 - diese durch Kraft und Richtung in der Lage war, eine gesunde Bandscheibe zu zerreißen, die bildgebende Untersuchung nach dem Unfall (wie MRT, Röntgen) keine degenerativen Veränderungen zeigt und vor dem Unfall keine Wirbelsäulenbeschwerden bestanden; oder
 - Frakturen ober- oder unterhalb der geschädigten Bandscheibe vorliegen; oder
 - es zu Bänderrissen im Bereich der Wirbelsäule mit Wirbelverrenkungen gekommen ist.
- c) Bauch- und Unterleibsbrüche, wenn sie durch eine plötzlich von außen kommende mechanische Einwirkung direkt herbeigeführt worden sind und nicht anlagenbedingt waren.

2.3 Als Unfälle gelten nicht:

- a) Fehl- und Frühgeburten, die durch einen Unfall herbeigeführt worden sind;
- b) Unfälle als Folgen einer Krankheit.

(6) Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung

Ist für eine stationäre Heilbehandlung Kostenersatz oder Kostenbeteiligung durch einen Träger der gesetzlichen Unfallversicherung vorgesehen, erfolgt die Kostenübernahme unter der Voraussetzung, dass der betreffende Sozialversicherungsträger die ihm obliegende Leistung erbringt.

(7) Gesetzliche Krankenversicherung

Der Tarif SJN setzt voraus, dass der Versicherte in Österreich keiner gesetzlichen Krankenversicherung unterliegt. Der Eintritt in die gesetzliche Krankenversicherung wirkt sich daher auf den Versicherungsschutz aus. Damit in diesem Fall weiterhin ein geeigneter Versicherungsschutz besteht, ist es erforderlich, dass der Versicherungsnehmer den Versicherer umgehend verständigt.

§ 2

Direktverrechnung

Sofern eine Vereinbarung mit dem Leistungsträger (Krankenhaus, Arzt) besteht, erfolgt auf Grundlage dieser Vereinbarung die direkte Verrechnung der Kosten und Honorare zwischen dem Versicherer und dem Leistungserbringer.

Weitere Grundlage ist eine vom Versicherten vor Antritt der Heilbehandlung anzufordernde Kostenübernahmeerklärung. Die Art der Erkrankung und die Notwendigkeit der Heilbehandlung sind in dieser Anforderung medizinisch nachzuweisen. Lässt die Dringlichkeit der Heilbehandlung eine vorhergehende Anfrage nicht zu, ist diese spätestens drei Arbeitstage ab Antritt der Heilbehandlung nachzureichen.

Der Versicherte hat der Ermittlung von zum Zwecke der Direktverrechnung erforderlichen Daten zuzustimmen. Wird die Zustimmungserklärung verweigert, widerrufen oder verspätet erteilt und stellt der Leistungserbringer Kosten und Honorare dem Versicherten in Rechnung, ist der Versicherer diesem gegenüber nur in dem in der Vereinbarung über die Direktverrechnung festgelegten Ausmaß zur Leistung verpflichtet.

§ 3

Tagesklinische Behandlung in Krankenhäusern

Tagesklinische Heilbehandlungen sind Heilbehandlungen in einem Krankenhaus, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Art der Heilbehandlung erfordert üblicherweise einen Aufenthalt von mindestens 24 Stunden,
- der Versicherte wird noch am Tag der Aufnahme aus dem Krankenhaus entlassen, und
- für die Heilbehandlung wird die Infrastruktur einer Abteilung des Krankenhauses in Anspruch genommen (z.B. Aufnahme in der Bettenstation, Benutzung eines Operationssaales).

Heilbehandlungen und Operationen in der Ambulanz eines Krankenhauses stellen jedenfalls keine tagesklinischen Behandlungen dar.

§ 4

Ambulante Operationen in Krankenhäusern

Ambulante Operationen sind

- medizinisch notwendige operative Eingriffe ab Operationsgruppe 3,
- die üblicherweise einen Aufenthalt von mindestens 24 Stunden erfordern und
- in Krankenhäusern oder tagesklinischen Einrichtungen, die sowohl rechtlich, wirtschaftlich als auch organisatorisch an ein bettenführendes Krankenhaus angegliedert sind, durchgeführt werden.

Das für die Einstufung eines Eingriffs maßgebliche Operationsgruppenschema kann auf der Homepage des Versicherers unter folgendem Link eingesehen werden:

<https://www.generali.at/service/krankenversicherung-operationsgruppenschema.html>

Für ambulante Operationen in selbstständigen Tageskliniken oder in Ordinationen niedergelassener Fachärzte werden keine Leistungen erbracht.

§ 5

Akut-Geriatrie und Remobilisation

Für medizinisch notwendige stationäre Akut-Geriatrie und Remobilisation im Anschluss an eine stationäre Heilbehandlung wird eine Leistung für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr erbracht.

Erfolgen Akut-Geriatrie bzw. Remobilisation in einem Krankenhaus (Abteilung), mit dem der Versicherer dafür einen Vertrag abgeschlossen hat, werden die vereinbarten Kosten mit dem Vertragskrankenhaus gemäß § 2 direkt verrechnet. In allen übrigen Fällen wird das dafür im Leistungstarif angeführte Ersatztagegeld ausbezahlt.

§ 6

Hospiz, Palliativstation

Für medizinisch notwendige stationäre Aufenthalte in einem Hospiz oder einer Palliativstation eines Krankenhauses wird eine Leistung für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr erbracht.

Erfolgt der Aufenthalt in einer Einrichtung, mit der der Versicherer dafür einen Vertrag abgeschlossen hat, werden die vereinbarten Kosten mit der Vertragseinrichtung gemäß § 2 direkt verrechnet. In allen übrigen Fällen wird das dafür im Leistungstarif angeführte Ersatztagegeld ausbezahlt.

§ 7

Tarifliche Leistungen

(1) Umfang einzelner tariflicher Leistungen

1. Tageskosten

umfassen die zu bezahlenden Kosten für Verpflegungs- und Krankenhausgebühren (für die Unterbringung, Pflege und Verpflegung).

2. Behandlungshonorar

umfasst alle ärztlichen Honorare (auch Honorare für Hebammen) ausgenommen die Honorare für technische Untersuchungen wie bildgebende Verfahren, Labor, Nuklearmedizin etc.

Soweit Kosten aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Vereinbarungen mit dem Versicherer betraglich geregelt sind, ist der Versicherer zum Ersatz darüber hinausgehender Kosten (z.B. Sonderhonorare der Vorstände von Universitätskliniken gemäß § 46 KaKuG und ausführende Landesgesetze) nicht verpflichtet.

3. Technische Leistungen

umfassen die Honorare für technische Untersuchungen wie bildgebende Verfahren, Labor, Nuklearmedizin etc. und sämtlichen Sachaufwand einschließlich der Kosten für Benützung des Operationssaales, der Arzneimittel (Heilmittel) und Heilbehelfe.

(2) Stationäre Heilbehandlung in Krankenhäusern

Bei stationärer Heilbehandlung in Krankenhäusern, die im Krankenhausverzeichnis nicht enthalten sind, werden für die Kosten des Aufenthaltes die Leistungen gemäß der für

- Tageskosten,
- Behandlungshonorar,
- Technische Leistungen, und
- Summenleistung

festgesetzten Beträgen erbracht.

(3) Tagesklinische Heilbehandlung in Krankenhäusern

Für tagesklinische Heilbehandlungen in Krankenhäusern, mit denen dafür keine vertraglichen Vereinbarungen über die Kostenübernahme bestehen, werden für die Kosten die folgenden tariflichen Leistungen wie für eine eintägige stationäre Heilbehandlung erbracht:

- Tageskosten,
- Behandlungshonorar,
- Technische Leistungen und
- Summenleistung.

(4) Ambulante Operationen in Krankenhäusern

Für ambulante Operationen in Krankenhäusern oder an diese angegliederten tagesklinischen Einrichtungen, mit denen dafür keine vertraglichen Vereinbarungen über die Kostenübernahme bestehen, wird das tarifliche Behandlungshonorar für die betreffende Operationsgruppe bezahlt.

§ 8

GesundheitsCoaching

(1) Informationen über medizinische Einrichtungen und Gesundheitsdienste

werden bei einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung zu folgenden Themen erteilt:

- Medizinische Einrichtungen weltweit,
- Krankenanstalten in Österreich (öffentlich, privat),
- Transporteinrichtungen in Österreich.

1. Informationen über medizinische Einrichtungen außerhalb Österreichs

werden erteilt, wenn für die spezielle medizinische Behandlung kein geeigneter Arzt bzw. keine geeignete medizinische Einrichtung in Österreich vorhanden oder ärztliche Hilfe während eines Auslandsaufenthaltes erforderlich ist.

2. Informationen über Transporteinrichtungen in Österreich

werden erteilt, wenn der Versicherte aufgrund der Art der Erkrankung bzw. durch die Unfallfolgen oder wegen der

ärztlich angeordneten Verhaltensmaßnahmen außerstande ist, den Arzt oder die medizinische Einrichtung aus eigener Kraft aufzusuchen.

(2) **Hilfe im Notfall**

Ein medizinischer Notfall liegt vor, wenn der Versicherte von einer unmittelbaren Gefahr (z.B. akute Erkrankung, Unfall, drohende Einwirkung schädigender Stoffe) für Leben, körperliche Unversehrtheit oder Gesundheit bedroht ist.

In allen medizinischen Notfällen ist der Versicherer rund um die Uhr erreichbar und

- unterstützt durch Herstellung der Verbindung und Organisation des Transports zu allen Notfalleinrichtungen in Österreich:

- Nacht- und Wochenenddienste durch Ärzte für Allgemeinmedizin und Zahnärzte bzw. Apotheken, nächstgelegenes geeignetes Krankenhaus,
- sonstige Notdienste (z.B. Rotes Kreuz, Vergiftungszentrale, psychosoziale Dienste)

oder

- veranlasst - abhängig vom Gesundheitszustand des Versicherten - einen zeitnahen Rückruf von einem Arzt zur telefonischen Abklärung und Beratung über weitere Maßnahmen.

(3) **Bester Arzt, bester Therapeut**

Bei einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung unterstützt der Versicherer den Versicherten bei der Suche nach dem hinsichtlich

- des konkreten Beschwerdebildes am besten geeigneten Arzt, bzw.
- der ärztlich empfohlenen Maßnahmen am besten geeigneten Therapeuten.

(4) **Ärztliche Zweitmeinung (Second Opinion)**

Bei einer notwendigen medizinischen Heilbehandlung nennt der Versicherer auf Wunsch des Versicherten einen Spezialisten, wenn eine Therapie bzw. ein Eingriff von einem Arzt bereits geplant ist.

(5) **Herstellung der Verbindung**

erfolgt nur auf Wunsch des Versicherten.

Der Versicherer stellt nur den erstmaligen Kontakt her, in weiterer Folge wendet sich der Versicherte selbst an den Arzt/Therapeuten, die medizinische Einrichtung oder den Gesundheitsdienst.

(6) **Haftungsausschluss**

Durch die Informationsleistung bzw. Herstellung der Verbindung gewährleistet der Versicherer nicht die Verfügbarkeit der Leistungen des betreffenden Arztes/Therapeuten, der medizinischen Einrichtung oder des Gesundheitsdienstes in einem bestimmten Umfang oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes.

(7) **Leistungen des persönlichen GesundheitsCoaches**

werden für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten durch dafür qualifizierte Mitarbeiter eines Vertragspartners des Versicherers erbracht.

Dieser Zeitraum beginnt

- bei der Begleitung während der Genesung und Unterstützung bei der besseren Bewältigung der durch den Versicherungsfall bedingten Lebenssituation mit der medizinisch notwendigen stationären Heilbehandlung;
- bei der Erarbeitung einer Strategie zur Reduktion von Risikofaktoren und Unterstützung bei Maßnahmen zur Umstellung hin zu einem gesünderen Lebensstil mit der erstmaligen Kontaktaufnahme des Versicherten mit dem GesundheitsCoach.

Der Versicherer trägt die Kosten der Begleitung und Unterstützung durch den persönlichen GesundheitsCoach, leistet jedoch keinen Kostenersatz für von diesem erarbeitete oder vorgeschlagene Maßnahmen (z.B. Kosten gesünderer Lebensmittel oder eines Fitnesstrainings).

(8) **Nachweis der Anspruchsvoraussetzungen**

Außer bei "Hilfe im Notfall" kann der Versicherer verlangen, dass der Versicherte die Anspruchsvoraussetzungen der oben angeführten Leistungen durch entsprechende medizinische Unterlagen (ärztliche Befunde, Rezepte für Arzneien, etc.) nachweist.

§ 9

Änderung der Prämie und des Versicherungsschutzes

- (1) Der Tarif SJN unterliegt der Anpassung gemäß § 17 AVBKV 2017 / AVBKV 2017.

- (2) In Ergänzung zu § 17 Abs. 1 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 gilt:
Kann in einem Bundesland über die Höhe der Krankenhauskosten und Honorare kein Einvernehmen hergestellt werden, wird der Anpassung die jeweilige Veränderung des von Statistik Austria verlautbarten Index der Verbraucherpreise zugrundegelegt.
- (3) In Ergänzung zu § 17 Abs. 2 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 gilt:
Ergibt der Vergleich der in § 17 Abs. 1 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 genannten Faktoren eine Änderung der zu erwartenden Leistungen um mindestens die in der Grundtarifstufe SJN1 festgelegten Leistungen, so erfolgt eine Anpassung um die entsprechende Anzahl von Grundtarifstufen.
- (4) Ergibt der Vergleich der in § 17 Abs. 1 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 genannten Faktoren einen Änderungsbedarf für die Prämie der Grundtarifstufe SJN1, so wird die Prämie der Grundtarifstufe SJN1 entsprechend angepasst.
- (5) In Ergänzung zu § 17 Abs. 3 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 gilt:
Ob und in welchem Umfang der Versicherer zur Kostenübernahme (§ 1 Abs. 1 - 3) verpflichtet ist, ergibt sich aus der zuletzt gültigen Polizze.

Ergänzende Versicherungsbedingungen für die Option auf MedCare: Sonderklasse - Tarif SJVO (EB_SJVO_17)

Vertragspartner

Diese Vertragsgrundlagen gelten für Verträge mit der Generali Versicherung AG, 1010 Wien, Landskronergasse 1-3.

Aufsichtsbehörde

Finanzmarktaufsicht, 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5



§ 1

Option auf Sonderklasse - Tarfumstellung

(1) Inhalt der Option

1. Der Versicherungsnehmer ist bis zu dem in der Polizza angeführten Datum berechtigt, einmal
 - den Abschluss des Tarifes SJKV oder
 - die Erhöhung des gemeinsam mit Tarif SJVO versicherten Tarifes SJKV, SJMV oder SJR zu beantragen (Tarfumstellung).

Der Versicherungsnehmer kann dabei eine Tarfstufe des Tarifes SJKV, SJMV oder SJR bis zur Höhe der vereinbarten Tarfstufe des Tarifes SJVO wählen.

2. Der Versicherungsnehmer ist auch berechtigt, anstelle des Abschlusses des Tarifes SJKV oder der Erhöhung des Tarifes SJKV, SJMV oder SJR neuerlich eine Option in der bisher vereinbarten Höhe für einen weiteren Zeitraum von 10 Jahren - längstens bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres - zu beantragen.
Dieser Neuabschluss der Option erfolgt ohne Risikoprüfung mit jener Prämie, die dem Alter des Versicherten zum Zeitpunkt des neuerlichen Abschlusses entspricht.
3. Der Versicherer stellt die für ein Kind abgeschlossene Option wird mit dem auf dessen 18. Geburtstag folgenden Monatsersten auf einen Vertrag um
 - mit der Prämie, die der Tarif für Versicherte vorsieht, die mit diesem Alter in die Versicherung eintreten und
 - mit einer weiteren Laufzeit der Option von 10 Jahren.

Der Versicherer erstellt zu diesem Zweck eine neue Polizza mit der neuen Prämie und dem geänderten Datum des Ablaufs der Option.

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, die Option hinsichtlich des Versicherten binnen vier Wochen ab Erhalt der Benachrichtigung zum Wirksamkeitszeitpunkt der Änderung zu kündigen. Auf dieses Recht wird der Versicherer den Versicherungsnehmer in seiner Benachrichtigung ausdrücklich nochmals hinweisen.

(2) Zeitpunkt der Tarfumstellung

Der Versicherungsnehmer kann die Tarfumstellung jeweils zu einem Monatsersten mit einer Frist von 6 Monaten beantragen.

(3) Folgen der Tarfumstellung

Die Tarfumstellung erfolgt ohne neuerliche Risikoprüfung und ohne Wartezeiten für die höheren (neuen) Leistungen. Für die Bemessung der Prämie für die höheren (neuen) Leistungen ist das Alter des Versicherten zum Zeitpunkt der Tarfumstellung maßgebend.

Zum Zeitpunkt der Tarfumstellung in Kombination mit der Option versicherte Krankenhauskostentarife mit geringerem Versicherungsschutz werden durch den gewählten Tarif SJKV ersetzt.

Ein Krankenhauskostentarif weist einen geringeren Versicherungsschutz im Sinne dieser Bedingungen auf, wenn er

- lediglich eine Ausschnittsdeckung (z.B. Kostenersatz nur nach Unfall) oder
- gegenüber der Tarfstufe SJVO niedrigeren Kostenersatz bietet.

(4) Tarfumstellung durch den Versicherer

Wird die Tarfumstellung vom Versicherungsnehmer nicht bis zu dem in der Polizza angeführten Datum (siehe oben, Abs. 1 Pkt. 1) beantragt, erstellt der Versicherer eine **neue Polizza** mit den Leistungen und der Prämie der Tarfstufe des Tarifes SJKV, SJMV oder SJR die der in der Polizza vereinbarten Tarfstufe des Tarifes SJVO entsprechen. Der Versicherer schickt die Polizza dem Versicherungsnehmer vor dem in der Polizza angeführten Datum zu.

Spätestens 2 Monate vor Erstellung der Polizza wird der Versicherer den Versicherungsnehmer informieren über

- den Zeitpunkt der Umstellung
- die neue Höhe/Bezeichnung des Tarifes
- die neue Prämie
- die Gestaltungsmöglichkeiten inkl. Beratung durch Betreuerer

Innerhalb von 4 Wochen ab Erhalt der Polizze hat der Versicherungsnehmer das Recht,

- der Tarifumstellung zu widersprechen,
- eine Reduktion zu beantragen oder
- den neuerlichen Abschluss einer Option gemäß § 1, Abs. 1, Pkt. 2 zu beantragen.

Auf dieses Recht wird der Versicherer den Versicherungsnehmer bei Übermittlung der Polizze ausdrücklich nochmals hinweisen.

Lehnt der Versicherungsnehmer die Tarifumstellung ab, wird der Abschluss des Tarifes SJKV oder die Erhöhung des Tarifes SJKV, SJMV oder SJR rückgängig gemacht und die Option ist erloschen.

§ 2

Versicherungsschutz der künftigen Krankenhauskostenversicherung

Vertragsgrundlagen

für "MedCare: Sonderklasse" (Tarif SJKV) oder "MedCare: Smart Sonderklasse" (Tarif SJMV) oder "MedCare: Sonderklasse" (Tarif SJR) sind:

- Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeldversicherung (AVBKV 2017) bzw. Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Gruppenversicherung von Krankheitskosten und Krankenhaustagegeld (AVBKVG 2017);
- Ergänzende Versicherungsbedingungen für MedCare: Sonderklasse - Tarif SJKV oder MedCare: Smart Sonderklasse - Tarif SJMV oder MedCare: Sonderklasse - Tarif SJR;
- Leistungstarif für MedCare: Sonderklasse - Tarif SJKV oder MedCare: Smart Sonderklasse - Tarif SJMV oder MedCare: Sonderklasse - Tarif SJR;
- Österreichisches Recht.

Die Versicherungsbedingungen werden auf Verlangen übermittelt - ein diesbezügliches Ersuchen ist an die zuständige Regionaldirektion zu richten.

§ 3

Änderung der Prämie und des Versicherungsschutzes

Der Tarif SJVO unterliegt der Anpassung gemäß § 17 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017. Bei der Festsetzung der erforderlichen Anpassung werden dabei auch Änderungen der Faktoren gemäß § 17, Abs. 1, Pkt. a) - f) AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 im künftig versicherten Tarif SJKV, SJMV oder SJR berücksichtigt.

Ergänzende Versicherungsbedingungen für das Krankenhaus-Tagegeld - Tarif TJ (EB_TJ_17)

Vertragspartner

Diese Vertragsgrundlagen gelten für Verträge mit der Generali Versicherung AG, 1010 Wien, Landskronergasse 1-3.

Aufsichtsbehörde

Finanzmarktaufsicht, 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5



**§ 1
Krankenhaus- Tagesgeld**

- (1) Voraussetzung für die Leistung des Krankenhaus-Tagegeldes ist eine **stationäre Heilbehandlung** im Sinne des § 5 C) Abs. 10 AVBKV 2017 / AVBKG 2017.
- (2) Bei tagesklinischer Behandlung im Krankenhaus wird Krankenhaus- Tagesgeld wie für einen eintägigen Aufenthalt bezahlt.

Eine **tagesklinische Behandlung** liegt vor, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Art der Heilbehandlung erfordert üblicherweise einen Aufenthalt von mindestens 24 Stunden;
- der Versicherte wird noch am Tag der Aufnahme aus dem Krankenhaus entlassen, und
- für die Heilbehandlung wird die Infrastruktur einer Abteilung des Krankenhauses in Anspruch genommen (z.B. Aufnahme in der Bettenstation, Benutzung eines Operationssaales).

Heilbehandlung und Operationen in der Ambulanz eines Krankenhauses stellen jedenfalls keine tagesklinischen Behandlungen dar.

- (3) Bei einer **Entbindung** zu Hause oder bei einer Entbindung im Krankenhaus wird das Krankenhaus- Tagesgeld jedenfalls wie bei einer Aufenthaltsdauer von 6 Tagen bezahlt.
Bei längerer Aufenthaltsdauer wird pro Tag der vereinbarte Leistungsbetrag bezahlt.

**§ 2
Kostenersatz für Krankentransport**

Die nachgewiesenen Kosten des Transportes in das Krankenhaus und die nachgewiesenen Kosten des Heimtransportes per Krankenwagen, Bahn oder Autotaxi (§ 5 C) Abs. 13 AVBKV 2017 / AVBKG 2017) werden bei einem stationären oder tagesklinischen Aufenthalt in einem Krankenhaus und wenn eine Notfallversorgung nach einem Unfall in einem Krankenhaus erforderlich ist, erbracht.

**§ 3
Tagegeld bei Kur- und Rehabilitationsaufenthalten**

- (1) Diese Tarifleistung wird bezahlt, wenn ein Sozialversicherungsträger
- den Versicherten in ein Kurheim (auch Einrichtung für Psychosomatik und Zentrum für seelische Gesundheit) oder Rehabilitationszentrum (eigene oder Vertragseinrichtung) einweist bzw. den Aufenthalt bewilligt oder
 - einen Kurkostenzuschuss bewilligt.

Als Kurkostenzuschuss des Sozialversicherungsträgers ist ein Zuschuss zu den Kosten einer Kur außerhalb des Wohnortes anzusehen, nicht der Ersatz von Kurmittelkosten allein.

- (2) Diese Tarifleistung wird auch bezahlt, wenn Kuraufenthalt oder Rehabilitation vom Versicherer bewilligt wurden.

Voraussetzung für die Bewilligung ist, dass im Rahmen des Krankheitsgeschehens eine für die medizinisch indizierte Behandlung geeignete Einrichtung aufgesucht wird.

Der Antrag auf Erstattung der Kosten ist entsprechend medizinisch zu begründen. Der Versicherer kann vor Erledigung des Antrages auf seine Kosten die Untersuchung des Versicherten durch einen von ihm bestimmten Arzt verlangen. Er hat binnen 4 Wochen nach Eingang des Antrages oder des Untersuchungsergebnisses Stellung zu nehmen, ansonsten gilt der Antrag als bewilligt.

Für ambulant durchgeführte Kuren oder Rehabilitationen erfolgt keine Bewilligung.

- (3) Das Tagesgeld wird je Aufenthalt längstens
- bei Kuraufenthalt für 28 Tage,
 - bei Kuraufenthalt in einer Einrichtung für Psychosomatik und einem Zentrum für seelische Gesundheit für 42 Tage
 - bei Rehabilitationsaufenthalt für 42 Tage geleistet.

Leistungen gemäß Abs. 1 und 2 werden höchstens für 3 Aufenthalte in 6 Jahren erbracht.

§ 4

Tagegeld bei Akut-Geriatrie und Remobilisation

Für medizinisch notwendige stationäre Akut-Geriatrie und Remobilisation im Anschluss an eine stationäre Heilbehandlung wird das Tagesgeld bei Akut-Geriatrie und Remobilisation für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr geleistet.

§ 5

Tagegeld bei Aufenthalt in Hospiz oder Palliativstation

Für medizinisch notwendige stationäre Aufenthalte in einem Hospiz oder einer Palliativstation eines Krankenhauses wird das Tagesgeld bei Aufenthalt in Hospiz oder Palliativstation für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr erbracht.

§ 6

GesundheitsCoaching

(1) Informationen über medizinische Einrichtungen und Gesundheitsdienste

werden bei einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung zu folgenden Themen erteilt:

- Medizinische Einrichtungen weltweit,
- Krankenanstalten in Österreich (öffentlich, privat),
- Transporteinrichtungen in Österreich.

1. Informationen über medizinische Einrichtungen außerhalb Österreichs

werden erteilt, wenn für die spezielle medizinische Behandlung kein geeigneter Arzt bzw. keine geeignete medizinische Einrichtung in Österreich vorhanden oder ärztliche Hilfe während eines Auslandsaufenthaltes erforderlich ist.

2. Informationen über Transporteinrichtungen in Österreich

werden erteilt, wenn der Versicherte aufgrund der Art der Erkrankung bzw. durch die Unfallfolgen oder wegen der ärztlich angeordneten Verhaltensmaßnahmen außerstande ist, den Arzt oder die medizinische Einrichtung aus eigener Kraft aufzusuchen.

(2) Hilfe im Notfall

Ein medizinischer Notfall liegt vor, wenn der Versicherte von einer unmittelbaren Gefahr (z.B. akute Erkrankung, Unfall, drohende Einwirkung schädigender Stoffe) für Leben, körperliche Unversehrtheit oder Gesundheit bedroht ist.

In allen medizinischen Notfällen ist der Versicherer rund um die Uhr erreichbar und

- unterstützt durch Herstellung der Verbindung und Organisation des Transports zu allen Notfalleinrichtungen in Österreich:
 - Nacht- und Wochenenddienste durch Ärzte für Allgemeinmedizin und Zahnärzte bzw. Apotheken, nächstgelegenes geeignetes Krankenhaus,
 - sonstige Notdienste (z.B. Rotes Kreuz, Vergiftungszentrale, psychosoziale Dienste)

oder

- veranlasst - abhängig vom Gesundheitszustand des Versicherten - einen zeitnahen Rückruf von einem Arzt zur telefonischen Abklärung und Beratung über weitere Maßnahmen.

(3) Herstellung der Verbindung

erfolgt nur auf Wunsch des Versicherten.

Der Versicherer stellt nur den erstmaligen Kontakt her, in weiterer Folge wendet sich der Versicherte selbst an den Arzt/Therapeuten, die medizinische Einrichtung oder den Gesundheitsdienst.

(4) Haftungsausschluss

Durch die Informationsleistung bzw. Herstellung der Verbindung gewährleistet der Versicherer nicht die Verfügbarkeit der Leistungen des betreffenden Arztes/Therapeuten, der medizinischen Einrichtung oder des Gesundheitsdienstes in einem bestimmten Umfang oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes.

(5) Nachweis der Anspruchsvoraussetzungen

Außer bei "Hilfe im Notfall" kann der Versicherer verlangen, dass der Versicherte die Anspruchsvoraussetzungen der oben angeführten Leistungen durch entsprechende medizinische Unterlagen (ärztliche Befunde, Rezepte für Arzneien, etc.) nachweist.

§ 7

Änderung der Prämie und des Versicherungsschutzes

(1) Der Tarif TJ unterliegt der Anpassung gemäß § 17 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017.

Indexvereinbarung

(2) Der für Änderungen der Prämie oder des Versicherungsschutzes gemäß § 178f Abs 2 Z 1 VersVG maßgebliche Index ist der von der Bundesanstalt "Statistik Österreich" (FN 191155k) veröffentlichte Verbraucherpreisindex VPI 2010 oder, wenn dieser Index nicht mehr veröffentlicht wird, der an dessen Stelle tretende Index ("VPI").

(3) Der Versicherer ist berechtigt, die Leistungen gemäß dem VPI (siehe oben Abs. 2) und, aus Anlass einer Leistungsänderung auch die Prämie, wie folgt zu ändern:

1. Der Tarif TJ ist ein sogenannter Stufentarif mit Grundtarifstufe 1.
Die Leistungen der Grundtarifstufe sind unabhängig vom Lebensalter des Versicherten gleich hoch. Die Höhe der Prämie für die Grundtarifstufe ist je nach Alter des Versicherten zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses unterschiedlich.
Die Höhe der in der Polizza konkret vereinbarten Tarifleistungen wird durch die Anzahl der versicherten Grundtarifstufen bestimmt.
2. Ausgangsbasis ist die Indexzahl für Juli des Kalenderjahres, das dem Vertragsabschluss oder der letzten Vertragsänderung (worunter Indexanpassungen und andere Änderungen der Leistung zu verstehen sind) vorangegangen ist.
3. Der Versicherer ermittelt Indexänderungen vor Ablauf eines jeden Kalenderjahres für das nächste Kalenderjahr. Vergleichswert ist die für Juli des aktuellen Kalenderjahres veröffentlichte Indexzahl.
Eine Anpassung aufgrund einer Indexveränderung erfolgt frühestens nach Ablauf eines Jahres nach Vertragsabschluss oder der letzten Vertragsänderung.
4. Der Faktor, um den der Vergleichswert höher oder niedriger als die Ausgangsbasis ist, wird mit der Anzahl der Grundtarifstufen, die jeweils aktuell versichert sind, multipliziert.
5. Ist das Ergebnis um eine oder mehr Grundtarifstufen höher oder niedriger als die aktuelle Anzahl der Grundtarifstufen, dann wird die Anzahl der Grundtarifstufen um diese Differenz - kaufmännisch gerundet auf die nächste ganze Zahl an Grundtarifstufen - erhöht oder vermindert.
Ergibt die Indexveränderung eine Differenz von weniger als einer Grundtarifstufe, so wird sie auf den nächsten Vergleichszeitraum vorgetragen und bei einer späteren Indexanpassung berücksichtigt.
6. Die Prämie für die zusätzlichen oder in Abzug zu bringenden Grundtarifstufen wird mit dem aktuellen Alter des Versicherten zum Zeitpunkt der Anpassung berechnet.
- (4) Daraus resultierende Änderungen der Prämie und des Versicherungsschutzes wird der Versicherer dem Versicherungsnehmer vor Ablauf des Kalenderjahres zusenden. Sie wirken gemäß § 178f Abs 4 VersVG ab dem dieser Absendung folgenden Monatsersten, dh ab dem 1. Jänner des Folgejahres.
- (5) Wenn der Versicherungsnehmer mit der zugesandten Änderung nicht einverstanden ist, kann er das dem Versicherer bis 31. Jänner des Folgejahres mitteilen. Dann findet die Änderung für den Vertrag nicht statt. Auf dieses Recht wird der Versicherer den Versicherungsnehmer in der Verständigung von der Änderung der Prämie und des Versicherungsschutzes gesondert hinweisen.
- (6) Beispiele zur oben beschriebenen Indexanpassung sind auf der Homepage www.general.at veröffentlicht.

Ergänzende Versicherungsbedingungen für MedCare: Sonderklasse nach Unfall und MedCare: Sonderklasse nach Unfall und Krankenhaus-Tagegeld - Tarife SHU und STHU (EB_SHU_STHU_17)

Vertragspartner

Diese Vertragsgrundlagen gelten für Verträge mit der Generali Versicherung AG, 1010 Wien, Landskrongasse 1-3.

Aufsichtsbehörde

Finanzmarktaufsicht, 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5



§ 1

Dauer der Versicherungsleistungen

Alle Leistungen nach Unfall (ausgenommen "Tagegeld bei Rehabilitation oder Anschlussheilverfahren") werden bezahlt, wenn sie innerhalb von 2 Jahren ab dem Unfalltag im Versicherungszeitraum entstanden sind.

§ 2

Umfang der Versicherungsleistungen

(1) Leistung nach Unfall (siehe auch § 1 Abs. 5 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017)

1. Ein **Unfall** liegt vor, wenn der Versicherte durch ein plötzlich von außen auf seinen Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.
2. Als Unfall gelten auch:
 - a) **Zerreißungen** von an Gliedmaßen und an der Wirbelsäule befindlichen Muskeln, Sehnen, Bändern und Kapseln sowie Meniskusverletzungen infolge plötzlicher Abweichung vom geplanten Bewegungsablauf, wenn sie innerhalb von 7 Tagen ab dem Ereignistag medizinisch dokumentiert und ärztlich behandelt wurden.
 - b) **Bandscheibenhernien**, wenn sie durch eine plötzliche, erhebliche direkte Gewalteinwirkung auf das jeweilige Segment der Wirbelsäule verursacht werden, und
 - diese durch Kraft und Richtung in der Lage war, eine gesunde Bandscheibe zu zerreißen, die bildgebende Untersuchung nach dem Unfall (wie MRT, Röntgen) keine degenerativen Veränderungen zeigt und vor dem Unfall keine Wirbelsäulenbeschwerden bestanden; oder
 - Frakturen ober- oder unterhalb der geschädigten Bandscheibe vorliegen; oder
 - es zu Bänderrissen im Bereich der Wirbelsäule mit Wirbelverrenkungen gekommen ist.
 - c) **Bauch- und Unterleibsbrüche**, wenn sie durch eine plötzlich von außen kommende mechanische Einwirkung direkt herbeigeführt worden sind und nicht anlagenbedingt waren.
3. Fehl- und Frühgeburten, die durch einen Unfall herbeigeführt worden sind, gelten nicht als Unfallfolgen. Unfälle als Folgen einer Krankheit sind im Sinne dieser Versicherungsbedingungen Krankheiten.

(2) Leistung nach Krankheit

Tarif SHU: Im Falle einer Krankheit werden keine Leistungen erbracht.

Tarif STHU: Im Falle einer Krankheit wird Krankenhaus-Tagegeld bezahlt (§ 9 Abs. 1).

(3) Leistung bei Schwangerschaft und Entbindung

Tarif SHU: Für Entbindungen sowie die mit der Schwangerschaft im Zusammenhang stehende medizinisch notwendige Heilbehandlung werden keine Leistungen erbracht.

Tarif STHU: Bei einer Entbindung wird Tagegeld bei Entbindung bezahlt (§ 9 Abs. 3).

§ 3

Kostenübernahme nach Unfall

(1) Kostenübernahme in Vertragskrankenhäusern in Österreich laut Krankenhausverzeichnis

Nimmt der Versicherte ein Zweibettzimmer in der Sonderklasse eines Vertragskrankenhauses in Österreich in Anspruch, so werden die vereinbarten Kosten einschließlich der ärztlichen Honorare anstelle der tariflichen Leistungen in voller Höhe übernommen und mit dem Krankenhaus direkt verrechnet.

(2) Kostenübernahme in Europa laut Krankenhausverzeichnis (Europaliste)

Nimmt der Versicherte ein Mehrbettzimmer in der Sonderklasse eines allgemeinen öffentlichen Krankenhauses im europäischen Ausland (lt. Europaliste) in Anspruch, so werden die Kosten der Pflege und Verpflegung, von Operationen und Behandlung einschließlich der ärztlichen Honorare anstelle der tariflichen Leistungen in voller Höhe übernommen.

(3) Weltweite Kostenübernahme laut Krankenhausverzeichnis

Nimmt der Versicherte ein Mehrbettzimmer in der Sonderklasse eines allgemeinen öffentlichen Krankenhauses außerhalb Österreichs und Europas (lt. Europoliste) in Anspruch, so werden die Kosten der Pflege und Verpflegung, von Operationen und Behandlung einschließlich der ärztlichen Honorare anstelle der tariflichen Leistungen in voller Höhe übernommen, wenn

- a) die Behandlung in Österreich gleichwertig nicht durchgeführt werden kann, diese ärztlich empfohlen wurde und der Versicherer vorher eine Kostenübernahmeerklärung abgegeben hat. Der Versicherer gibt eine Kostenübernahmeerklärung ab, wenn er über die geplante Behandlung informiert wurde und dadurch Gelegenheit hatte, vor Beginn der Behandlung mit dem betreffenden Krankenhaus über die Höhe der Kosten Einvernehmen herzustellen.
- b) wegen eines Unfalles während eines Aufenthaltes mit einer geplanten Dauer von bis zu 6 Wochen in diesen Ländern eine Heilbehandlung medizinisch notwendig ist und eine Rückkehr nach Österreich aus medizinischen Gründen nicht möglich ist.

Bei Kostenübernahme gemäß Pkt. a) wird der für "Kosten des Transportes ins Krankenhaus" festgesetzte Betrag verdoppelt.

(4) Krankenhausverzeichnis – Europoliste

Die Vertragskrankenhäuser und die Europoliste sind im Krankenhausverzeichnis enthalten. Änderungen in diesem Verzeichnis werden dem Versicherungsnehmer in geschriebener Form bekanntgegeben und treten mit Zugang der Verständigung in Kraft. Der Versicherungsnehmer ist gesondert darauf hinzuweisen, wenn der Versicherer überhaupt keine Vertragskrankenhäuser mehr hat, sodass die volle Kostenübernahme gegenstandslos geworden ist.

Diese allgemeine Kostendeckungszusage kann im Sinn des § 178 c VersVG vom Versicherer in geschriebener Form widerrufen werden. Der Widerruf wird nach Ablauf von drei Wochen wirksam.

(5) Gesetzliche Krankenversicherung

Abhängig vom Schutz des Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung erfolgt die Kostenübernahme unter der Voraussetzung der Erbringung der nachstehenden Leistungen durch Krankenversicherungsträger. Ohne Leistung eines Krankenversicherungsträgers werden die Kosten des Krankenhausaufenthalts bis zu den in der Polizze angeführten tariflichen Höchstbeträgen ersetzt:

1. Für gesetzlich Krankenversicherte nach ASVG (ÖGK, usw.), BSVG (SVS - Bauern) und GSVG-Sachleistungsgruppe (SVS - Selbständige):
Der Krankenversicherungsträger erbringt eine Leistung für die Kosten der allgemeinen Gebührenklasse.
2. Für gesetzlich Krankenversicherte nach B-KUVG (BVAEB - Beamte):
Der Krankenversicherungsträger erbringt eine Leistung für die Kosten der allgemeinen Gebührenklasse und für einen Teil der Pflege- und/oder Sondergebühren einschließlich der Arzthonorare der Sonderklasse.
3. Für gesetzlich Krankenversicherte nach GSVG-Geldleistungsgruppe (SVS - Selbständige):
Der Krankenversicherungsträger erbringt eine Leistung für die Kosten der allgemeinen Gebührenklasse und für einen Teil der Pflege- und/oder Sondergebühren einschließlich der Arzthonorare der Sonderklasse.
4. Für Anspruchsberechtigte nach den Gemeinschaftsbestimmungen über die soziale Sicherheit in der Europäischen Union (EU):
Der Versicherte ist aufgrund der Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und Nr. 988/2009 für stationäre Heilbehandlung von Unfallfolgen in Österreich sachleistungsberechtigt und der Krankenversicherungsträger erbringt für den konkreten Krankenhausaufenthalt eine Leistung für die Kosten der allgemeinen Gebührenklasse.

(6) Entfall der gesetzlichen Krankenversicherung

Die Tarife SHU und STHU setzen voraus, dass der Versicherte gegenüber einem Träger der gesetzlichen Krankenversicherung anspruchsberechtigt ist.

Endet die Anspruchsberechtigung des Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung,

- entfällt der Versicherungsschutz für die Kostenübernahme nach Unfällen und
- die Kosten von Krankenhausaufenthalten werden bis zu den in der Polizze angeführten tariflichen Höchstbeträgen ersetzt (siehe oben Abs. 5).

Der Versicherungsnehmer kann den Tarif hinsichtlich des Versicherten mit sofortiger Wirkung kündigen.

§ 4

Direktverrechnung

Sofern eine Vereinbarung mit dem Leistungsträger (Krankenanstalt/Arzt) besteht, erfolgt auf Grundlage dieser Vereinbarung die direkte Verrechnung der Kosten und Honorare zwischen dem Versicherer und dem Leistungserbringer.

Weitere Grundlage ist eine vom Versicherten vor Antritt der stationären Heilbehandlung anzufordernde Kostenübernahmeerklärung. Die Art der Unfallfolgen und die Notwendigkeit der stationären Heilbehandlung sind in dieser Anforderung medizinisch nachzuweisen. Lässt die Dringlichkeit der Heilbehandlung eine vorübergehende Anfrage nicht zu, ist diese spätestens drei Arbeitstage ab Antritt der Heilbehandlung nachzureichen.

Der Versicherte hat der Ermittlung von zum Zwecke der Direktverrechnung erforderlichen Daten zuzustimmen. Wird die Zustimmungserklärung verweigert, widerrufen oder verspätet erteilt und stellt der Leistungserbringer Kosten und Honorare dem Versicherten in Rechnung, ist der Versicherer diesem gegenüber nur in dem in der Vereinbarung über die Direktverrechnung festgelegten Ausmaß zur Leistung verpflichtet.

§ 5

Tagesklinische Behandlung in Krankenhäusern nach Unfall

Tagesklinische Heilbehandlungen sind Heilbehandlungen in einem Krankenhaus, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Art der Heilbehandlung erfordert üblicherweise einen Aufenthalt von mindestens 24 Stunden,
- der Versicherte wird noch am Tag der Aufnahme aus dem Krankenhaus entlassen, und
- für die Heilbehandlung wird die Infrastruktur einer Abteilung des Krankenhauses in Anspruch genommen (z.B. Aufnahme in der Bettenstation, Benutzung eines Operationssaales).

Heilbehandlungen und Operationen in der Ambulanz eines Krankenhauses stellen jedenfalls keine tagesklinischen Behandlungen dar.

§ 6

Ambulante Operationen in Krankenhäusern nach Unfall

- (1) Ambulante Operationen sind
- medizinisch notwendige operative Eingriffe ab Operationsgruppe 3,
 - die üblicherweise einen Aufenthalt von mindestens 24 Stunden erfordern und
 - in Krankenhäusern oder tagesklinischen Einrichtungen, die sowohl rechtlich, wirtschaftlich als auch organisatorisch an ein bettenführendes Krankenhaus angegliedert sind, durchgeführt werden.

Das für die Einstufung eines Eingriffs maßgebliche Operationsgruppenschema kann auf der Homepage des Versicherers unter folgendem Link eingesehen werden:

<https://www.generali.at/service/krankenversicherung-operationsgruppenschema.html>

Für ambulante Operationen in selbstständigen Tageskliniken oder in Ordinationen niedergelassener Fachärzte werden keine Leistungen erbracht.

- (2) Der Versicherer ersetzt die Kosten einer ambulanten Operation, sofern der Versicherte diese zuvor bei seinem Sozialversicherungsträger im Wege der Voreinreichung geltend gemacht hat. Der Versicherer leistet Kostenersatz abzüglich der Leistung des Sozialversicherungsträgers.

§ 7

Remobilisation

Für unfallbedingt medizinisch notwendige stationäre Remobilisation im Anschluss an eine stationäre Heilbehandlung aufgrund eines Unfalles wird eine Leistung für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr erbracht.

Erfolgt die Remobilisation in einem Krankenhaus (Abteilung), mit dem der Versicherer dafür einen Vertrag abgeschlossen hat, werden die vereinbarten Kosten mit dem Vertragskrankenhaus gemäß § 4 direkt verrechnet. In allen übrigen Fällen wird das dafür im Leistungstarif angeführte Ersatztagegeld ausbezahlt.

§ 8

Tarifliche Leistungen nach Unfall

(1) Stationäre Heilbehandlung in Krankenhäusern

Bei stationärer Heilbehandlung in Krankenhäusern, die im Krankenhausverzeichnis nicht enthalten sind, werden für die Kosten des Aufenthaltes die Leistungen gemäß der für

- Tageskosten,
 - Behandlungshonorar,
 - Technische Leistungen, und
 - Summenleistung
- festgesetzten Beträgen erbracht.

(2) Tagesklinische Behandlung in Krankenhäusern

Für tagesklinische Heilbehandlungen in Krankenhäusern, mit denen dafür keine vertraglichen Vereinbarungen über die Kostenübernahme bestehen, werden für die Kosten die folgenden tariflichen Leistungen wie für eine eintägige stationäre Heilbehandlung erbracht:

- Tageskosten,
- Behandlungshonorar,
- Technische Leistungen und
- Summenleistung.

(3) Ambulante Operationen in Krankenhäusern

Für ambulante Operationen in Krankenhäusern oder an diese angegliederten tagesklinischen Einrichtungen, mit denen dafür keine vertraglichen Vereinbarungen über die Kostenübernahme bestehen, wird das tarifliche Behandlungshonorar für die betreffende Operationsgruppe bezahlt.

(4) Tageskosten

umfassen die zu bezahlenden Kosten für Verpflegungs- und Krankenhausgebühren (für die Unterbringung, Pflege und Verpflegung).

(5) Behandlungshonorar

umfasst alle ärztlichen Honorare ausgenommen die Honorare für technische Untersuchungen wie bildgebende Verfahren, Labor, Nuklearmedizin etc.

Soweit Kosten aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Vereinbarungen mit dem Versicherer betraglich geregelt sind, ist der Versicherer zum Ersatz darüber hinausgehender Kosten (z.B. Sonderhonorare der Vorstände von Universitätskliniken gemäß § 46 KaKuG und ausführende Landesgesetze) nicht verpflichtet.

(6) Technische Leistungen

umfassen die Honorare für technische Untersuchungen wie bildgebende Verfahren, Labor, Nuklearmedizin etc. und sämtlichen Sachaufwand einschließlich der Kosten für Benützung des Operationssaales, der Arzneimittel (Heilmittel) und Heilbehelfe (abweichend von § 5 A) Abs. 1, 2 und 4 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017).

(7) Ersatztagegeld

wird anstelle des Kostenersatzes für stationäre Heilbehandlung (Kostenübernahme oder tariflich: Tageskosten, Behandlungshonorar, Technische Leistungen, Summenleistung) bezahlt.

(8) Aufenthaltskosten der Begleitperson

werden zusätzlich zum Kostensatz für stationäre Heilbehandlung (Kostenübernahme oder tariflich: Tageskosten, Behandlungshonorar, Technische Leistungen, Summenleistung) oder Ersatztagegeld bezahlt.

(9) **Kosten des Transportes ins Krankenhaus**

inkl. Bergungskosten und Hubschraubertransport werden zusätzlich zum Kostenersatz für stationäre Heilbehandlung bezahlt.

(10) **Das Tagegeld bei Rehabilitation und Anschlussheilverfahren nach Unfall** wird bezahlt

- bei Rehabilitation in Rehabilitationszentren,
- bei Anschlussheilverfahren (Nachbehandlungen in ursächlichem Zusammenhang mit einer vorangehenden Primärbehandlung in einer Krankenanstalt) in Sonderheilanstalten.

Diese Leistung wird je Aufenthalt längstens für 42 Tage erbracht.

Die nachfolgende Bestimmung des § 9 gilt nur bei Tarif STHU:

§ 9

Tarifliche Leistungen bei Krankheit und Entbindung

(1) **Krankenhaus-Tagegeld**

Voraussetzung für die Leistung des Krankenhaus-Tagegeldes ist eine stationäre Heilbehandlung im Sinne des § 5 C) Abs. 10 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017.

Bei tagesklinischer Behandlung im Krankenhaus wird Krankenhaus-Tagegeld wie für einen eintägigen Aufenthalt bezahlt.

Eine tagesklinische Behandlung liegt vor, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Art der Heilbehandlung erfordert üblicherweise einen Aufenthalt von mindestens 24 Stunden,
- der Versicherte wird noch am Tag der Aufnahme aus dem Krankenhaus entlassen, und
- für die Heilbehandlung wird die Infrastruktur einer Abteilung des Krankenhauses in Anspruch genommen (z.B. Aufnahme in der Bettenstation, Benutzung eines Operationssaales).

Heilbehandlungen und Operationen in der Ambulanz eines Krankenhauses stellen jedenfalls keine tagesklinischen Behandlungen dar.

(2) **Aufenthaltskosten der Begleitperson**

werden zusätzlich zum Kostensatz für stationäre Heilbehandlung (Kostenübernahme oder tariflich: Tageskosten, Behandlungshonorar, Technische Leistungen, Summenleistung) oder Ersatztagegeld bezahlt.

(3) **Tagegeld bei Entbindung**

wird bei einer Entbindung zu Hause oder bei einer Entbindung im Krankenhaus jedenfalls wie bei einer Aufenthaltsdauer von 6 Tagen bezahlt.

Bei längerer Aufenthaltsdauer wird pro Tag der vereinbarte Leistungsbetrag bezahlt.

(4) **Tagegeld bei Kuraufenthalten**

wird bezahlt, wenn ein Sozialversicherungsträger

- den Versicherten in ein Kurheim (auch Einrichtung für Psychosomatik und Zentrum für seelische Gesundheit) einweist bzw. den Aufenthalt bewilligt oder
- einen Kurkostenzuschuss bewilligt.

Als Kurkostenzuschuss des Sozialversicherungsträgers ist ein Zuschuss zu den Kosten einer Kur außerhalb des Wohnortes anzusehen, nicht der Ersatz von Kurmittelkosten allein.

Diese Tarifleistung wird auch bezahlt, wenn der Kuraufenthalt vom Versicherer bewilligt wurde.

Voraussetzung für die Bewilligung ist, dass im Rahmen des Krankheitsgeschehens eine für die medizinisch indizierte Behandlung geeignete Einrichtung aufgesucht wird.

Der Antrag auf Erstattung der Kosten ist entsprechend medizinisch zu begründen. Der Versicherer kann vor Erledigung des Antrages auf seine Kosten die Untersuchung des Versicherten durch einen von ihm bestimmten Arzt verlangen. Er hat binnen 4 Wochen nach Eingang des Antrages oder des Untersuchungsergebnisses Stellung zu nehmen, ansonsten gilt der Antrag als bewilligt.

Für ambulant durchgeführte Kuren erfolgt keine Bewilligung.

Das Tagegeld wird je Aufenthalt längstens

- bei Kuraufenthalt für 28 Tage;

- bei Kuraufenthalt in einer Einrichtung für Psychosomatik und einem Zentrum für seelische Gesundheit für 42 Tage und höchstens für 3 Aufenthalte in 6 Jahren geleistet.

(5) Tagegeld bei Rehabilitationsaufenthalten

wird bezahlt, wenn ein Sozialversicherungsträger den Versicherten in ein Rehabilitationszentrum (eigene oder Vertragseinrichtung) einweist bzw. den Aufenthalt bewilligt.

Diese Tarifleistung wird auch bezahlt, wenn die Rehabilitation vom Versicherer bewilligt wurde.

Voraussetzung für die Bewilligung ist, dass im Rahmen des Krankheitsgeschehens eine für die medizinisch indizierte Behandlung geeignete Einrichtung aufgesucht wird.

Der Antrag auf Erstattung der Kosten ist entsprechend medizinisch zu begründen. Der Versicherer kann vor Erledigung des Antrages auf seine Kosten die Untersuchung des Versicherten durch einen von ihm bestimmten Arzt verlangen. Er hat binnen 4 Wochen nach Eingang des Antrages oder des Untersuchungsergebnisses Stellung zu nehmen, ansonsten gilt der Antrag als bewilligt.

Das Tagegeld wird je Rehabilitationsaufenthalt für längstens 42 Tage und höchstens für 3 Aufenthalte in 6 Jahren geleistet.

(6) Tagegeld bei Akutgeriatrie und Remobilisation

wird bei medizinisch notwendiger stationärer Akut-Geriatrie und Remobilisation im Anschluss an eine stationäre Heilbehandlung für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr bezahlt.

(7) Tagegeld bei Aufenthalt in Hospiz oder Palliativstation

wird bei medizinisch notwendigen stationären Aufenthalten in einem Hospiz oder einer Palliativstation eines Krankenhauses für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr bezahlt.

§ 10

GesundheitsCoaching

(1) Informationen über medizinische Einrichtungen und Gesundheitsdienste

werden bei einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung aufgrund eines Unfalles zu folgenden Themen erteilt:

- Medizinische Einrichtungen weltweit,
- Krankenanstalten in Österreich (öffentlich, privat),
- Transporteinrichtungen in Österreich.

1. Informationen über medizinische Einrichtungen außerhalb Österreichs

werden erteilt, wenn für die spezielle medizinische Behandlung kein geeigneter Arzt bzw. keine geeignete medizinische Einrichtung in Österreich vorhanden oder ärztliche Hilfe während eines Auslandsaufenthaltes erforderlich ist.

2. Informationen über Transporteinrichtungen in Österreich

werden erteilt, wenn der Versicherte aufgrund der Art der Erkrankung bzw. durch die Unfallfolgen oder wegen der ärztlich angeordneten Verhaltensmaßregeln außerstande ist, den Arzt oder die medizinische Einrichtung aus eigener Kraft aufzusuchen.

(2) Hilfe im Notfall

Ein medizinischer Notfall liegt vor, wenn der Versicherte von einer unmittelbaren Gefahr (z.B. akute Erkrankung, Unfall, drohende Einwirkung schädigender Stoffe) für Leben, körperliche Unversehrtheit oder Gesundheit bedroht ist.

In allen medizinischen Notfällen ist der Versicherer rund um die Uhr erreichbar und

- unterstützt durch Herstellung der Verbindung und Organisation des Transports zu allen Notfalleinrichtungen in Österreich:
 - Nacht- und Wochenenddienste durch Ärzte für Allgemeinmedizin und Zahnärzte bzw. Apotheken, nächstgelegenes geeignetes Krankenhaus,
 - sonstige Notdienste (z.B. Rotes Kreuz, Vergiftungszentrale, psychosoziale Dienste)

oder

- veranlasst - abhängig vom Gesundheitszustand des Versicherten - einen zeitnahen Rückruf von einem Arzt zur telefonischen Abklärung und Beratung über weitere Maßnahmen.

(3) Bester Arzt, bester Therapeut

Bei einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung aufgrund eines Unfalles unterstützt der Versicherer den Versicherten bei der Suche nach dem hinsichtlich

- des konkreten Beschwerdebildes am besten geeigneten Arzt, bzw.
- der ärztlich empfohlenen Maßnahmen am besten geeigneten Therapeuten.

(4) **Ärztliche Zweitmeinung (Second Opinion)**

Bei einer notwendigen medizinischen Heilbehandlung von Unfallfolgen nennt der Versicherer auf Wunsch des Versicherten einen Spezialisten, wenn eine Therapie bzw. ein Eingriff von einem Arzt bereits geplant ist.

(5) **Herstellung der Verbindung**

erfolgt nur auf Wunsch des Versicherten.

Der Versicherer stellt nur den erstmaligen Kontakt her, in weiterer Folge wendet sich der Versicherte selbst an den Arzt/Therapeuten, die medizinische Einrichtung oder den Gesundheitsdienst.

(6) **Haftungsausschluss**

Durch die Informationsleistung bzw. Herstellung der Verbindung gewährleistet der Versicherer nicht die Verfügbarkeit der Leistungen des betreffenden Arztes/Therapeuten, der medizinischen Einrichtung oder des Gesundheitsdienstes in einem bestimmten Umfang oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes.

(7) **Leistungen des persönlichen GesundheitsCoaches**

werden für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten ab Beginn einer medizinisch notwendigen stationären Heilbehandlung von Unfallfolgen durch dafür qualifizierte Mitarbeiter eines Vertragspartners des Versicherers erbracht. Der Versicherer trägt die Kosten der Begleitung und Unterstützung durch den persönlichen GesundheitsCoach, leistet jedoch keinen Kostenersatz für von diesem erarbeitete oder vorgeschlagene Maßnahmen (z.B. Kosten gesünderer Lebensmittel oder eines Fitnesstrainings).

(8) **Nachweis der Anspruchsvoraussetzungen**

Außer bei "Hilfe im Notfall" kann der Versicherer verlangen, dass der Versicherte die Anspruchsvoraussetzungen der oben angeführten Leistungen durch entsprechende medizinische Unterlagen (ärztliche Befunde, Rezepte für Arzneien, etc.) nachweist.

§ 11

Änderung der Prämie und des Versicherungsschutzes

- (1) Die Tarife SHU und STHU unterliegen der Anpassung gemäß § 17 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017.
- (2) In Ergänzung zu § 17 Abs. 1 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 gilt:
Kann in einem Bundesland über die Höhe der Krankenhauskosten und Honorare kein Einvernehmen hergestellt werden, wird der Anpassung die jeweilige Veränderung des von Statistik Austria verlautbarten Index der Verbraucherpreise zugrundegelegt.
- (3) In Ergänzung zu § 17 Abs. 3 AVBKV 2017 / AVBKVG 2017 gilt:
Ob und in welchem Umfang der Versicherer zur Kostenübernahme (§ 3 Abs. 1 - 3) verpflichtet ist, ergibt sich aus der zuletzt gültigen Police.

Ergänzende Versicherungsbedingungen für MedCare4Business: Vorsorge - Tarif 2VJ (EB_2VJK)

Vertragspartner

Diese Vertragsgrundlagen gelten für Verträge mit der Generali Versicherung AG, 1010 Wien, Landskrongasse 1-3.

Aufsichtsbehörde

Finanzmarktaufsicht, 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5



§ 1

Vorsorgeuntersuchung

- (1) Die tariflichen Leistungen können jeweils einmal in zwei Kalenderjahren in Anspruch genommen werden. Dieser Zeitraum wird nach dem Beginn jenes Kalenderjahres ermittelt, in das der Vertragsbeginn (§ 3 AVBKVK 2020) fällt.
Eine Leistung, die nicht innerhalb des oben angeführten Zeitraums durchgeführt wurde, kann in der nächsten Periode nicht mehr konsumiert werden.
- (2) Der tariflich vorgesehene Kostenersatz für eine Vorsorgeuntersuchung umfasst die Kosten der Untersuchung durch einen praktischen Arzt oder Facharzt einschließlich der Kosten von Röntgen- und Laboruntersuchungen. Vorsorgeuntersuchungen sind Untersuchungen zur Früherkennung chronischer Erkrankungen, wie z.B. maligner Prozesse, Erkrankungen des Herzens und des Kreislaufes oder des Stoffwechsels unter Anwendung von nach dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Wissenschaft zweckmäßigen und ausreichenden Maßnahmen.
- Ebenfalls als Vorsorgeuntersuchung anzusehen ist die einmalige Feststellung der für die erste Hilfe nach akuten Erkrankungen oder Unfällen bzw. zur Schockbekämpfung wesentlichen Daten, wie Blutgruppe, Rhesusfaktor, Allergien usw.
Nicht als Vorsorgeuntersuchung gelten Schwangerschaftstests.

§ 2

Information über Vorsorgeuntersuchungen

- (1) Bei Anspruch auf eine Vorsorgeuntersuchung (§ 1, Abs. 2) unterstützt der Versicherer bei der Suche nach dem für das medizinische Fachgebiet der Untersuchung am besten geeigneten Arzt.
Darüber hinaus informiert der Versicherer über
- Inhalte und Methoden medizinisch empfohlener Vorsorgeuntersuchungen;
 - Ärzte in der Nähe des Wohnorts des Versicherten, die Vorsorgeuntersuchungen durchführen.
- (2) **Herstellung der Verbindung**
erfolgt nur auf Wunsch des Versicherten. Der Versicherer stellt nur den erstmaligen Kontakt her, in weiterer Folge wendet sich der Versicherte selbst an den Arzt.
- (3) **Haftungsausschluss**
Durch die Informationsleistung bzw. Herstellung der Verbindung gewährleistet der Versicherer nicht die Verfügbarkeit der Leistungen des betreffenden Arztes in einem bestimmten Umfang oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes.

§ 3

Änderung der Prämie und des Versicherungsschutzes

Der Tarif 2VJ unterliegt der Anpassung gemäß § 17 AVBKVK 2020.